

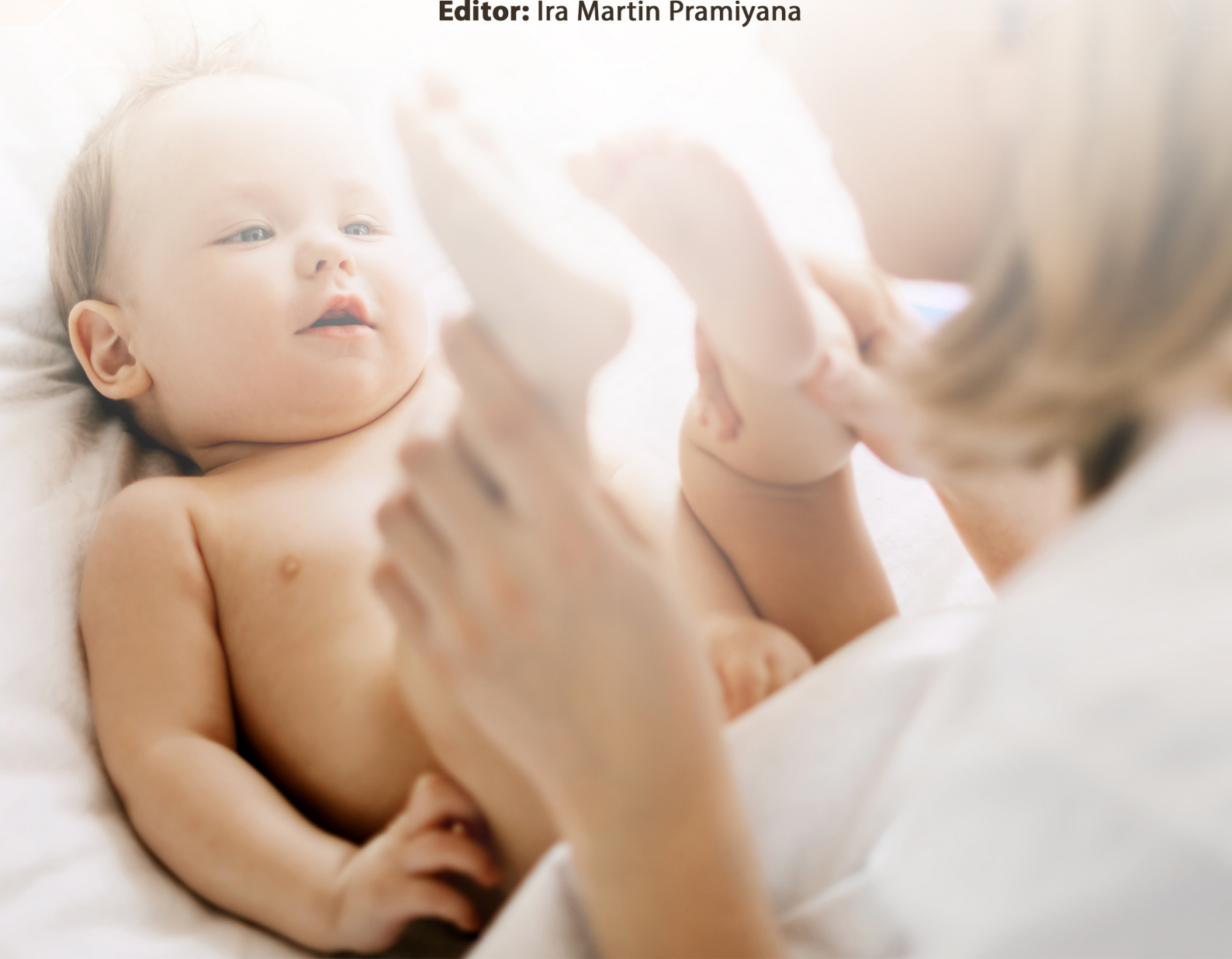
Bunga Rampai

ASUHAN KEBIDANAN PASCAPERSALINAN

**PERSPEKTIF MODERN DALAM DUKUNGAN ASI EKSKLUSIF
DAN PENCEGAHAN DEPRESI POSTPARTUM**

Dewi Mayangsari • Rolita Efriani • Ririn Ratnasari
Handayani • Putu Lusita Nati Indriani • Erma Puspita Sari
Nur Hidayati

Editor: Ira Martin Pramiyana



BUNGA RAMPAI
ASUHAN KEBIDANAN PASCAPERSALINAN:
PERSPEKTIF MODERN DALAM DUKUNGAN ASI
EKSKLUSIF DAN PENCEGAHAN DEPRESI
POSTPARTUM

Penulis:

Bd. Dewi Mayangsari, S.SiT., M.Kes., M.Keb.

Rolita Efriani, S.ST., M.Keb.

Ririn Ratnasari, SST., M.kes.

Handayani, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

Bdn. Putu Lusita Nati Indriani, SST., M.Kes.

Bdn. Erma Puspita Sari, SST., M.Kes.

Nur Hidayati, S.SiT., M.Kes.

Editor:

Ira Martin Pramiyana, SST., MPH.



BUNGA RAMPAI ASUHAN KEBIDANAN PASCAPERSALINAN: PERSPEKTIF MODERN DALAM DUKUNGAN ASI EKSKLUSIF DAN PENCEGAHAN DEPRESI POSTPARTUM

Penulis: Bd. Dewi Mayangsari, S.SiT., M.Kes., M.Keb.
Rolita Efriani, S.ST., M.Keb.
Ririn Ratnasari, SST., M.kes.
Handayani, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.
Bdn. Putu Lusita Nati Indriani, SST., M.Kes.
Bdn. Erma Puspita Sari, SST., M.Kes.
Nur Hidayati, S.SiT., M.Kes.

Editor: Ira Martin Pramiyana, SST., MPH.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7426-10-9

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Alhamdulillah, buku bunga rampai Asuhan Kebidanan Pascapersalinan: Perspektif Modern dalam Dukungan ASI Eksklusif dan Pencegahan Depresi Postpartum hadir sebagai ikhtiar kolektif untuk menjembatani jurang antara pengetahuan ilmiah mutakhir dan praktik sehari-hari di ruang bersalin, rumah bersalin, puskesmas, dan komunitas. Masa pascapersalinan adalah periode yang sering kurang mendapatkan perhatian, padahal di sinilah fondasi kesehatan ibu dan bayi diletakkan: keberhasilan menyusui, pemulihan fisik, kestabilan psikologis, dan terbentuknya ikatan orang tua dengan bayi. Ketiganya saling terkait dan saling memperkuat. Dukungan menyusui yang efektif dapat menurunkan risiko stres dan gejala depresi, sementara kesehatan mental ibu yang terjaga meningkatkan peluang keberhasilan menyusui.

Buku ini berangkat dari keyakinan bahwa asuhan pascapersalinan yang bermartabat harus berpusat pada ibu dan keluarga, berbasis bukti, dan peka terhadap konteks budaya. Para penulis menghadirkan pembahasan tentang strategi dukungan menyusui yang humanis dan terukur, mulai dari inisiasi menyusui dini, perlekatan yang tepat, manajemen masalah laktasi yang paling sering ditemui, hingga tata laksana kondisi khusus. Pada saat yang sama, buku ini mengulas pencegahan dan deteksi dini depresi pascapersalinan melalui pendekatan yang holistik: penguatan jejaring dukungan, komunikasi empatik, skrining yang etis, rujukan yang tepat, serta intervensi psikososial yang dapat diintegrasikan dalam layanan kebidanan.

Kami menyadari bahwa tenaga kebidanan bekerja di tengah tantangan zaman: beban kerja yang tinggi, keterbatasan sumber daya, serta arus informasi yang cepat berubah. Karena itu, setiap bab dirancang ringkas namun padat guna menggabungkan landasan teoretis, ringkasan bukti, langkah praktik, skenario kasus, alat siap pakai, dan indikator mutu yang memudahkan implementasi. Harapannya, pembaca memperoleh bukan hanya pemahaman, tetapi juga keterampilan konkret untuk diadaptasi sesuai kebutuhan setempat.

Bunga rampai ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas disiplin. Asuhan pascapersalinan yang berkualitas melibatkan bidan, perawat, dokter, konselor laktasi, psikolog, kader, serta dukungan keluarga dan komunitas. Perspektif modern di sini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan keberanian untuk memadukan ilmu dengan

kearifan lokal, teknologi dengan kedekatan manusiawi, serta standar klinis dengan nilai dan preferensi keluarga.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis, penelaah sejawat, dan para praktisi lapangan yang berbagi pengalaman, data, dan refleksi. Kami juga menghaturkan penghargaan kepada para ibu dan keluarga yang kisahnya menginspirasi penyusunan buku ini. Semoga kehadiran karya ini menjadi bagian dari gerakan memperkuat layanan pascapersalinan yang aman, ramah, dan berkeadilan.

Kami membuka diri terhadap umpan balik untuk perbaikan edisi mendatang. Semoga buku ini bermanfaat sebagai rujukan belajar, pengayaan praktik klinis, serta bahan ajar bagi pendidik dan mahasiswa. Pada akhirnya, tujuan kita satu: memastikan setiap ibu dan bayi melewati masa pascapersalinan dengan sehat, percaya diri, dan bahagia.

Oktober, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA..... iii

DAFTAR ISI..... v

CHAPTER 1 KONSEP ASUHAN PASCAPERSALINAN MODERN 1

Bd. Dewi Mayangsari, S.Si.T., M.Kes., M.Keb..... 1

A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Prinsip Dasar Asuhan Pascapersalinan Modern	2
C. Komponen Utama Asuhan Pascapersalinan Modern.....	4
D. Pendekatan Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice).....	6
E. Integrasi Teknologi dalam Asuhan Pascapersalinan Modern	7
F. Asuhan Psikososial dan Dukungan Mental Emosional	9
G. Peran Kolaborasi Interprofesional dalam Asuhan Pascapersalinan	11
H. Peran Edukasi dalam Meningkatkan Kemandirian Ibu Pascapersalinan.....	13
I. Tantangan dan Strategi Optimalisasi Asuhan Pascapersalinan Modern.....	15
J. Simpulan.....	17
K. Referensi	18
L. Glosarium	20

CHAPTER 2 STRATEGI EFEKTIF MENDUKUNG PEMBERIAN ASI

EKSKLUSIF23

Rolita Efriani, S.ST., M.Keb.....23

A. Pendahuluan/Prolog	23
B. Pentingnya Pemberian ASI Eksklusif	23
C. Strategi Edukasi dan Konseling bagi Ibu dan Keluarga.....	28
D. Kebijakan dan Dukungan di Tempat Kerja.....	31
E. Peran Teknologi dan Inovasi Digital dalam Mendukung Menyusui	33
F. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Kampanye ASI Eksklusif	36
G. Kesimpulan	38
H. Daftar Pustaka	38

CHAPTER 3 PENATALAKSANAAN KOMPLIKASI POSTPARTUM BERBASIS BUKTI.....	45
Ririn Ratnasari, SST., M.kes.	45
A. Pendahuluan/Prolog	45
B. Jenis-Jenis Komplikasi Postpartum	46
C. Prinsip Pendekatan Berbasis Bukti dalam Penatalaksanaan	48
D. Penatalaksanaan Perdarahan Postpartum (PPH)	50
E. Penatalaksanaan Infeksi Postpartum.....	52
F. Penanganan Gangguan Psikologis Postpartum	53
G. Kolaborasi dan Sistem Rujukan.....	55
H. Peran Edukasi dan Follow-up Masa Nifas	57
I. Simpulan.....	58
J. Referensi	59
K. Glosarium	60

CHAPTER 4 IDENTIFIKASI DINI DAN MANAJEMEN DEPRESI POSTPARTUM.....	63
Handayani, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.	63
A. Pendahuluan/Prolog	63
B. Konsep Depresi Postpartum dalam Perspektif Kebidanan Modern	64
C. Faktor Risiko dan Determinan Depresi Postpartum	65
D. Pentingnya Identifikasi Dini dalam Praktik Kebidanan	66
E. Peran Bidan dalam Sistem Deteksi Dini	67
F. Pendekatan Manajemen Depresi Postpartum	69
G. Peran Tenaga Kebidanan dalam Pencegahan dan Manajemen Depresi Postpartum.....	70
H. Tantangan dan Peluang dalam Identifikasi Dini dan Manajemen Depresi Postpartum.....	72
I. Simpulan.....	73
J. Referensi	75
K. Glosarium	76

CHAPTER 5 PENDAMPINGAN DAN KONSELING KELUARGA PADA MASA NIFAS	79
Bdn. Putu Lusita Nati Indriani, SST., M.Kes.	79
A. Pendahuluan/Prolog	79
B. Konsep Dasar Masa Nifas dan Peran Keluarga.....	80
C. Prinsip-Prinsip Konseling Keluarga dalam Kebidanan.....	81
D. Metode Pendampingan Keluarga oleh Bidan	83
E. Materi Konseling Masa Nifas	84
F. Keterlibatan Suami dan Keluarga Inti.....	86

G. Tantangan dan Solusi dalam Konseling Keluarga	87
H. Studi Kasus Pendampingan Masa Nifas.....	88
I. Peran Bidan dalam Penguatan Sistem Dukungan Keluarga	90
J. Simpulan.....	91
K. Referensi	92
L. Glosarium	92
 CHAPTER 6 EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA	
BERENCANA PASCAPERSALINAN.....	95
Bdn. Erma Puspita Sari, SST., M.Kes.	95
A. Pendahuluan/Pendahuluan	95
B. Konsep Kesehatan Reproduksi Pascapersalinan	96
C. Hak dan Kebutuhan Reproduksi Ibu Pascapersalinan	98
D. Edukasi Seksualitas Sehat Pascapersalinan.....	99
E. Kontrasepsi Pascapersalinan: Jenis dan Indikasi	101
F. Komunikasi Efektif dalam Edukasi Keluarga Berencana	102
G. Peran Suami dan Keluarga dalam Pengambilan Keputusan KB	104
H. Tantangan Edukasi Reproduksi Pascapersalinan	105
I. Simpulan.....	107
J. Referensi.....	108
K. Glosarium	108
 CHAPTER 7 EVALUASI MUTU LAYANAN KEBIDANAN PADA MASA	
NIFAS.....	111
Nur Hidayati, S.SiT., M.Kes.	111
A. Pendahuluan/Prolog	111
B. Dimensi Mutu dalam Pelayanan Kebidanan Masa Nifas	112
C. Indikator Mutu Pelayanan Nifas.....	113
D. Metode Evaluasi Mutu Layanan Kebidanan.....	115
E. Peran Bidan dalam Monitoring dan Evaluasi Pelayanan	116
F. Tantangan dalam Menjaga Mutu Pelayanan Nifas	118
G. Strategi Peningkatan Mutu Berkelanjutan	119
H. Simpulan.....	121
I. Referensi.....	122
J. Glosarium	123
 PROFIL PENULIS	127

CHAPTER 1

KONSEP ASUHAN PASCAPERSALINAN MODERN

Bd. Dewi Mayangsari, S.Si.T., M.Kes., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Asuhan pascapersalinan adalah tahapan yang tidak kalah penting dari proses persalinan itu sendiri. Dalam perspektif modern, asuhan pascapersalinan tidak lagi dipandang hanya sebagai pemeriksaan rutin terhadap kondisi fisik ibu dan bayi semata, tetapi sudah berkembang menjadi sebuah konsep yang mencakup aspek yang lebih luas dan komprehensif. Asuhan pascapersalinan modern bertujuan untuk memastikan bahwa ibu dan bayinya dapat melalui masa transisi yang kritis ini dengan aman, sehat secara fisik maupun emosional, serta mampu beradaptasi secara optimal terhadap peran-peran barunya.

Periode pascapersalinan, khususnya 24 jam pertama hingga beberapa minggu setelah melahirkan, merupakan fase yang sangat rentan bagi seorang ibu. Pada masa ini, perubahan fisik yang dramatis terjadi akibat proses persalinan serta kondisi hormonal yang berfluktuasi dengan signifikan. Perubahan-perubahan tersebut sering kali disertai berbagai tantangan kesehatan seperti perdarahan postpartum, infeksi, atau masalah yang berhubungan dengan proses menyusui. Selain itu, fase ini juga merupakan periode di mana banyak ibu mengalami tantangan psikologis yang tidak ringan. Misalnya saja, munculnya gangguan emosional seperti baby blues, kecemasan berlebihan, bahkan depresi postpartum yang jika tidak mendapatkan perhatian khusus bisa berkembang menjadi kondisi serius dan berdampak jangka panjang pada hubungan ibu-bayi.

Dalam perspektif modern, asuhan pascapersalinan dituntut untuk dapat merespon secara holistik dan peka terhadap kebutuhan ibu secara menyeluruh, baik fisik maupun psikologis. Dengan demikian, model pendekatan yang bersifat integratif dan berbasis bukti ilmiah menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas asuhan yang diberikan kepada ibu pascapersalinan. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, dokter spesialis kebidanan, psikolog, serta tenaga kesehatan lain yang relevan harus berkolaborasi secara intensif untuk memastikan bahwa setiap ibu mendapatkan asuhan terbaik yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Tantangan yang dihadapi oleh ibu baru dalam periode pascapersalinan juga sangat beragam. Selain tantangan fisik yang muncul akibat proses persalinan itu

sendiri, ibu juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan dalam rutinitas kesehariannya, seperti jadwal tidur yang tidak teratur akibat kebutuhan bayi yang baru lahir, rasa nyeri yang dirasakan setelah persalinan, hingga perubahan drastis dalam perannya sebagai seorang ibu. Semua tantangan ini tidak jarang menimbulkan tekanan psikologis yang cukup besar, terlebih jika ibu merasa tidak mendapat dukungan sosial yang memadai dari keluarga atau lingkungannya.

Di sinilah peran tenaga kesehatan menjadi sangat krusial dalam memberikan asuhan pascapersalinan modern yang komprehensif. Tenaga kesehatan tidak hanya bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan medis rutin terhadap ibu dan bayi, tetapi juga dituntut untuk memberikan edukasi secara kontinu kepada ibu dan keluarganya tentang bagaimana mengenali tanda-tanda bahaya postpartum, mengelola perubahan emosi dan stres, serta meningkatkan keterampilan merawat bayi yang baru lahir. Selain itu, dukungan emosional yang diberikan oleh tenaga kesehatan juga sangat penting dalam membantu ibu mengatasi rasa takut, cemas, dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama masa transisi ini.

Dalam konsep asuhan pascapersalinan modern, peran tenaga kesehatan juga semakin diperkuat dengan pendekatan teknologi informasi yang mendukung pemantauan kondisi ibu dan bayi secara efektif. Contohnya adalah penggunaan aplikasi digital, telemidwifery, dan pemanfaatan teknologi medis canggih yang memungkinkan tenaga kesehatan melakukan pengawasan kesehatan ibu secara jarak jauh dengan lebih efisien dan akurat. Penggunaan teknologi ini merupakan bagian integral dari asuhan pascapersalinan modern yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam konteks geografis seperti wilayah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan.

B. Prinsip Dasar Asuhan Pascapersalinan Modern

Asuhan pascapersalinan modern didasarkan pada serangkaian prinsip yang memastikan ibu dan bayi mendapatkan perawatan secara optimal, aman, dan sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam merancang dan memberikan pelayanan yang efektif serta responsif terhadap berbagai tantangan yang muncul setelah persalinan. Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi pendekatan holistik, evidence-based practice (berbasis bukti), woman-centered care (asuhan berpusat pada perempuan), dan continuity of care (keberlanjutan pelayanan).

Pendekatan holistik merupakan prinsip yang pertama dan mendasar dalam asuhan pascapersalinan modern. Pendekatan ini menganggap bahwa ibu pascapersalinan adalah individu yang utuh, tidak hanya memiliki kebutuhan fisik tetapi juga psikologis, emosional, sosial, dan spiritual. Oleh sebab itu, asuhan yang

diberikan kepada ibu haruslah mampu merespon secara komprehensif terhadap berbagai aspek kebutuhan tersebut. Dalam praktiknya, pendekatan holistik akan terlihat melalui perhatian tenaga kesehatan terhadap kondisi fisik ibu, seperti memantau proses involusi rahim, manajemen nyeri, pemberian nutrisi, hingga perawatan luka pasca persalinan. Namun, lebih dari itu, tenaga kesehatan juga perlu secara aktif menggali dan merespon kebutuhan psikologis ibu seperti memberikan konseling emosional, mendeteksi dini gangguan mental seperti baby blues atau depresi postpartum, serta memberikan dukungan emosional yang memadai.

Prinsip kedua yang menjadi landasan penting adalah evidence-based practice atau praktik berbasis bukti ilmiah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan dan intervensi dalam asuhan pascapersalinan harus didasarkan pada hasil penelitian ilmiah yang terpercaya, relevan, dan terbaru. Dengan demikian, berbagai prosedur seperti pemantauan perdarahan postpartum, pencegahan infeksi, metode menyusui, hingga intervensi dalam mengatasi gangguan psikologis, dilakukan berdasarkan bukti ilmiah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan benar-benar efektif, aman, serta membawa manfaat optimal bagi ibu dan bayi. Dalam penerapan praktik berbasis bukti ini, tenaga kesehatan perlu terus-menerus memperbarui pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, seminar, maupun jurnal-jurnal terbaru di bidang kebidanan dan kesehatan maternal.

Selanjutnya, prinsip woman-centered care atau asuhan berpusat pada perempuan juga menjadi bagian yang integral dari konsep asuhan pascapersalinan modern. Prinsip ini menempatkan ibu sebagai pusat utama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan asuhan pascapersalinan. Artinya, ibu tidak hanya dipandang sebagai objek penerima layanan tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan jenis perawatan yang ingin didapatkannya. Asuhan berpusat pada perempuan memandang bahwa setiap ibu memiliki latar belakang, kebutuhan, preferensi, serta harapan yang unik. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu membuka ruang dialog dan komunikasi yang empatik dengan ibu, mendengarkan keluhan dan kebutuhan ibu secara aktif, serta memberikan informasi yang jelas dan lengkap sehingga ibu mampu mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan bayinya. Dengan pendekatan ini, ibu merasa dihargai, dihormati, serta memiliki rasa kontrol terhadap proses perawatan yang diterimanya, sehingga meningkatkan kepuasan serta kualitas hidup ibu pascapersalinan secara keseluruhan.

Prinsip terakhir yang tidak kalah penting adalah continuity of care atau prinsip keberlanjutan pelayanan. Continuity of care berarti bahwa ibu mendapatkan pelayanan yang berkesinambungan dan konsisten sejak masa kehamilan, persalinan,

hingga periode pascapersalinan. Keberlanjutan pelayanan ini sangat penting karena dapat memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki pemahaman yang mendalam tentang riwayat kesehatan, kondisi fisik dan psikologis ibu, serta kebutuhan khusus yang mungkin dimiliki oleh ibu. Dengan pelayanan yang berkelanjutan, tenaga kesehatan dapat mendeteksi perubahan-perubahan kecil yang mungkin mengindikasikan munculnya komplikasi atau masalah kesehatan secara dini, sehingga penanganan yang cepat dapat dilakukan. Prinsip ini juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi ibu karena ia merasa didampingi secara penuh oleh tim kesehatan yang sudah mengenalnya sejak awal.

C. Komponen Utama Asuhan Pascapersalinan Modern

Asuhan pascapersalinan modern mencakup berbagai komponen utama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, serta sosial ibu dan bayi secara menyeluruh. Komponen-komponen ini saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain, membentuk suatu sistem perawatan terpadu yang memastikan kesehatan dan kesejahteraan ibu serta bayi dalam periode kritis setelah persalinan. Secara detail, komponen utama tersebut mencakup perawatan fisik, dukungan emosional, edukasi keluarga, serta pemantauan kesehatan ibu dan bayi secara komprehensif.

Perawatan fisik merupakan komponen pertama dan sangat penting dalam asuhan pascapersalinan modern. Setelah menjalani proses persalinan, ibu mengalami berbagai perubahan signifikan secara fisik, yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan pemulihan yang optimal. Perawatan fisik ini meliputi beberapa aspek utama, di antaranya adalah pengelolaan nyeri pascapersalinan, pemantauan kontraksi dan involusi rahim, pengelolaan perdarahan postpartum, perawatan luka jahitan, serta manajemen nutrisi ibu untuk mempercepat proses penyembuhan. Dalam perawatan fisik, perhatian juga diberikan terhadap aktivitas mobilisasi dini, higiene perineum yang tepat, perawatan payudara agar mencegah mastitis, dan dukungan dalam proses menyusui agar bayi mendapatkan nutrisi yang optimal. Dengan perawatan fisik yang baik, diharapkan pemulihan ibu akan berlangsung lebih cepat dan komplikasi seperti perdarahan, infeksi, serta gangguan kesehatan lainnya dapat diminimalkan secara signifikan.

Selain aspek fisik, dukungan emosional juga menjadi komponen penting yang perlu diperhatikan dalam asuhan pascapersalinan modern. Setelah melahirkan, ibu cenderung mengalami fluktuasi emosi yang signifikan akibat perubahan hormonal, kelelahan fisik, dan berbagai tantangan baru yang muncul saat merawat bayi. Dukungan emosional diberikan melalui pendekatan empatik oleh tenaga kesehatan dan keluarga, berupa konseling individu maupun kelompok, memberikan

kesempatan kepada ibu untuk berbagi perasaan atau pengalaman, serta membantu ibu mengelola stres dan kecemasan secara efektif. Dukungan ini sangat penting untuk mencegah gangguan emosional seperti baby blues, kecemasan berlebih, hingga depresi postpartum. Tenaga kesehatan juga perlu aktif melakukan skrining psikologis untuk mendeteksi dini gangguan kesehatan mental, agar intervensi psikologis atau bahkan farmakologis bisa segera diberikan jika diperlukan.

Komponen berikutnya yang tidak kalah penting adalah edukasi keluarga. Dalam asuhan pascapersalinan modern, edukasi tidak hanya diberikan kepada ibu saja, tetapi juga kepada anggota keluarga lain yang terlibat langsung dalam perawatan ibu dan bayi. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan keluarga dalam merawat ibu pascapersalinan secara mandiri di rumah. Beberapa materi edukasi penting yang diberikan mencakup cara mengenali tanda-tanda komplikasi postpartum dini seperti perdarahan hebat, infeksi luka jahitan, atau gangguan psikologis, teknik perawatan luka jahitan yang tepat, cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta prinsip-prinsip dasar menyusui yang efektif dan nyaman. Selain itu, edukasi keluarga juga mencakup informasi tentang nutrisi yang tepat untuk ibu dalam masa pemulihan, teknik mobilisasi yang aman untuk menghindari komplikasi seperti trombosis vena dalam (deep vein thrombosis), serta cara mendukung ibu secara emosional untuk melewati periode yang menantang ini.

Komponen terakhir adalah pemantauan kesehatan ibu dan bayi secara menyeluruh. Pemantauan ini merupakan proses kontinu yang dilakukan sejak ibu selesai melahirkan hingga masa postpartum selesai, biasanya hingga enam minggu pascapersalinan. Pemantauan dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi secara dini adanya tanda-tanda komplikasi yang mungkin timbul baik pada ibu maupun bayi, sehingga dapat segera ditangani secara cepat dan tepat. Pemantauan meliputi pemeriksaan rutin tanda vital seperti tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, respirasi, serta pemeriksaan fisik rahim, perineum, payudara, hingga luka operasi jika ada. Pada bayi, pemantauan dilakukan terhadap tanda vital, status nutrisi, pertumbuhan dan perkembangan, serta pola tidur dan menyusui. Pemeriksaan secara rutin dan terjadwal memungkinkan tenaga kesehatan untuk mendeteksi dini potensi komplikasi seperti infeksi, perdarahan, atau gangguan emosional pada ibu, maupun masalah kesehatan seperti kuning (ikterus), hipotermia, atau gangguan menyusui pada bayi.

D. Pendekatan Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice)

Pendekatan berbasis bukti atau evidence-based practice (EBP) merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan asuhan pascapersalinan modern. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap keputusan klinis dan tindakan yang diberikan kepada ibu pascapersalinan harus berdasarkan bukti ilmiah yang valid dan terbaru, sehingga dapat menjamin keamanan, efektivitas, dan efisiensi dari perawatan yang diberikan. Melalui penerapan EBP, tenaga kesehatan dapat memastikan bahwa praktik klinis tidak lagi hanya berdasarkan kebiasaan atau pengalaman semata, melainkan juga didukung oleh hasil penelitian terkini yang terpercaya.

Dalam konteks asuhan pascapersalinan, penggunaan pendekatan berbasis bukti sangat penting karena masa postpartum merupakan periode yang kritis di mana ibu sangat rentan mengalami berbagai komplikasi serius seperti perdarahan postpartum, infeksi, gangguan psikologis, hingga komplikasi menyusui. Dengan merujuk pada hasil penelitian terbaru, tenaga kesehatan memiliki panduan yang jelas tentang intervensi mana yang paling efektif dan aman untuk digunakan dalam berbagai kondisi klinis pascapersalinan. Hal ini membantu tenaga kesehatan untuk menghindari praktik yang tidak efektif atau bahkan berisiko bagi kesehatan ibu maupun bayi.

Salah satu contoh penerapan pendekatan berbasis bukti dalam asuhan pascapersalinan adalah penggunaan uterotonika secara rutin setelah persalinan untuk mencegah perdarahan postpartum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian oksitosin segera setelah bayi lahir dapat secara signifikan menurunkan risiko perdarahan postpartum yang merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan bukti tersebut, World Health Organization (WHO) merekomendasikan pemberian oksitosin sebagai standar praktik bagi seluruh ibu yang baru melahirkan, kecuali terdapat kontraindikasi medis tertentu.

Contoh lainnya adalah praktik menyusui dini (early initiation of breastfeeding) dalam waktu satu jam pertama setelah kelahiran. Berbagai penelitian membuktikan bahwa menyusui dini memiliki manfaat besar, baik bagi ibu maupun bayi. Dari sisi ibu, menyusui dini membantu mempercepat kontraksi rahim sehingga menurunkan risiko perdarahan postpartum dan mempercepat proses involusi rahim. Sedangkan dari sisi bayi, menyusui dini dapat meningkatkan peluang keberhasilan ASI eksklusif dan memperkuat ikatan emosional (bonding) antara ibu dan bayi. Bukti kuat ini telah mendorong praktik menyusui dini menjadi rekomendasi global dalam asuhan pascapersalinan modern.

Selain aspek medis, pendekatan berbasis bukti juga sangat penting dalam penanganan gangguan psikologis postpartum seperti baby blues dan depresi postpartum. Skrining rutin menggunakan instrumen valid seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) telah terbukti efektif dalam mendeteksi ibu yang berisiko mengalami depresi postpartum sejak dini. Dengan adanya deteksi dini ini, intervensi psikologis seperti terapi perilaku kognitif (CBT) atau konseling interpersonal dapat segera diberikan, yang juga telah terbukti melalui berbagai penelitian mampu secara signifikan menurunkan risiko depresi berkepanjangan serta meningkatkan kualitas hidup ibu pascapersalinan.

Dalam implementasi EBP, sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk selalu memperbarui pengetahuannya tentang hasil penelitian terkini melalui pelatihan, seminar, atau jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Penggunaan protokol klinis, pedoman praktik klinis (clinical practice guidelines), serta keterlibatan aktif dalam diskusi interprofesional juga merupakan langkah penting agar tenaga kesehatan selalu dapat mengaplikasikan bukti terbaru dalam praktik sehari-hari.

Dengan konsisten menerapkan pendekatan berbasis bukti, tenaga kesehatan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas asuhan pascapersalinan yang diberikan tetapi juga secara nyata menurunkan risiko komplikasi postpartum, sehingga memberikan dampak positif bagi kesehatan ibu, bayi, dan keluarganya dalam jangka panjang. Pendekatan ini juga mencerminkan tanggung jawab profesional dalam memberikan perawatan terbaik yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian terkini, demi mewujudkan asuhan pascapersalinan yang aman, efektif, dan bermutu tinggi.

E. Integrasi Teknologi dalam Asuhan Pascapersalinan Modern

Dalam era modern saat ini, teknologi memiliki peran yang semakin strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk dalam asuhan pascapersalinan. Integrasi teknologi, baik digital maupun medis, menjadi salah satu elemen penting yang mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan optimal kepada ibu yang baru melahirkan dan keluarganya. Pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk memperluas akses, mempercepat deteksi komplikasi, meningkatkan kualitas pemantauan kesehatan, serta mendukung edukasi yang lebih efektif dan interaktif kepada keluarga.

Salah satu bentuk teknologi yang semakin berkembang dan terbukti memberikan manfaat besar dalam asuhan pascapersalinan adalah telemidwifery. Telemidwifery merupakan praktik kebidanan jarak jauh yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti telepon, pesan singkat, video call, maupun platform aplikasi kesehatan digital. Dengan menggunakan telemidwifery,

bidan dan tenaga kesehatan lainnya mampu memberikan konsultasi, edukasi, serta pemantauan rutin kepada ibu pascapersalinan tanpa terhalang oleh jarak atau keterbatasan geografis. Terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau, telemidwifery membantu ibu baru mendapatkan akses layanan yang cepat, tepat waktu, dan berkualitas tinggi, sekaligus meningkatkan rasa aman dan percaya diri dalam merawat diri dan bayinya di rumah.

Pemanfaatan aplikasi kesehatan ibu juga menjadi bagian penting dalam integrasi teknologi modern di masa pascapersalinan. Berbagai aplikasi digital kini tersedia dan secara khusus didesain untuk mendukung ibu baru dalam memahami kondisi kesehatannya, mendeteksi gejala komplikasi dini, mengelola jadwal pemeriksaan rutin, serta memperoleh edukasi kesehatan yang jelas dan mudah dipahami. Aplikasi tersebut biasanya dilengkapi dengan fitur interaktif, misalnya pengingat jadwal kunjungan pascapersalinan, panduan menyusui yang benar, teknik perawatan luka persalinan, hingga skrining gangguan psikologis postpartum. Melalui penggunaan aplikasi kesehatan, ibu dapat lebih aktif dalam mengelola kesehatannya sendiri dan merasa lebih dekat serta terkoneksi dengan tenaga kesehatan yang mendampingi.

Selain teknologi digital, kemajuan teknologi medis modern juga turut memberikan kontribusi besar dalam asuhan pascapersalinan. Alat-alat diagnostik canggih seperti ultrasound portabel, alat monitoring tekanan darah digital, pulse oximetry, serta alat-alat deteksi dini perdarahan atau infeksi postpartum kini semakin mudah diakses dan digunakan secara luas. Dengan menggunakan alat-alat ini, tenaga kesehatan mampu mendeteksi tanda-tanda komplikasi secara cepat, tepat, dan akurat, sehingga intervensi medis dapat dilakukan sedini mungkin sebelum komplikasi berkembang menjadi kondisi yang serius.

Sebagai contoh, penggunaan ultrasound portabel dapat membantu tenaga kesehatan memastikan rahim telah bersih dari sisa jaringan plasenta setelah persalinan, sehingga risiko perdarahan akibat retensi plasenta dapat diminimalkan. Begitu pula, pemantauan tekanan darah secara digital dan berkelanjutan sangat penting untuk ibu yang berisiko mengalami hipertensi postpartum atau preeklamsia pascapersalinan, sehingga kondisi tersebut dapat diidentifikasi dan ditangani lebih awal.

Teknologi wearable atau perangkat yang dapat dikenakan seperti smartwatch atau gelang kesehatan juga mulai dimanfaatkan dalam asuhan pascapersalinan modern. Teknologi ini memungkinkan pemantauan kondisi fisik ibu secara real-time, seperti detak jantung, pola tidur, suhu tubuh, serta aktivitas fisik, yang semuanya memberikan informasi penting tentang status kesehatan ibu selama masa pemulihan setelah melahirkan. Data yang dihasilkan oleh perangkat wearable ini

dapat dikirimkan secara langsung ke tenaga kesehatan melalui aplikasi digital, sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan rekomendasi yang lebih personal dan spesifik sesuai kebutuhan masing-masing ibu.

Selain manfaat klinis, integrasi teknologi juga berkontribusi dalam mendukung kesehatan mental ibu pascapersalinan. Berbagai aplikasi digital kini menyediakan layanan konseling virtual, komunitas online ibu baru, hingga fitur interaktif yang memungkinkan ibu berbagi pengalaman atau bertanya langsung kepada pakar kesehatan mengenai tantangan yang mereka hadapi. Dukungan emosional yang didapatkan melalui teknologi ini terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan, mencegah depresi postpartum, serta mempercepat adaptasi ibu terhadap peran barunya.

Namun, dalam penerapan teknologi dalam asuhan pascapersalinan modern, beberapa tantangan tetap harus diperhatikan, seperti keterbatasan literasi digital di kalangan ibu dan keluarga, keterbatasan jaringan internet di daerah terpencil, serta kebutuhan pelatihan yang cukup bagi tenaga kesehatan untuk menggunakan teknologi secara efektif. Oleh karena itu, pendekatan terpadu dan kolaborasi antar sektor diperlukan agar manfaat teknologi ini dapat benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh ibu pascapersalinan.

Dengan integrasi teknologi secara tepat dan optimal, asuhan pascapersalinan modern tidak hanya mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien tetapi juga secara nyata meningkatkan kualitas hidup, keselamatan, dan kesejahteraan ibu, bayi, serta keluarganya. Hal ini semakin menegaskan pentingnya teknologi sebagai bagian integral dalam asuhan pascapersalinan masa kini yang berorientasi pada masa depan yang lebih baik.

F. Asuhan Psikososial dan Dukungan Mental Emosional

Dalam konsep asuhan pascapersalinan modern, perhatian terhadap aspek psikologis dan emosional seorang ibu merupakan hal yang tidak kalah penting dibandingkan dengan perawatan fisik. Masa setelah persalinan merupakan periode yang kompleks secara emosional bagi banyak ibu, ditandai dengan berbagai perubahan drastis, baik fisik, hormonal, maupun peran sosial. Oleh sebab itu, asuhan psikososial dan dukungan mental emosional harus diberikan secara terencana, komprehensif, dan tepat waktu agar ibu dapat menjalani masa transisi ini dengan baik dan sehat secara mental.

Pasca melahirkan, hampir setiap ibu mengalami berbagai perasaan emosional yang beragam, mulai dari rasa bahagia yang mendalam hingga kekhawatiran dan kecemasan yang tidak terduga. Sebagian besar ibu baru, sekitar 50-80%, akan mengalami kondisi ringan yang dikenal sebagai baby blues. Baby blues biasanya

muncul beberapa hari pertama setelah persalinan, ditandai dengan perasaan mudah menangis, perubahan suasana hati yang cepat, perasaan kewalahan, kelelahan fisik dan mental yang intens, serta kecenderungan merasa sedih tanpa sebab jelas. Meskipun tergolong ringan dan bersifat sementara (biasanya berlangsung tidak lebih dari dua minggu), baby blues bisa menimbulkan ketidaknyamanan yang signifikan bagi ibu baru, sehingga membutuhkan dukungan emosional dari pasangan, keluarga, dan tenaga kesehatan.

Namun demikian, tidak sedikit ibu yang mengalami kondisi lebih serius seperti gangguan kecemasan postpartum atau bahkan depresi postpartum. Gangguan kecemasan postpartum biasanya ditandai oleh kecemasan berlebihan yang sulit dikendalikan, rasa takut yang mendalam tentang keselamatan bayi atau diri sendiri, gangguan tidur, bahkan gejala fisik seperti jantung berdebar, mual, nyeri dada, hingga pusing. Kondisi ini bila tidak segera mendapat perhatian khusus dapat berdampak negatif terhadap interaksi ibu dan bayi, mengganggu proses bonding, dan bahkan memengaruhi kesehatan fisik ibu secara keseluruhan.

Lebih jauh, kondisi depresi postpartum merupakan gangguan yang jauh lebih serius dan membutuhkan intervensi segera. Sekitar 10–15% ibu baru mengalami depresi postpartum yang ditandai dengan perasaan sedih mendalam yang menetap, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, rasa bersalah yang berlebihan, kesulitan berkonsentrasi, perubahan pola tidur dan makan yang ekstrem, serta pada beberapa kasus berat bahkan muncul pikiran untuk melukai diri sendiri atau bayinya. Kondisi ini bukan hanya berdampak buruk terhadap ibu secara individu, tetapi juga sangat berpotensi merusak keharmonisan keluarga serta tumbuh kembang bayi dalam jangka panjang.

Dalam konteks inilah deteksi dini masalah psikososial dan emosional sangat penting untuk dilakukan secara aktif oleh tenaga kesehatan. Pendekatan terbaik adalah melalui skrining rutin kondisi mental ibu sejak hari-hari awal pascapersalinan, misalnya dengan menggunakan alat bantu seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Skrining semacam ini terbukti efektif dalam mengidentifikasi secara dini ibu-ibu yang berisiko tinggi mengalami gangguan psikologis postpartum, sehingga intervensi yang diperlukan bisa segera diberikan.

Setelah ibu yang berisiko teridentifikasi, intervensi dini yang tepat harus segera dilakukan. Strategi intervensi ini dapat berupa konseling atau psikoterapi, baik secara individu maupun kelompok. Psikoterapi yang paling sering digunakan adalah terapi perilaku kognitif (CBT) yang bertujuan membantu ibu mengenali pola pikir negatifnya, mengubahnya menjadi pola pikir yang lebih konstruktif, serta melatih ibu dalam strategi koping efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya. Terapi interpersonal juga sangat efektif, terutama untuk membantu ibu

memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat perubahan peran serta memberikan pemahaman mengenai dinamika keluarga baru setelah kehadiran bayi.

Pada beberapa situasi yang lebih serius, seperti depresi postpartum berat, intervensi farmakologis berupa pemberian antidepresan oleh dokter atau psikiater mungkin diperlukan. Dalam hal ini, sangat penting mempertimbangkan aspek keamanan pengobatan tersebut, terutama pada ibu yang masih menyusui. Konsultasi intensif dan pemantauan secara ketat oleh tenaga kesehatan merupakan hal yang wajib dilakukan agar pengobatan berjalan aman dan efektif.

Selain intervensi profesional, dukungan keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam pemulihan ibu secara psikologis pascapersalinan. Keluarga harus diberikan edukasi secara menyeluruh mengenai gejala gangguan psikologis postpartum, serta diajarkan cara memberikan dukungan emosional yang tepat kepada ibu. Dukungan keluarga mencakup memberikan ruang bagi ibu untuk beristirahat, menciptakan suasana yang tenang dan nyaman di rumah, serta memberikan bantuan praktis dalam merawat bayi maupun dalam aktivitas sehari-hari lainnya. Keluarga juga harus memahami bahwa gangguan psikologis postpartum bukanlah kelemahan atau kegagalan pribadi ibu, melainkan kondisi medis yang membutuhkan empati dan penanganan profesional.

Lebih jauh lagi, asuhan psikososial pascapersalinan juga bisa diperkuat dengan memanfaatkan berbagai teknologi digital modern, seperti layanan konseling online, aplikasi kesehatan mental khusus ibu, atau komunitas digital untuk saling berbagi pengalaman. Hal ini dapat membantu ibu untuk merasa lebih terhubung, tidak terisolasi, dan lebih termotivasi untuk segera mencari bantuan bila mengalami kesulitan emosional.

G. Peran Kolaborasi Interprofesional dalam Asuhan Pascapersalinan

Kolaborasi interprofesional merupakan aspek penting dalam pemberian asuhan pascapersalinan modern yang berorientasi pada pelayanan komprehensif, aman, efektif, serta berkesinambungan. Dalam konsep ini, berbagai tenaga kesehatan dari beragam disiplin ilmu bekerja secara terkoordinasi untuk memberikan asuhan terbaik kepada ibu dan bayi setelah proses persalinan. Kolaborasi ini bertujuan agar setiap ibu mendapatkan perawatan fisik, psikologis, sosial, serta edukasi yang optimal, sehingga risiko komplikasi dapat diminimalisasi serta kualitas hidup ibu dan bayi dapat ditingkatkan secara signifikan.

Dalam tim interprofesional yang menangani asuhan pascapersalinan, dokter spesialis kebidanan (obstetrician) berperan penting dalam mengawasi dan mengevaluasi kondisi medis ibu setelah melahirkan. Dokter bertanggung jawab

menentukan diagnosis dan mengambil keputusan medis, terutama ketika menghadapi komplikasi serius seperti perdarahan postpartum, infeksi berat, atau retensi plasenta yang memerlukan tindakan medis atau intervensi bedah segera. Dengan adanya dokter yang kompeten dan sigap dalam tim ini, penanganan komplikasi serius pascapersalinan menjadi lebih cepat, akurat, dan efektif.

Sementara itu, bidan sebagai garda terdepan memiliki peran strategis dalam pemantauan kondisi fisik ibu sehari-hari selama periode postpartum. Bidan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan rutin, membantu ibu mengatasi keluhan fisik umum, serta memberikan edukasi yang komprehensif mengenai perawatan diri, menyusui, dan tanda-tanda bahaya postpartum. Bidan juga berperan dalam deteksi dini berbagai komplikasi, baik fisik maupun psikologis, sehingga langkah penanganan bisa segera dilakukan tanpa penundaan. Peran bidan yang aktif dan edukatif sangat menentukan keberhasilan asuhan postpartum secara menyeluruh.

Perawat sebagai bagian penting dari tim ini juga memainkan peran krusial, terutama dalam aspek perawatan keperawatan. Perawat bertugas untuk memastikan kondisi kesehatan ibu tetap stabil dengan memantau tanda vital secara rutin, menjaga kebersihan luka persalinan atau operasi caesar, serta melakukan manajemen nyeri dan ketidaknyamanan ibu selama masa pemulihan. Selain itu, perawat juga berperan penting dalam memberikan dukungan emosional, membantu mobilisasi awal, serta memastikan lingkungan perawatan aman, bersih, dan nyaman bagi pemulihan ibu dan bayi.

Aspek psikologis dalam asuhan postpartum ditangani secara khusus oleh tenaga profesional di bidang kesehatan mental, seperti psikolog maupun psikiater. Psikolog bertugas melakukan skrining dan evaluasi terhadap kesehatan mental ibu, memberikan konseling psikologis, serta menerapkan intervensi berupa terapi perilaku kognitif atau terapi interpersonal jika diperlukan. Dalam situasi di mana ibu membutuhkan bantuan farmakologis akibat gangguan psikologis berat, peran psikiater menjadi sangat penting dalam merencanakan dan mengelola terapi obat secara aman, khususnya bagi ibu yang sedang menyusui.

Ahli gizi juga memainkan peranan strategis dalam tim interprofesional ini dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan nutrisi ibu setelah melahirkan. Nutrisi pascapersalinan yang optimal penting untuk mempercepat pemulihan fisik, mendukung penyembuhan luka, serta menunjang produksi Air Susu Ibu (ASI) yang cukup untuk kebutuhan bayi. Ahli gizi memberikan edukasi secara spesifik mengenai menu makanan yang sehat, cara mengatur pola makan yang tepat, dan menyesuaikan kebutuhan gizi berdasarkan kondisi kesehatan khusus yang mungkin

dialami ibu, seperti anemia postpartum, diabetes gestasional, atau hipertensi postpartum.

Selain tenaga kesehatan utama tersebut, profesi kesehatan lain seperti fisioterapis dan pekerja sosial juga turut berkontribusi secara signifikan. Fisioterapis membantu ibu mempercepat pemulihan fisik melalui latihan fisik yang tepat dan aman, terutama setelah persalinan melalui operasi caesar atau pada kasus cedera persalinan tertentu. Sementara pekerja sosial berperan membantu keluarga menghadapi berbagai tantangan sosial ekonomi yang sering muncul setelah kelahiran bayi, seperti stres akibat perubahan peran, permasalahan keuangan, hingga masalah relasi keluarga yang dapat memengaruhi kesehatan mental ibu secara keseluruhan.

Efektivitas kolaborasi interprofesional sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka, jelas, dan efektif antar seluruh anggota tim. Informasi mengenai kondisi ibu harus didokumentasikan secara akurat dan terus diperbarui, sehingga setiap tenaga kesehatan dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap dan terkini. Pertemuan rutin tim yang bersifat multidisiplin juga perlu dilakukan secara berkala agar setiap anggota tim memahami kondisi pasien secara menyeluruh, berbagi informasi penting, serta mendiskusikan langkah-langkah intervensi yang paling tepat sesuai dengan perkembangan terbaru kondisi pasien.

Lebih dari itu, hubungan antar tenaga kesehatan dalam tim interprofesional harus didasarkan pada rasa saling menghormati dan memahami kompetensi profesional masing-masing. Setiap anggota tim perlu merasa dihargai dan didukung dalam menjalankan peran serta tanggung jawabnya, sehingga mampu bekerja secara harmonis dan saling melengkapi. Dengan lingkungan kerja yang kolaboratif dan saling percaya ini, asuhan pascapersalinan yang diberikan menjadi lebih efektif, holistik, dan mampu memberikan hasil yang optimal bagi kesehatan ibu, bayi, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

H. Peran Edukasi dalam Meningkatkan Kemandirian Ibu Pascapersalinan

Edukasi menjadi elemen penting dalam konsep asuhan pascapersalinan modern, karena merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta kemandirian ibu dan keluarga selama periode postpartum. Melalui edukasi yang tepat, ibu tidak hanya memahami perubahan fisiologis yang terjadi dalam tubuhnya setelah melahirkan, tetapi juga mampu mengenali tanda-tanda komplikasi secara dini, merawat diri dan bayinya dengan optimal, serta memiliki rasa percaya diri untuk menjalani perannya sebagai orang tua baru.

Edukasi kepada ibu pascapersalinan idealnya dimulai sejak masa kehamilan dan terus berlangsung hingga beberapa minggu atau bulan setelah persalinan. Pendekatan edukasi secara berkelanjutan ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif, sehingga ibu dan keluarganya tidak merasa kewalahan dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul setelah kelahiran bayi. Proses ini sangat krusial karena pada masa postpartum, ibu sering menghadapi berbagai kondisi fisik, psikologis, dan emosional yang kompleks, seperti kelelahan ekstrem, ketidaknyamanan akibat luka persalinan, masalah menyusui, hingga perubahan emosional seperti kecemasan, baby blues, bahkan depresi postpartum.

Materi edukasi yang diberikan kepada ibu mencakup berbagai aspek penting dalam perawatan diri pascapersalinan, seperti cara menjaga kebersihan diri, merawat luka persalinan, teknik menyusui yang tepat dan nyaman, serta pentingnya istirahat dan asupan nutrisi yang cukup untuk mempercepat pemulihan fisik. Selain itu, edukasi juga mencakup pengetahuan praktis dalam perawatan bayi baru lahir, seperti mengenali tanda-tanda lapar pada bayi, menjaga kebersihan bayi, memandikan bayi dengan aman, serta teknik pijatan bayi yang dapat meningkatkan kelekatan emosional antara ibu dan bayi. Dengan keterampilan praktis ini, ibu akan merasa lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan tugas sehari-hari, sehingga rasa cemas dan kekhawatiran berlebihan bisa diminimalisir secara signifikan.

Tidak kalah penting, edukasi juga harus menitikberatkan pada kemampuan ibu dalam mengidentifikasi tanda-tanda bahaya postpartum secara dini, seperti perdarahan berlebihan, nyeri hebat, demam tinggi, infeksi pada luka persalinan, serta tanda-tanda gangguan psikologis. Pemahaman ini penting agar ibu dapat segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gejala tersebut, sehingga risiko komplikasi serius dapat ditekan secara optimal. Edukasi yang jelas dan mudah dipahami juga memungkinkan keluarga, khususnya pasangan, menjadi pihak pertama yang memberikan dukungan serta bantuan apabila terjadi situasi darurat.

Selain aspek fisik, edukasi juga penting dalam meningkatkan kesadaran ibu dan keluarga terhadap pentingnya kesehatan mental dan emosional ibu selama masa postpartum. Pengetahuan tentang perubahan psikologis normal seperti baby blues, rasa cemas, atau ketakutan dalam menghadapi peran baru sebagai orang tua perlu disampaikan secara jelas, termasuk pengetahuan tentang kapan kondisi emosional ini dianggap serius dan memerlukan bantuan profesional. Edukasi ini diharapkan bisa mengurangi stigma sosial terhadap gangguan psikologis postpartum, sehingga ibu dan keluarga tidak ragu untuk segera mendapatkan bantuan psikologis yang dibutuhkan.

Peran tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, dokter, atau psikolog dalam memberikan edukasi sangat vital. Mereka bertugas menyampaikan informasi dalam

bahasa sederhana, lugas, empatik, serta ramah, sehingga ibu dan keluarga merasa nyaman serta termotivasi untuk belajar. Penggunaan media edukasi seperti leaflet, brosur, video edukasi, maupun demonstrasi langsung sangat dianjurkan untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Edukasi juga sebaiknya dilakukan secara interaktif, memberi kesempatan kepada ibu dan keluarga untuk bertanya, berdiskusi, serta mempraktikkan langsung keterampilan yang diajarkan di bawah bimbingan tenaga kesehatan.

Selain itu, dalam konsep asuhan modern, edukasi juga dapat diberikan melalui berbagai platform digital, seperti aplikasi kesehatan ibu dan anak, layanan telemidwifery, atau grup diskusi daring dengan tenaga kesehatan profesional. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan ibu untuk mendapatkan informasi edukatif kapan pun dibutuhkan, tanpa batasan ruang dan waktu. Hal ini sangat bermanfaat khususnya bagi ibu yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan konvensional.

Edukasi yang diberikan kepada keluarga, terutama pasangan, juga tidak kalah penting karena keluarga adalah support system utama bagi ibu selama masa pemulihan. Dengan edukasi yang tepat, keluarga menjadi lebih peka dan sigap dalam memberikan dukungan emosional maupun praktis, seperti membantu merawat bayi, memberikan kesempatan ibu untuk beristirahat, atau membantu tugas rumah tangga agar ibu tidak mengalami kelelahan berlebihan. Dukungan keluarga yang teredukasi dengan baik terbukti secara efektif meningkatkan kesejahteraan emosional ibu serta mempercepat proses adaptasi terhadap peran baru.

I. Tantangan dan Strategi Optimalisasi Asuhan Pascapersalinan Modern

Pemberian asuhan pascapersalinan modern tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh tenaga kesehatan adalah rendahnya kesadaran ibu dan keluarga mengenai pentingnya perawatan postpartum. Banyak ibu menganggap bahwa masa kritis hanya terjadi selama persalinan saja, sehingga mereka kurang memperhatikan pemulihan fisik dan psikologis yang optimal pada periode setelah melahirkan. Rendahnya kesadaran ini menyebabkan kunjungan postpartum sering kali tidak teratur, bahkan diabaikan oleh sebagian ibu, yang berdampak pada meningkatnya risiko komplikasi yang sebenarnya bisa dicegah.

Selain itu, tantangan lain yang sering dijumpai adalah keterbatasan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil. Infrastruktur pelayanan kesehatan yang belum memadai menyebabkan banyak ibu tidak mendapatkan asuhan pascapersalinan yang ideal.

Kekurangan tenaga kesehatan terlatih juga menjadi kendala signifikan, sehingga beban kerja yang tinggi dan keterbatasan waktu sering kali menyebabkan asuhan postpartum diberikan secara tidak maksimal, terbatas pada aspek fisik saja, tanpa memperhatikan aspek psikososial yang tidak kalah pentingnya.

Tantangan lain yang tidak bisa diabaikan adalah rendahnya pemanfaatan hasil penelitian terbaru atau praktik berbasis bukti dalam layanan kesehatan maternal. Masih banyak tenaga kesehatan yang cenderung menggunakan pendekatan tradisional atau konvensional yang sudah usang, meskipun sudah tersedia rekomendasi praktik terbaik berbasis penelitian terkini. Hal ini menyebabkan kualitas asuhan pascapersalinan tidak sesuai dengan standar modern yang efektif dalam mencegah komplikasi serta mempercepat pemulihan ibu.

Di sisi lain, faktor sosial-budaya juga kerap menjadi tantangan besar dalam implementasi asuhan pascapersalinan modern. Kebiasaan, tradisi, atau mitos yang masih dipercaya secara turun-temurun dalam masyarakat sering kali bertentangan dengan praktik medis modern. Sebagai contoh, beberapa masyarakat masih percaya bahwa ibu pascapersalinan tidak boleh mandi selama beberapa hari atau minggu setelah melahirkan, padahal hal ini justru meningkatkan risiko infeksi. Demikian pula adanya kepercayaan tertentu yang membatasi asupan nutrisi tertentu bagi ibu setelah persalinan, yang berpotensi menghambat pemulihan fisik serta produksi ASI.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, strategi optimalisasi yang komprehensif perlu dirancang dan diterapkan secara sistematis oleh tenaga kesehatan. Strategi utama yang dapat diterapkan adalah meningkatkan edukasi kesehatan secara masif dan berkesinambungan, tidak hanya kepada ibu tetapi juga kepada keluarga serta masyarakat luas. Edukasi ini perlu mencakup pentingnya pemeriksaan postpartum rutin, tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai, serta pentingnya menjaga kesehatan fisik maupun psikologis selama masa pemulihan. Metode edukasi interaktif dan berbasis komunitas seperti kelas ibu hamil dan kelas ibu postpartum dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat secara lebih efektif.

Selain edukasi langsung, optimalisasi asuhan pascapersalinan modern juga dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi digital seperti telemidwifery atau telehealth. Strategi ini memungkinkan ibu mendapatkan akses langsung ke tenaga kesehatan profesional tanpa terhalang jarak geografis. Telekonsultasi secara online dapat menjadi solusi efektif dalam pemantauan kondisi kesehatan ibu dan bayi secara berkala, pemberian edukasi yang tepat, serta deteksi dini terhadap kemungkinan komplikasi yang muncul. Teknologi digital juga bisa digunakan sebagai sarana edukasi melalui aplikasi kesehatan ibu dan anak, yang menawarkan informasi terkini berbasis bukti yang akurat dan mudah diakses kapan saja.

Di samping itu, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan merupakan strategi penting dalam optimalisasi layanan pascapersalinan. Program pelatihan reguler, workshop, serta sertifikasi dalam penerapan asuhan berbasis bukti perlu diadakan secara rutin agar tenaga kesehatan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Dengan kompetensi yang lebih tinggi, tenaga kesehatan dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas, holistik, dan sesuai standar praktik terbaik yang telah terbukti secara ilmiah mampu menekan angka morbiditas dan mortalitas maternal.

Penguatan kolaborasi interprofesional juga menjadi strategi efektif dalam mengatasi tantangan yang ada. Kolaborasi yang erat antara dokter, bidan, perawat, psikolog, ahli gizi, serta tenaga kesehatan lainnya, memungkinkan terciptanya asuhan yang terpadu dan saling mendukung. Melalui kolaborasi ini, setiap aspek kebutuhan ibu pascapersalinan, baik fisik maupun psikososial, dapat terpenuhi dengan baik. Komunikasi tim yang rutin dan terstruktur melalui pertemuan koordinasi reguler juga memastikan tidak ada aspek penting dalam asuhan postpartum yang terlewatkan.

Terakhir, pendekatan sensitif budaya menjadi strategi penting lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam optimalisasi asuhan pascapersalinan modern. Tenaga kesehatan perlu memahami serta menghormati nilai-nilai budaya setempat, sembari tetap memberikan edukasi mengenai risiko yang mungkin timbul dari praktik yang bertentangan dengan prinsip medis. Dengan cara ini, ibu dan keluarga akan lebih mudah menerima praktik medis modern tanpa merasa bahwa budaya atau tradisi mereka diabaikan atau dihilangkan sepenuhnya.

Dengan implementasi berbagai strategi tersebut secara terpadu, maka kualitas asuhan pascapersalinan modern akan meningkat secara signifikan. Hal ini tidak hanya mampu menekan angka komplikasi postpartum, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi secara keseluruhan, serta menciptakan lingkungan keluarga yang lebih sehat, bahagia, dan harmonis.

J. Simpulan

Asuhan pascapersalinan modern merupakan pendekatan komprehensif yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik ibu dan bayi, tetapi juga mencakup perhatian serius terhadap aspek psikososial, emosional, serta kebutuhan edukasi yang berkesinambungan. Prinsip-prinsip dasar dalam asuhan ini, yaitu pendekatan holistik, praktik berbasis bukti, asuhan yang berpusat pada perempuan (*woman-centered care*), dan kontinuitas pelayanan (*continuity of care*), menjadi landasan utama yang memastikan pelayanan diberikan secara optimal dan responsif terhadap kebutuhan individu.

Komponen utama dari asuhan ini meliputi perawatan fisik secara menyeluruh, dukungan emosional yang intensif, edukasi keluarga yang berkelanjutan, serta pemantauan rutin kesehatan ibu dan bayi untuk mendeteksi dini komplikasi yang mungkin terjadi. Penerapan pendekatan berbasis bukti dalam praktik klinis sangat penting untuk memastikan bahwa semua tindakan dan intervensi telah terbukti efektif dan aman berdasarkan penelitian ilmiah terbaru.

Pemanfaatan teknologi modern, seperti telemidwifery, aplikasi kesehatan ibu, serta alat diagnostik canggih, semakin mendukung optimalisasi asuhan dengan meningkatkan akses, akurasi pemantauan, dan efektivitas komunikasi antara tenaga kesehatan dan ibu. Selain itu, perhatian khusus terhadap aspek psikososial melalui deteksi dini dan intervensi terhadap baby blues, kecemasan, dan depresi postpartum juga menjadi prioritas utama untuk menjaga kesehatan mental dan emosional ibu.

Kolaborasi interprofesional antar tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, psikolog, ahli gizi, dan tenaga profesional lainnya merupakan elemen vital dalam memberikan asuhan yang terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan. Sementara itu, peran edukasi terhadap ibu dan keluarga menjadi kunci dalam meningkatkan kemandirian dan kesiapan mereka menghadapi tantangan selama periode postpartum.

Walaupun berbagai tantangan masih ditemui, seperti rendahnya kesadaran keluarga, keterbatasan akses layanan, kurangnya pemanfaatan hasil penelitian terbaru, dan adanya hambatan budaya, berbagai strategi optimalisasi, seperti edukasi kesehatan secara masif, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, integrasi teknologi digital, kolaborasi interprofesional, serta pendekatan sensitif budaya, mampu secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan pascapersalinan.

Dengan demikian, implementasi asuhan pascapersalinan modern yang efektif dan terintegrasi tidak hanya mampu menekan risiko komplikasi postpartum, tetapi juga berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi serta menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera.

K. Referensi

- Bastable, S. B. (2019). *Nurse as educator: Principles of teaching and learning for nursing practice* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Bergström, A., & Lindmark, G. (2013). Evidence-based care in pregnancy and childbirth. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 120(2), 141-147. <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2012.11.021>
- Davidson, M. R., London, M. L., & Ladewig, P. W. (2021). *Olds' maternal-newborn nursing & women's health across the lifespan* (11th ed.). Pearson Education.

- Declercq, E. R., Sakala, C., Corry, M. P., Applebaum, S., & Herrlich, A. (2013). Listening to mothers III: Pregnancy and birth. Childbirth Connection.
- Dennis, C. L., & Dowswell, T. (2013). Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (2), CD001134. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001134.pub3>
- Henderson, J., Redshaw, M., & Quigley, M. A. (2019). Women's experience of maternity care: A population-based cross-sectional survey. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 19(1), 243. <https://doi.org/10.1186/s12884-019-2391-4>
- Howard, L. M., Molyneaux, E., Dennis, C. L., Rochat, T., Stein, A., & Milgrom, J. (2014). Non-psychotic mental disorders in the perinatal period. *The Lancet*, 384(9956), 1775-1788. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61276-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61276-9)
- Koblinsky, M., Moyer, C. A., Calvert, C., Campbell, J., Campbell, O. M., Feigl, A. B., ... & Graham, W. J. (2016). Quality maternity care for every woman, everywhere: A call to action. *The Lancet*, 388(10057), 2307-2320. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31333-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31333-2)
- Lavender, T., & Ebert, L. (2020). Midwifery-led care and the continuity of care model. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 65(4), 446-453. <https://doi.org/10.1111/jmwh.13100>
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, M. C., Alden, K. R., & Olshansky, E. (2020). *Maternity and women's health care* (12th ed.). Elsevier.
- Osman, H., Chaaya, M., El Zein, L., Naassan, G., & Wick, L. (2010). What do first-time mothers worry about? A study of usage patterns of an internet-based parenting support group. *Journal of Advanced Nursing*, 66(12), 2778-2787. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05422.x>
- Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F., ... & McCormick, F. (2014). Midwifery and quality care: Findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. *The Lancet*, 384(9948), 1129-1145. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60789-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60789-3)
- Ricci, S. S., Kyle, T., & Carman, S. (2021). *Maternity and pediatric nursing* (4th ed.). Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
- Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2016(4), CD004667. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub5>
- Simpson, K. R., & Creehan, P. A. (2020). *Perinatal nursing* (5th ed.). Wolters Kluwer.
- World Health Organization. (2014). *WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn*. World Health Organization.

World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. World Health Organization.

World Health Organization. (2019). WHO guideline: Recommendations on digital interventions for health system strengthening. World Health Organization.

World Health Organization. (2022). WHO recommendations for care of the preterm or low-birth-weight infant. World Health Organization.

L. Glosarium

Asuhan Pascapersalinan

Perawatan yang diberikan kepada ibu dan bayi selama periode setelah persalinan, yang bertujuan memastikan kesehatan fisik, emosional, serta adaptasi ibu terhadap peran baru.

Baby Blues

Gangguan emosional ringan yang muncul beberapa hari pertama setelah melahirkan, ditandai dengan perubahan suasana hati, kelelahan, perasaan sedih tanpa alasan jelas, dan mudah menangis.

Depresi Postpartum

Gangguan mental serius yang terjadi pascapersalinan, ditandai oleh perasaan sedih mendalam, kehilangan minat, perubahan pola tidur, gangguan konsentrasi, hingga munculnya pikiran melukai diri sendiri atau bayinya.

Pendekatan Holistik

Prinsip perawatan yang melihat individu secara keseluruhan meliputi aspek fisik, psikologis, emosional, sosial, dan spiritual dalam memberikan asuhan pascapersalinan.

Evidence-Based Practice (EBP)

Pendekatan dalam asuhan kebidanan yang mengacu pada hasil penelitian ilmiah terbaru yang valid dan relevan untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan efisiensi pelayanan.

Woman-Centered Care

Pendekatan perawatan kesehatan yang menjadikan ibu sebagai pusat pengambilan keputusan, memperhatikan kebutuhan, preferensi, dan latar belakang ibu secara personal dan unik.

Continuity of Care

Prinsip asuhan yang menekankan pelayanan berkesinambungan dari masa kehamilan, persalinan, hingga pascapersalinan, agar tenaga kesehatan mampu memantau secara mendalam kondisi kesehatan ibu dan bayi.

Telemidwifery

Penggunaan teknologi komunikasi seperti telepon, video call, atau aplikasi kesehatan digital dalam memberikan konsultasi, edukasi, serta pemantauan jarak jauh terhadap ibu pascapersalinan.

Skrining Psikologis Postpartum

Proses identifikasi dini gangguan psikologis pada ibu pascapersalinan, seperti depresi postpartum dan kecemasan, dengan alat bantu seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS).

Kolaborasi Interprofesional

Kerjasama antar tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu seperti dokter, bidan, perawat, psikolog, ahli gizi, fisioterapis, dan pekerja sosial dalam memberikan asuhan terpadu yang komprehensif untuk ibu dan bayi.

Dukungan Emosional

Pendampingan empatik oleh tenaga kesehatan dan keluarga, berupa konseling dan intervensi psikososial untuk membantu ibu mengelola perubahan emosional yang terjadi setelah persalinan.

Literasi Digital

Kemampuan ibu dan keluarga dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi kesehatan, telekonsultasi, dan sumber informasi digital untuk mendukung perawatan mandiri pascapersalinan.

Edukasi Pascapersalinan

Proses pemberian informasi, keterampilan praktis, serta pengetahuan kepada ibu dan keluarga agar mampu secara mandiri mengenali tanda bahaya postpartum, merawat bayi, serta menjaga kesehatan fisik dan psikologis ibu.

Pendekatan Sensitif Budaya

Strategi pelayanan kesehatan yang menghormati nilai-nilai dan praktik budaya masyarakat lokal, sambil tetap memberikan edukasi tentang praktik kesehatan berbasis bukti untuk meningkatkan penerimaan terhadap asuhan medis modern.

Komplikasi Postpartum

Masalah kesehatan yang muncul setelah persalinan, seperti perdarahan, infeksi, retensi plasenta, gangguan menyusui, hingga gangguan psikologis seperti depresi postpartum, yang memerlukan deteksi dini dan intervensi cepat.

CHAPTER 2

STRATEGI EFEKTIF MENDUKUNG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Rolita Efriani, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi merupakan rekomendasi global yang didukung oleh organisasi kesehatan dunia seperti WHO dan UNICEF. ASI eksklusif memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan bayi, seperti meningkatkan sistem imun, mengurangi risiko infeksi, dan mendukung perkembangan otak. Selain itu, menyusui juga memberikan manfaat bagi ibu, termasuk mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium, serta memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi (WHO, 2021).

Namun, meskipun manfaat ASI eksklusif telah banyak diketahui, tingkat pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih belum optimal. Data dari Riskesdas (2018) menunjukkan bahwa cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih berada di angka 65,8%, yang berarti masih jauh dari target nasional sebesar 80%. Berbagai faktor seperti kurangnya dukungan sosial, minimnya pengetahuan, masalah laktasi, serta tuntutan pekerjaan menjadi hambatan utama dalam mencapai keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dan komprehensif untuk mendukung para ibu dalam memberikan ASI eksklusif. Strategi ini tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan, tetapi juga dukungan dari keluarga, lingkungan kerja, pemerintah, dan masyarakat secara luas. Bab ini akan membahas berbagai strategi yang telah terbukti efektif dalam mendukung pemberian ASI eksklusif, mulai dari pendidikan kesehatan, dukungan konseling, kebijakan di tempat kerja, hingga peran teknologi dalam memudahkan akses informasi dan dukungan laktasi.

B. Pentingnya Pemberian ASI Eksklusif

Pemberian ASI eksklusif didefinisikan sebagai pemberian hanya ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih, kepada bayi sejak lahir hingga berusia enam bulan. ASI mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh kembang yang optimal, serta antibodi yang melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi (Kemenkes RI, 2020).

1. Manfaat ASI bagi Bayi

Banyak manfaat pemberian ASI khususnya ASI eksklusif yang dapat dirasakan. Menurut Roesli (2019), manfaatnya antara lain bagi bayi adalah :

a. ASI sebagai nutrisi

ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. ASI adalah makanan bayi yang paling sempurna, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dengan tata laksana menyusui yang benar, ASI sebagai makanan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh bayi normal sampai usia 6 bulan.

b. ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi

Bayi baru lahir secara alamiah mendapat imunoglobulin dari ibunya melalui ari-ari. Namun, kadar zat ini akan cepat sekali menurun segera setelah bayi lahir. Badan bayi baru membuat zat kekebalan cukup banyak pada waktu usia 9 sampai 12 bulan. Pada saat kekebalan bawaan menurun, sedangkan yang dibentuk oleh badan bayi belum mencukupi maka akan terjadi kesenjangan zat kekebalan pada bayi. Kesenjangan akan berkurang bila bayi di beri ASI, karena ASI adalah cairan hidup yang mengandung zat kekebalan yang akan melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi dan diare. Zat kekebalan itu terdapat dalam kolostrum.

c. ASI meningkatkan kecerdasan

Kecerdasan anak berkaitan erat dengan otak maka jelas bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan adalah pertumbuhan otak. Lemak pada ASI adalah lemak tak jenuh yang mengandung omega 3 untuk pematangan sel otak sehingga jaringan otak akan tumbuh secara optimal.

d. ASI meningkatkan jalinan kasih sayang

Bayi yang sering berada dalam dekapan ibu karena menyusui akan merasakan kasih sayang ibunya. Ia juga akan merasa aman dan tenteram. Perasaan terlindung dan disayangi inilah yang akan menjadi dasar perkembangan emosi bayi dan membentuk kepribadian yang percaya diri dan dasar spritual yang baik.

Penelitian menunjukkan bahwa bayi yang mendapat ASI eksklusif memiliki risiko lebih rendah untuk menderita diare, pneumonia, dan infeksi telinga dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif. Selain itu, ASI juga dikaitkan dengan perkembangan kognitif yang lebih baik dan penurunan risiko obesitas dan diabetes di kemudian hari (Victora et al., 2016).

Komposisi ASI yang unik dan spesifik sesuai kebutuhan bayi membuatnya menjadi makanan terbaik. Kolostrum yang dihasilkan pada hari-hari pertama setelah melahirkan kaya akan antibodi dan sel darah putih yang membantu melindungi bayi dari infeksi. ASI juga mengandung prebiotik yang mendukung perkembangan mikrobioma usus sehat pada bayi.

2. Manfaat ASI bagi Ibu

Menurut Roesli (2019) beberapa keuntungan bagi ibu antara lain :

- a. Mengurangi pendarahan setelah melahirkan
Ini karena pada saat ibu menyusui terjadi peningkatan kadar oksitosin yang berguna untuk penutupan pembuluh darah sehingga perdarahan akan berhenti.
- b. Menjarangkan kehamilan
Hal ini terjadi karena hisapan mulut bayi pada putting susu ibu merangsang ujung saraf sensorik sehingga post anterior hipofise mengeluarkan prolaktin. Prolaktin masuk ke indung telur, menekan produksi estrogen akibatnya tidak ada ovulasi. Selama ibu memberi ASI eksklusif dan belum haid, 98% tidak akan hamil pada 6 bulan pertama setelah melahirkan.
- c. Mengecilkan Rahim
Kadar oksitoksin ibu menyusui akan membantu rahim untuk kembali ke ukuran sebelum hamil.
- d. Penurunan Berat Badan
Dengan menyusui tubuh akan menghasilkan ASI lebih banyak sehingga timbunan lemak yang berfungsi sebagai cadangan tenaga akan terpakai. Sehingga berat badan ibu akan cepat kembali ke keadaan sebelum hamil.
- e. Mengurangi kemungkinan menderita kanker
Pada ibu menyusui yang memberikan ASI eksklusif kemungkinan akan mengurangi menderita kanker payudara dan kanker indung telur.
- f. Memberi kepuasan bagi ibu
Ibu yang berhasil memberikan ASI eksklusif akan merasakan kepuasan, kebanggaan, dan kebahagiaan yang mendalam.

Bagi ibu, menyusui membantu mempercepat pemulihan pascapersalinan dengan merangsang kontraksi rahim, mengurangi perdarahan, serta membantu menurunkan berat badan. Menyusui juga menurunkan risiko ibu terkena kanker payudara, ovarium, dan osteoporosis (CDC, 2020).

Dari segi ekonomi, pemberian ASI eksklusif dapat menghemat pengeluaran keluarga untuk pembelian susu formula dan perlengkapannya. Dari perspektif

lingkungan, ASI merupakan sumber makanan yang ramah lingkungan karena tidak memerlukan kemasan, pengolahan, atau transportasi.

3. Lama dan Frekuensi Menyusui

Sebaiknya menyusui bayi tanpa dijadwal (*on demand*), karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Cara ini dinamakan menyusui atas permintaan sendiri atau self demand feeding. Pemberian ASI yang tidak dibatasi ini akan merangsang produksi ASI dan membantu mencegah pembekakan payudara. Ibu harus menyusui bayinya bila bayinya menangis bukan karena sebab lain atau ibu sudah merasa perlu menyusui bayinya. Bayi yang sehat dapat mengosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit. Rata-rata bayi menyusui selama 5-15 menit, walaupun terkadang lebih dan ASI dalam lambung bayi akan kosong dalam waktu 2 jam. Rentang yang optimal dalam menyusui adalah antara 8 hingga 12 kali setiap hari.

Tiap kali menyusui, bayi hendaknya menyusui pada kedua payudara secara bergantian. Memberikan ASI dengan frekuensi tidak terbatas meningkatkan produksi ASI. Dengan demikian bayi bisa tumbuh optimal, masalah puting susu dan payudara berkurang, durasi menyusui pun bertambah panjang. Ibu perlu memahami bahwa dengan semakin bertambahnya umur bayi, jarak antara waktu menyusui dengan sendirinya akan bertambah panjang (Maryunani, 2012).

4. Kunci Utama Keberhasilan Menyusui

Agar pemberian ASI Eksklusif berhasil, hal yang paling utama perlu diperhatikan (Maryunani, 2012) adalah :

a. Perlekatan, dimana perlekatan merupakan kunci keberhasilan menyusui. Agar terjadi perlekatan yang benar, maka bagian areola masuk ke mulut bayi, sehingga mulut bayi dapat memerah ASI. Cara perlekatan yang baik :

- 1) Dagunya bayi menempel payudara ibu.
- 2) Mulut bayi terbuka lebar.
- 3) Bibir bawah bayi berputar ke bawah.
- 4) Sebagian besar areola masuk ke mulut bayi.

b. Cara Menyusui yang Baik dan Benar

Sebelum menyusui, ASI dikeluarkan sedikit dan dioleskan ke puting susu dan areola sekitarnya. Ini bermanfaat sebagai desinfektan dan menjaga kelembaban puting susu. Adapun cara menyusui yaitu :

- 1) Posisi ibu santai (duduk/berbaring)
- 2) Badan bayi menempel pada perut ibu
- 3) Dagunya bayi menempel pada payudara
- 4) Telinga dan lengan bayi berada dalam satu garis

- 5) Pegang bagian bawah payudara dengan 4 jari, ibu jari diletakkan di bagian atas payudara
- 6) Puting susu dan sebagian besar areola masuk ke mulut bayi
- 7) Perhatikan kebersihan tangan dan puting susu
- 8) Setelah bayi menyusui pada salah satu payudara sampai terasa kosong, sebaiknya ganti menyusui pada payudara yang lain
- 9) Menyusui berikutnya mulai dari payudara yang belum terkosongkan (yang dihisap terakhir)
- 10) Setelah selesai menyusui, bayi disendawakan dengan tujuan mengeluarkan udara dari lambung supaya bayi tidak muntah.

5. Dampak Tidak Diberikan ASI Eksklusif

Pada Bayi Dapat menyebabkan hubungan antara ibu dan bayi berkurang keeratannya, meningkatkan insiden penyakit diare, menyebabkan malnutrisi dan obesitas. Komposisi ASI sangat tepat dan ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi (Nugroho, 2011). Suatu penelitian di New Zealand melaporkan bahwa IQ (*Intelligence Qoutient*) pada bayi yang diberikan ASI selama 8 bulan lebih tinggi yaitu sebesar 1,5 - 4,5 point dibandingkan bayi yang mendapatkan susu formula. Salah satu faktor penentu kecerdasan anak adalah nutrisi yaitu dengan pemberian ASI sejak lahir.

6. Tantangan dalam Pemberian ASI Eksklusif

Meskipun memiliki banyak manfaat, banyak ibu yang menghentikan pemberian ASI eksklusif sebelum bayi berusia enam bulan. Faktor-faktor seperti persepsi ASI tidak cukup, puting sakit, kurangnya dukungan dari keluarga atau tenaga kesehatan, serta tekanan untuk kembali bekerja menjadi penyebab utama kegagalan pemberian ASI eksklusif (Prawirohardjo, 2018). Hasil penelitian Damayanti & Nurhaeni (2021), menunjukkan bahwa 65% ibu menyusui mengalami kesulitan dalam minggu-minggu pertama menyusui, dan tanpa dukungan yang tepat, banyak yang akhirnya beralih ke susu formula. Oleh karena itu, pemahaman tentang tantangan-tantangan ini penting untuk merancang strategi dukungan yang efektif.

Hasil penelitian Rolita Efriani & Dhesi Ari Astuti (2020), menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pemberian ASI eksklusif meliputi usia ibu yang terlalu muda (<20 tahun) atau terlalu tua (>35 tahun), yang cenderung tidak memberikan ASI eksklusif, serta faktor pekerjaan ibu di luar rumah yang membatasi waktu dan kesempatan untuk menyusui secara langsung. Ibu yang bekerja sering kali menghadapi kendala seperti cuti melahirkan yang singkat (hanya 12 minggu), jarak tempat kerja yang jauh, kurangnya fasilitas menyusui atau pemerah ASI di tempat kerja, serta jadwal kerja yang tidak fleksibel.

Sejalan dengan penelitian Rahadian (2014), menunjukkan bahwa tantangan utama pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja bukan hanya terletak pada fasilitas fisik, tetapi juga pada lingkungan sosial dan kebijakan yang belum mendukung. Sebagian besar tempat kerja tidak menyediakan ruang laktasi yang layak, memaksa ibu untuk memerah ASI di tempat yang tidak nyaman dan tidak higienis seperti toilet, kubikel tanpa privasi, atau ruang rapat. Ibu bekerja seringkali mendapatkan komentar negatif, sindiran, dan kurangnya dukungan dari rekan kerja dan atasan, yang menimbulkan tekanan psikologis dan dapat menurunkan produksi ASI. Selain itu, Ibu menghadapi kesulitan dalam menyimpan dan membawa pulang ASI perah dengan aman akibat tidak tersedianya fasilitas pendukung seperti kulkas kantor yang dapat digunakan. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, termasuk di lingkungan kerja, tentang pentingnya ASI eksklusif menjadi hambatan besar bagi ibu untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan. Oleh karena itu, Perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung ibu menyusui.

Relevan dengan penelitian Asnidayati & Ramdhan (2021), menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pemberian ASI eksklusif berasal dari berbagai faktor, yaitu faktor sosiodemografi, kesehatan dan fasilitas kesehatan, persepsi ibu, pengetahuan, sosial budaya, serta lingkungan. Beban kerja domestik dan jadwal kerja yang padat seringkali memaksa ibu untuk kembali bekerja, sehingga menyulitkan mereka untuk memerah ASI dan mempertahankan produksinya. Kurangnya dukungan dari tempat kerja, seperti tidak tersedianya ruang laktasi yang memadai dan kebijakan atasan yang tidak mendukung, menjadi penghambat signifikan bagi ibu bekerja. Persepsi yang salah bahwa ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, serta keyakinan bahwa bayi laki-laki membutuhkan lebih banyak ASI, sering kali menyebabkan pemberian makanan tambahan sebelum bayi berusia 6 bulan. Serta dukungan keluarga, terutama dari suami, ibu, dan mertua, yang kurang optimal dapat menjadi penghalang besar, karena keluarga sering kali memiliki keyakinan tradisional yang bertentangan dengan prinsip ASI eksklusif.

C. Strategi Edukasi dan Konseling bagi Ibu dan Keluarga

Edukasi dan konseling menyusui merupakan strategi kunci dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik pemberian ASI eksklusif. Intervensi ini dapat diberikan sejak masa kehamilan, pascapersalinan, hingga selama masa menyusui.

1. Kelas Antenatal untuk Menyusui

Edukasi selama kehamilan melalui kelas antenatal dapat mempersiapkan calon ibu dan keluarga tentang pentingnya ASI, teknik menyusui yang benar, dan cara mengatasi masalah umum menyusui. Hasil penelitian Andayani, Emilia & Ismail (2017), menunjukkan bahwa kelas ibu hamil (antenatal class) berperan signifikan dalam meningkatkan pemberian ASI eksklusif dengan memberikan edukasi tentang pentingnya ASI, teknik menyusui, perawatan bayi, serta dukungan psikologis yang mempersiapkan ibu untuk menyusui secara eksklusif. Ibu yang mengikuti kelas ibu hamil memiliki peluang 1,86 kali lebih tinggi untuk memberikan ASI eksklusif dibandingkan dengan yang tidak mengikutinya, bahkan setelah dikontrol oleh faktor dukungan suami dan kunjungan ANC.

Kelas ibu hamil secara langsung berpengaruh positif terhadap pemberian ASI eksklusif. Meskipun kontribusinya hanya sekitar 10% dalam model multivariat (bersama dukungan suami dan ANC), kelas ibu hamil terbukti menjadi intervensi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan praktik menyusui eksklusif. Dukungan suami juga merupakan faktor penting yang memperkuat keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan promosi kelas ibu hamil serta melibatkan keluarga, terutama suami, dalam program edukasi menyusui. Sejalan dengan penelitian oleh Siregar et al. (2021), menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengikuti kelas edukasi laktasi memiliki tingkat kepercayaan diri dan keberhasilan menyusui yang lebih tinggi. Kelas antenatal sebaiknya mencakup:

- a. Informasi tentang manfaat ASI bagi ibu dan bayi.
- b. Teknik menyusui yang benar (posisi dan perlekatan)
- c. Manajemen laktasi dan cara mempertahankan produksi ASI.
- d. Cara mengatasi masalah umum menyusui (puting lecet, mastitis, dll).
- e. Pentingnya Inisiasi Menyusui Dini (IMD).
- f. Dukungan untuk ibu bekerja yang akan menyusui.

2. Konseling Laktasi Pascapersalinan

Dukungan konseling dari konselor laktasi atau bidan segera setelah persalinan sangat penting untuk memastikan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) berhasil dan membantu ibu dalam posisi dan perlekatan yang benar. Penelitian Ambarwati, Muis & Susanti (2013), menunjukkan bahwa intervensi berupa konseling laktasi intensif pascapersalinan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencapaian pemberian ASI eksklusif. Kelompok ibu yang menerima konseling laktasi intensif menunjukkan tingkat keberhasilan pemberian ASI eksklusif yang jauh lebih tinggi hingga bayi berusia 3 bulan dibandingkan dengan kelompok ibu yang hanya menerima perawatan atau edukasi standar. Hal

ini menunjukkan bahwa dukungan berkelanjutan, pemecahan masalah secara aktif, dan edukasi mendalam yang diberikan melalui konseling laktasi merupakan faktor kunci dalam mengatasi hambatan awal menyusui dan meningkatkan kepercayaan diri ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif. Konseling pascapersalinan harus mencakup:

- a. Bantuan langsung dengan teknik menyusui segera setelah persalinan.
- b. Pemantauan frekuensi dan durasi menyusui.
- c. Evaluasi kecukupan ASI (melalui pertumbuhan bayi dan frekuensi BAK/BAB).
- d. Dukungan emosional untuk mengatasi kecemasan dan kelelahan ibu baru.
- e. Penanganan masalah menyusui yang mungkin timbul.

3. Pendekatan Peer Counselor

Dukungan dari ibu lain yang telah berhasil menyusui (*peer counselor*) terbukti efektif memberikan motivasi dan solusi praktis berdasarkan pengalaman. Program *peer counselor* mampu meningkatkan cakupan ASI eksklusif dari 60% menjadi 78% dalam kurun waktu enam bulan (Kusuma & Fitri, 2020). Penelitian oleh Aritonang dkk. (2023), menunjukkan bahwa edukasi melalui pendekatan *peer counseling* merupakan strategi yang sangat berhasil untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang teknik peningkatan produksi ASI. Keberhasilan ini disebabkan karena metode ini memanfaatkan kedekatan emosional dan kesamaan status antara konselor (teman sebaya) dengan ibu-ibu yang dibimbing, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih percaya, nyaman, dan relatable. Dukungan dari seseorang yang telah mengalami proses yang sama dirasakan lebih membumi dan memotivasi, yang pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan pemberian ASI eksklusif.

Sejalan dengan penelitian Lumbantoruan, Sirait & Sidabukke (2023), menunjukkan bahwa edukasi teman sebaya (*peer education/counselor*) merupakan suatu intervensi yang efektif untuk secara signifikan meningkatkan *breastfeeding self-efficacy* (keyakinan diri ibu dalam menyusui) pada ibu hamil dan menyusui. Dukungan dari sesama ibu yang telah berpengalaman dan terlatih terbukti dapat membangun kepercayaan diri, memberikan contoh nyata yang relatable, serta menciptakan lingkungan supportif yang pada akhirnya mendukung keberhasilan praktik pemberian ASI eksklusif. *Peer counselor* dapat memberikan:

- a. Dukungan emosional dan motivasi berdasarkan pengalaman nyata.
- b. Solusi praktis untuk masalah menyusui sehari-hari.
- c. Jejaring dukungan antar ibu menyusui.
- d. Informasi yang mudah dipahami dalam bahasa yang sederhana.

4. Pendidikan untuk Keluarga dan Suami

Dukungan keluarga, terutama suami, merupakan faktor penting dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Pendidikan untuk keluarga tentang pentingnya ASI dan cara mendukung ibu menyusui dapat meningkatkan keberhasilan program ASI eksklusif. Penelitian Muchsin (2024), Dukungan suami memiliki peran yang sangat krusial dan signifikan dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Dukungan ini bersifat multidimensi, tidak hanya sekadar dukungan moral (seperti memberikan semangat dan pujian), tetapi juga dukungan informasi, instrumental, emosional dan dukungan pengambilan keputusan. keberhasilan ASI eksklusif bukanlah tanggung jawab ibu seorang diri, melainkan hasil dari kerja tim dalam keluarga, di mana suami berperan sebagai "key supporter" utama. Oleh karena itu, intervensi pendidikan dan promosi kesehatan tentang ASI eksklusif harus menyasar tidak hanya ibu, tetapi juga melibatkan suami dan anggota keluarga lainnya. Peran suami dan keluarga dalam mendukung ibu menyusui meliputi:

- a. Memberikan dukungan emosional dan motivasi.
- b. Membantu tugas rumah tangga agar ibu dapat beristirahat cukup.
- c. Membantu dalam perawatan bayi selain menyusui.
- d. Membantu mengatasi masalah menyusui dengan mencari informasi atau bantuan profesional.

D. Kebijakan dan Dukungan di Tempat Kerja

Banyak ibu pekerja yang terpaksa menghentikan pemberian ASI eksklusif karena tidak adanya dukungan dan fasilitas memadai di tempat kerja. Implementasi kebijakan yang mendukung ibu menyusui sangat penting untuk memungkinkan mereka terus memberikan ASI.

1. Cuti Melahirkan yang Memadai

Durasi cuti melahirkan yang cukup (minimal 3-6 bulan) memungkinkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif tanpa terburu-buru kembali bekerja. Studi menunjukkan hubungan positif antara lamanya cuti melahirkan dengan keberlanjutan pemberian ASI (Nurhayati, 2019).

Di Indonesia, hak cuti melahirkan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), terutama Pasal 82, dan diperkuat oleh Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU No. 4 Tahun 2024 tentang KIA). Pekerja perempuan berhak atas istirahat selama minimal 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan (total 3 bulan). UU KIA juga memungkinkan perpanjangan cuti hingga total 6 bulan dalam kondisi kesehatan khusus ibu atau anak.

2. Fasilitas Ruang Laktasi (*Lactation Room*)

Penyediaan ruang laktasi yang nyaman, bersih, dan privat di tempat kerja memungkinkan ibu untuk memompa dan menyimpan ASI selama jam kerja. Penelitian di beberapa perusahaan di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan ruang laktasi meningkatkan motivasi ibu untuk terus memerah ASI (Wulandari & Pratama, 2021). Hasil penelitian Mahdang & Ahmad (2021), menunjukkan bahwa fasilitas ruang laktasi yang memadai dan lengkap merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada pekerja wanita. Meskipun ruang laktasi tersedia, ketidaklengkapan fasilitas (seperti tempat penyimpanan ASI, alat pompa, dan kenyamanan ruangan) dapat mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk menyediakan dan melengkapi ruang laktasi guna mendukung para ibu pekerja dalam memberikan ASI eksklusif. Standar ruang laktasi yang baik meliputi:

- a. Ruangan privat yang terkunci dan bebas dari gangguan.
- b. Kursi yang nyaman dan meja untuk tempat pompa ASI.
- c. Stop kontak untuk pompa listrik.
- d. Washtafel atau fasilitas untuk mencuci tangan dan peralatan.
- e. Lemari es khusus untuk menyimpan ASI perah.
- f. Informasi tentang menyusui dan memompa ASI.

3. Fleksibilitas Waktu dan Budaya Kerja yang Supportif

Kebijakan kerja fleksibel atau waktu istirahat khusus untuk memompa ASI dapat sangat membantu. Dukungan dari atasan dan rekan kerja juga berperan besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung ibu menyusui. Penelitian Savitri, Aisyiyah & Mansyur (2024), menunjukkan bahwa dukungan berupa fleksibilitas waktu dan budaya kerja yang mendukung menyusui merupakan faktor kritis dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja. Implementasi kebijakan yang memfasilitasi waktu istirahat yang cukup dan penyediaan fasilitas laktasi yang layak dapat meningkatkan tingkat ASI eksklusif, sementara ketiadaan dukungan tersebut justru menjadi penghambat signifikan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar mendukung praktik menyusui. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan:

- a. Waktu istirahat khusus untuk memompa ASI (2-3 kali selama jam kerja)
- b. Fleksibilitas jam kerja atau work from home untuk ibu menyusui
- c. Pengurangan beban kerja sementara selama masa menyusui
- d. Pelatihan untuk manajer dan staf tentang pentingnya dukungan menyusui di tempat kerja.

4. Kebijakan Corporate Parenting

Beberapa perusahaan telah menerapkan kebijakan corporate parenting yang lebih komprehensif, termasuk:

- a. Program pendampingan untuk ibu bekerja yang kembali setelah cuti melahirkan.
- b. Layanan konseling laktasi di tempat kerja.
- c. Child care center di dekat tempat kerja.
- d. Support group untuk orang tua bekerja.

E. Peran Teknologi dan Inovasi Digital dalam Mendukung Menyusui

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang baru untuk memberikan dukungan menyusui yang lebih mudah diakses, terutama di era digital seperti sekarang.

1. Aplikasi Mobile untuk Pemantauan Menyusui

Aplikasi mobile pemantauan menyusui berfungsi sebagai asisten digital yang membantu ibu mencatat jadwal menyusui, durasi, dan payudara yang digunakan terakhir. Penelitian Setyawan et al. (2024), menunjukkan bahwa aplikasi mobile "EdBusui" dikembangkan sebagai sebuah alat inovatif untuk memantau dan mendukung praktik pemberian ASI eksklusif guna mencegah stunting di Desa Paseh Kaler. Aplikasi ini berfungsi sebagai media edukasi yang memberikan informasi lengkap tentang menyusui, serta memudahkan ibu dalam mencatat dan memantau jadwal pemberian ASI, tumbuh kembang bayi, dan konsumsi makanan pendamping ASI (MPASI), sehingga membantu meningkatkan peran serta ibu dalam pemberian gizi yang optimal pada anak.

Sejalan dengan penelitian Virgiani dkk. (2023), menunjukkan bahwa aplikasi mobile "Menyusui Asi-Q" berperan sebagai inovasi digital yang efektif dalam mendukung program ASI eksklusif. Aplikasi ini berhasil diterapkan sebagai sarana edukasi, pemantauan, dan motivasi bagi ibu menyusui. Dengan fitur-fitur yang memudahkan ibu dalam mencatat dan memantau proses menyusui serta perkembangan bayi, aplikasi ini membantu meningkatkan pengetahuan, disiplin, dan kepercayaan diri ibu. Selain itu, aplikasi ini juga menjadi alat bantu yang valuable bagi tenaga kesehatan di puskesmas untuk melakukan pendampingan dan pemantauan dari jarak jauh, sehingga pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif di komunitas sasaran.

2. Konsultasi Online dengan Konselor Laktasi

Layanan telekonsultasi atau chat dengan konselor laktasi bersertifikat memungkinkan ibu untuk mendapatkan bantuan profesional kapan saja dan di mana saja, mengatasi kendala keterbatasan jarak dan waktu. Penelitian Okinarum

& Mulyani (2022), menunjukkan bahwa konsultasi laktasi online secara real-time merupakan strategi promosi kesehatan yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan dukungan bagi ibu menyusui. Penggunaan teknologi, dalam hal ini aplikasi mobile Ruang Sehati, berhasil mempermudah akses ibu untuk berkonsultasi dengan konselor laktasi profesional, mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Dukungan yang cepat dan langsung dari tenaga ahli melalui konsultasi online dapat meningkatkan pengetahuan, kepercayaan diri, dan kemampuan ibu dalam mengatasi masalah menyusui, yang pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

Sejalan dengan penelitian Cahyani (2022), menunjukkan bahwa edukasi melalui telelaktasi (konsultasi laktasi online) merupakan intervensi yang efektif untuk meningkatkan kesiapan ibu postpartum dalam memberikan ASI. Tinjauan literatur dalam jurnal tersebut menemukan bahwa akses terhadap konselor laktasi secara daring dapat mengatasi hambatan jarak dan waktu, memberikan dukungan yang berkelanjutan, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis ibu dalam manajemen laktasi. Peningkatan aspek-aspek ini secara langsung berkorelasi dengan peningkatan keyakinan diri ibu dan kemungkinan yang lebih besar untuk dapat memberikan ASI secara eksklusif. Bentuk konsultasi online yang tersedia:

- a. Konsultasi video call dengan konsultan laktasi.
- b. Layanan chat 24 jam untuk pertanyaan mendesak.
- c. Grup webinar tentang topik-topik spesifik menyusui.
- d. Platform berbagi foto/video untuk evaluasi teknik menyusui.

3. Komunitas dan Grup Dukungan Online

Grup media sosial (seperti Facebook atau WhatsApp) yang beranggotakan ibu menyusui dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, saling memotivasi, dan bertanya. Dukungan sosial dari komunitas online ini dapat mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan kepercayaan diri ibu (Lestari, 2022). Penelitian Efriani & Astuti (2021), menunjukkan bahwa dukungan suami memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Penelitian tersebut menyoroiti bahwa informasi dan dukungan emosional adalah faktor kunci. Dalam konteks modern, grup dukungan online (seperti melalui media sosial atau aplikasi percakapan) dapat menjadi platform yang efektif untuk saling berbagi pengalaman, memecahkan masalah menyusui, dan memberikan motivasi antar ibu, yang pada akhirnya dapat memperkuat upaya pemberian ASI eksklusif, terutama bagi ibu yang mungkin tidak mendapatkan dukungan maksimal dari lingkungan terdekatnya. Manfaat komunitas online untuk ibu menyusui:

- a. Dukungan emosional dari sesama ibu yang mengalami hal serupa
- b. Berbagi pengalaman dan solusi praktis
- c. Akses informasi yang cepat dan relevan
- d. Jejaring dengan ibu-ibu di daerah yang sama untuk pertemuan offline.

4. Teknologi Pompa ASI dan Perlengkapannya

Perkembangan teknologi juga terlihat dalam inovasi pompa ASI dan perlengkapannya:

- a. Pompa ASI elektrik yang lebih efisien dan nyaman.
- b. Pompa ASI portabel yang dapat digunakan tanpa menarik perhatian.
- c. Kantong penyimpanan ASI dengan indicator suhu dan tanggal.
- d. Teknologi pasteurisasi ASI perah di rumah.
- e. Aplikasi pemantauan suhu lemari es penyimpanan ASI.

Penelitian Nuzula dkk. (2022), menunjukkan bahwa teknologi pompa ASI dan perlengkapannya (seperti botol, tas cooler, dan kantong penyimpanan ASI) berperan sebagai fasilitator penting yang memungkinkan ibu untuk mempertahankan produksi ASI, menjaga ketersediaan stok ASI perah (ASIP) meski terpisah dari bayi, dan dengan demikian secara signifikan mendukung keberlangsungan pemberian ASI eksklusif. Teknologi ini sangat krusial bagi ibu yang harus kembali bekerja setelah cuti melahirkan, sehingga mereka dapat terus memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Teknologi pompa ASI merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang sangat berharga untuk mewujudkan kesadaran masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dengan memberi mereka kemandirian dan pilihan dalam memberikan nutrisi terbaik bagi anaknya.

Sejalan dengan penelitian Wulandari, dkk. (2018), menunjukkan bahwa penggunaan teknologi pompa ASI dan perlengkapannya merupakan faktor penunjang yang sangat penting bagi keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja, khususnya perawat. Dengan memompa secara rutin selama jam kerja, produksi ASI tetap lancar dan mencegah engorgement (pembengkakan payudara). ASI yang dipompa dapat disimpan dalam botol dan cooler bag yang didinginkan, sehingga dapat diberikan kepada bayi oleh pengasuh ketika ibu sedang bekerja. Teknologi ini menjadi solusi atas ketidakmampuan ibu untuk menyusui langsung selama berada di rumah sakit, sehingga komitmen untuk memberikan ASI eksklusif tetap dapat terpenuhi.

F. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Kampanye ASI Eksklusif

Peningkatan cakupan ASI eksklusif memerlukan komitmen dan sinergi dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.

1. Advokasi dan Regulasi

Advokasi dan regulasi dalam pemberian ASI eksklusif di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, terutama melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Berdasarkan penelitian Gunadi (2018), advokasi dan regulasi (dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif) memainkan peran krusial namun menghadapi tantangan signifikan dalam implementasinya.

Advokasi dari tenaga kesehatan dan kader posyandu terbukti efektif meningkatkan pemahaman ibu tentang pentingnya ASI eksklusif, sementara regulasi berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bayi dengan membatasi promosi dan pemasaran susu formula yang tidak etis. Namun, implementasi kedua aspek ini belum optimal akibat lemahnya pengawasan, sanksi yang tidak tegas bagi pelanggar, serta masih maraknya praktik promosi susu formula secara langsung maupun tidak langsung ke masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang melindungi hak ibu menyusui, seperti Peraturan Pemerintah tentang Pemasaran Pengganti ASI dan mewajibkan fasilitas umum dan tempat kerja menyediakan ruang laktasi. Regulasi yang diperlukan meliputi:

- a. Penguatan implementasi Peraturan Pemerintah tentang Pemasaran Pengganti ASI.
- b. Wajibnya ruang laktasi di tempat kerja dengan jumlah karyawan tertentu.
- c. Insentif bagi perusahaan yang menerapkan kebijakan ramah menyusui.
- d. Integrasi dukungan menyusui dalam program jaminan kesehatan nasional.

2. Kampanye Nasional dan Sosialisasi

Kampanye media massa dan media sosial tentang pentingnya ASI eksklusif perlu digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Berdasarkan penelitian Ekawati dkk. (2015), kampanye nasional dan upaya sosialisasi Program Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif dilaksanakan melalui berbagai metode, antara lain penyuluhan langsung di posyandu, pembagian booklet dan leaflet informatif, serta pemasangan spanduk dan banner di lokasi-lokasi strategis.

Sejalan dengan penelitian Budi Syahputri dan Dzul Akmal (2018), kampanye nasional dan kegiatan sosialisasi pemberian ASI eksklusif yang diimplementasikan oleh petugas Puskesmas meliputi berbagai upaya, seperti penyuluhan langsung kepada ibu hamil dan menyusui di posyandu, kelas ibu hamil, serta melalui media poster dan leaflet yang dipasang di lingkungan puskesmas dan fasilitas kesehatan

lainnya. Peran aktif petugas puskesmas melalui sosialisasi dan kampanye merupakan faktor pendorong utama dalam meningkatkan cakupan ASI eksklusif. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada puskesmas, tetapi juga memerlukan komitmen berkelanjutan dan kolaborasi dari semua pihak untuk mengatasi hambatan budaya dan struktural yang ada. Kampanye yang melibatkan public figure atau influencer dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Strategi kampanye yang efektif:

- a. Kampanye media massa dengan pesan yang jelas dan konsisten.
- b. Pemanfaatan media sosial dan influencer untuk menjangkau generasi muda.
- c. Integrasi edukasi ASI dalam kurikulum pendidikan kesehatan.
- d. Program sertifikasi "Tempat Ramah Menyusui" untuk fasilitas publik dan tempat kerja.

3. Pelatihan Tenaga Kesehatan

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya bidan dan perawat, dalam memberikan konseling laktasi yang tepat dan berbasis bukti sangat penting untuk memastikan ibu mendapatkan informasi yang benar sejak awal. Penelitian Novitasari & Rosita (2022), menunjukkan bahwa pelatihan konseling pemberian ASI eksklusif bagi tenaga kesehatan merupakan intervensi yang sangat efektif dan strategis. Pelatihan ini berhasil meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pendampingan dan edukasi yang tepat kepada ibu menyusui. Dengan demikian, upaya promosi ASI eksklusif menjadi lebih optimal, yang pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap pencegahan stunting sejak dini pada bayi.

Sejalan dengan penelitian Prihandani (2021), menunjukkan bahwa pelatihan konseling laktasi bagi tenaga kesehatan merupakan intervensi strategis yang terbukti secara signifikan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri mereka dalam memberikan dukungan serta edukasi yang komprehensif kepada ibu untuk mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Program pelatihan yang diperlukan:

- a. Sertifikasi konsultan laktasi untuk tenaga kesehatan.
- b. Integrasi materi konseling laktasi dalam kurikulum pendidikan kesehatan.
- c. Pelatihan berkelanjutan tentang teknik konseling dan manajemen laktasi terbaru.
- d. Supervisi dan pendampingan untuk tenaga kesehatan di daerah terpencil.

4. Dukungan untuk Ibu di Daerah Terpencil dan Kelompok Rentan

Perhatian khusus perlu diberikan kepada ibu di daerah terpencil dan kelompok rentan yang mungkin menghadapi hambatan lebih besar dalam pemberian ASI eksklusif. Program khusus yang dapat dilakukan:

- e. Layanan konseling laktasi keliling untuk daerah terpencil.
- f. Program pendampingan oleh kader kesehatan setempat.
- g. Bantuan transportasi untuk akses ke fasilitas kesehatan.
- h. Dukungan nutrisi untuk ibu menyusui dari keluarga kurang mampu.

G. Kesimpulan

Pemberian ASI eksklusif adalah investasi terbaik untuk kesehatan bayi dan ibu di masa depan. Mencapai target ASI eksklusif memerlukan pendekatan yang multi-sektor dan holistik. Strategi efektif yang meliputi edukasi berkelanjutan, konseling profesional, dukungan tempat kerja, pemanfaatan teknologi, serta komitmen kuat dari pemerintah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan. Dengan implementasi strategi-strategi tersebut secara sinergis, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang benar-benar mendukung setiap ibu untuk berhasil memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

H. Daftar Pustaka

- Ambarwati, R., Muis, S. F., & Susanti, P. (2013). Pengaruh konseling laktasi intensif terhadap pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif sampai 3 bulan. *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)*, 2(1).
- Andayani, D., Emilia, O., & Ismail, D. (2017). Peran kelas ibu hamil terhadap pemberian ASI Eksklusif di Gunung Kidul. *Berita kedokteran masyarakat*, 33(7), 317-324.
- Aritonang, J., Dewi, N. N. S. A., & Brahmana, N. B. (2023). Peningkatan Pengetahuan Cara Peningkatan Produksi ASI Melalui Edukasi Konseling Teman Sebaya (Peer Counseling). *JOMIS (Journal of Midwifery Science)*, 7(1), 79-85.
- Asnidayati, A., & Ramdhan, S. (2021). Hambatan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 10(1), 156–161.
- Budi Syahputri, R., & Dzul Akmal, S. K. M. (2018). Peran Petugas Puskesmas Dalam Sosialisasi, Edukasi, Dan Kampanye Untuk Meningkatkan Cakupan Asi Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Gilingan Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Cahyani, C. (2022). Efektifitas Edukasi Telelaktasi Meningkatkan Kesiapan Ibu Post Partum dalam Memberikan ASI: Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia*, 3(1), 71-78.

- Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Breastfeeding report card. Atlanta: CDC.
- Damayanti, R., & Nurhaeni, N. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pemberian ASI eksklusif. *Jurnal Kebidanan*, 10(2), 123-134.
- Efriani, R., & Astuti, D. A. (2021). The relationship husband's support and exclusive breastfeeding in the work area of Umbulharjo 1 public health center, Yogyakarta City. *International Journal of Health Science and Technology*, 2(2), 1-7.
- Gunadi, S. S. T. (2018). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Asi Eksklusif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Bayi Terhadap Promosi Susu Formula Bayi di Kota Palembang (Doctoral dissertation, Unika Soegijapranata Semarang).
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran: Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kusuma, W., & Fitri, A. (2020). Dampak program peer counselor terhadap peningkatan cakupan ASI eksklusif. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*, 14(2), 89-98.
- Lestari, W. (2022). Aplikasi Monitoring Antenatal Care Ibu Hamil Dengan Perangkat Mobile Di Pelayanan Kesehatan: Literatur Review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Insan Sehat*, 10(1), 45-50.
- Lumbantoruan, M., Sirait, A., & Sidabukke, I. (2023). Peningkatan Breasfeeding Self Efficacy Melalui Edukasi Teman Sebaya (Peer Education). *JOMIS (Journal of Midwifery Science)*, 7(1), 86-91.
- Mahdang, P. A., & Ahmad, Z. F. (2021). Pengaruh Sikap, Pengetahuan, dan Fasilitas Perusahaan terhadap Pemberian ASI Eksklusif oleh Pekerja Wanita. *Madu: Jurnal Kesehatan*, 10(2), 26-33.
- Maryunani, A. (2012). Inisiasi Menyusu Dini, ASI Eksklusif dan Manajemen Laktasi. Jakarta: Trans Info Media.
- Muchsin, E. N. (2024). Dukungan Suami Pada Pelaksanaan Pemberian ASI Eksklusif. *Health Care*, 13(1), 38-46.
- Novitasari, R., & Rosita, E. (2022). Refresh Upaya Pencegahan Stunting Pada Bayi Dengan Pelatihan Konseling Pemberian Asi Eksklusif Di Dinas Kesehatan Jombang Tahun 2022. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 4(2), 21-28.

- Nugroho, T. (2011). ASI dan Tumor Payudara. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Nurhayati, S. (2019). Hubungan lama cuti melahirkan dengan keberlanjutan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 8(3), 201-210.
- Nuzula, F., Oktaviana, M. N., & Purwitaningtyas, R. Y. (2022). Membangun Kesadaran dalam Mendukung Keberlangsungan Pemberian ASI Eksklusif Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan. *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 89-102.
- Okinarum, G. Y., & Mulyanib, S. H. Promosi ASI Eksklusif Melalui Konsultasi Laktasi Secara Real-Time-Online Menggunakan Ruang Sehati Mobile Application di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta.
- Prawirohardjo, S. (2018). Ilmu Kebidanan. Jakarta: PT Bina Pustaka.
- Prihandani, O. R. (2021, December). Pelatihan Konseling Laktasi Tenaga Kesehatan untuk Mendukung Keberhasilan ASI Eksklusif. In *Prosiding Seminar Nasional Unimus* (Vol. 4).
- Rahadian, A. S. (2014). Pemenuhan hak ASI eksklusif di kalangan ibu bekerja: peluang dan tantangan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 9(2), 107-116.
- Roesli, U. (2009). Mengenal ASI Eksklusif. Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Rolita Efriani, R. E., & Dhesi Ari Astut, D. A. A. (2020). Hubungan umur dan pekerjaan ibu menyusui dengan pemberian ASI eksklusif. *Jurnal Kebidanan*, 9(2), 153-162.
- Savitri, W., Aisyiyah, N., & Mansyur, H. (2024). Analisis Kebijakan dan Dukungan Tempat Kerja terhadap Praktik Pemberian ASI Eksklusif bagi Ibu Bekerja: Literatur Review. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)*, 9(2).
- Setyawan, A. B., Herlina, N., Ekowati, E., Nawangsari, S., & Nugroho, W. (2024). Pencegahan Stunting Dengan Menggunakan Aplikasi Mobile Edbusui Pada Ibu Dan Anak Di Desa Paseh Kaler. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 3(2), 1-5.
- Siregar, A. A., Lubis, Z., & Siregar, R. (2021). Pengaruh kelas edukasi laktasi selama kehamilan terhadap pengetahuan dan praktik menyusui. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Tradisional*, 6(1), 34-42.

- Victora, C. G., Bahl, R., Barros, A. J., França, G. V., Horton, S., Krasevec, J., ... & Rollins, N. C. (2016). Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. *The Lancet*, 387(10017), 475-490.
- Virgian, K., Setiawati, D., Veratiwi, V., Franciska, Y., & Hakim, D. R. (2023). Penerapan Aplikasi Android "Menyusui Asi-Q" pada Ibu Menyusui di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Palembang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (ABDIKEMAS)*, 5(1), 64-69.
- WHO. (2021). Guideline: protection, promotion and support of breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services. Geneva: World Health Organization.
- Wiji, R.N. (2013). ASI dan Panduan Ibu Menyusui. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Wulandari, D., & Pratama, H. (2021). Pengaruh ketersediaan ruang laktasi terhadap motivasi ibu bekerja untuk memerah ASI. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(2), 112-120.
- Wulandari, P., Arifianto, A., & Mulyaningsih, A. R. (2018). Cara Pelaksanaan Pemberian ASI Eksklusif Pada Perawat Yang Bekerja Di Rumah Sakit ST. Elisabeth Semarang. *Jurnal JKFT*, 3(1), 60-70.

I. Glosarium

Air Susu Ibu (ASI)

Cairan biologis yang diproduksi oleh kelenjar payudara perempuan setelah melahirkan, mengandung zat gizi, antibodi, enzim, hormon, serta faktor pertumbuhan yang esensial bagi kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan bayi.

ASI Eksklusif

Pemberian hanya ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih, sejak bayi lahir hingga usia enam bulan, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan tenaga kesehatan.

Kolostrum

Cairan kekuningan yang keluar dari payudara pada hari-hari pertama setelah melahirkan, kaya antibodi, protein, dan sel imun yang berperan penting dalam melindungi bayi dari infeksi.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Proses bayi diletakkan di dada ibu segera setelah lahir untuk mulai menyusui sendiri, biasanya dalam satu jam pertama kehidupan, yang berperan penting dalam keberhasilan menyusui.

Perlekatan

Teknik menempelkan mulut bayi pada payudara dengan benar sehingga bayi dapat mengisap ASI secara efektif, ditandai dengan mulut terbuka lebar, dagu menempel pada payudara, dan sebagian besar areola masuk ke mulut bayi.

Laktasi

Proses produksi dan pengeluaran ASI oleh kelenjar payudara yang dipengaruhi oleh hormon prolaktin (untuk produksi) dan oksitosin (untuk pengeluaran).

Prolaktin

Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior, berperan dalam merangsang produksi ASI dan menekan ovulasi, sehingga membantu menjarangkan kehamilan.

Oksitosin

Hormon yang dilepaskan dari hipofisis posterior, berfungsi merangsang kontraksi otot rahim pascapersalinan serta membantu pengeluaran ASI melalui refleks let down.

ASI Perah (ASIP)

ASI yang dipompa atau diperah dari payudara ibu untuk disimpan dan diberikan kembali kepada bayi, biasanya digunakan oleh ibu bekerja untuk tetap memenuhi kebutuhan ASI eksklusif bayi.

Ruang Laktasi

Fasilitas khusus di tempat kerja atau ruang publik yang digunakan ibu menyusui untuk memerah, menyimpan, atau memberikan ASI dengan aman, nyaman, dan higienis.

Peer Counselor Menyusui

Ibu menyusui berpengalaman yang memberikan dukungan, informasi, dan motivasi kepada ibu lain dalam praktik menyusui, berdasarkan pengalaman pribadi dan pelatihan khusus.

Konseling Laktasi

Pendampingan profesional oleh tenaga kesehatan atau konselor laktasi untuk membantu ibu dalam teknik menyusui, perlekatan, manajemen ASI, serta pemecahan masalah menyusui.

Self Demand Feeding (Menyusu Sesuai Permintaan)

Pola menyusui yang dilakukan tanpa jadwal ketat, di mana bayi disusui sesuai kebutuhan dan permintaannya, biasanya 8–12 kali per hari pada enam bulan pertama.

Mastitis

Peradangan pada payudara yang biasanya terjadi akibat penyumbatan saluran ASI atau infeksi bakteri, ditandai dengan nyeri, kemerahan, dan kadang disertai demam.

Engorgement (Pembengkakan Payudara)

Kondisi ketika payudara terasa penuh, keras, dan nyeri akibat produksi ASI yang berlebihan atau pengosongan payudara yang tidak optimal.

Corporate Parenting

Kebijakan perusahaan yang menyediakan dukungan komprehensif bagi pekerja yang menjadi orang tua, termasuk cuti melahirkan, ruang laktasi, layanan konseling, hingga fasilitas penitipan anak.

Telelaktasi

Layanan konseling laktasi berbasis digital yang memanfaatkan teknologi komunikasi daring seperti video call, chat, atau aplikasi khusus untuk memberikan dukungan menyusui jarak jauh.

Prebiotik ASI

Komponen dalam ASI (seperti oligosakarida) yang berfungsi sebagai makanan bagi bakteri baik dalam usus bayi, sehingga mendukung pembentukan mikrobioma usus yang sehat.

Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar)

Survei nasional yang dilakukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memantau status kesehatan masyarakat, termasuk cakupan pemberian ASI eksklusif.

WHO (World Health Organization)

Organisasi kesehatan dunia yang merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi sebagai standar emas nutrisi bayi.

CHAPTER 3

PENATALAKSANAAN KOMPLIKASI POSTPARTUM BERBASIS BUKTI

Ririn Ratnasari, SST., M.kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Masa postpartum atau masa nifas merupakan periode krusial yang dimulai setelah kelahiran plasenta dan berlangsung hingga enam minggu pascapersalinan. Meskipun proses persalinan telah selesai, fase ini tetap menyimpan berbagai risiko yang dapat membahayakan keselamatan ibu jika tidak dikelola dengan baik. Komplikasi postpartum dapat muncul secara tiba-tiba dan tanpa gejala awal yang mencolok, sehingga deteksi dini dan penatalaksanaan yang cepat dan tepat menjadi sangat penting. Berbagai studi global dan nasional menunjukkan bahwa sebagian besar kematian maternal justru terjadi dalam 24 jam hingga minggu-minggu pertama setelah persalinan. Oleh karena itu, penanganan komplikasi postpartum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penurunan angka kesakitan dan kematian ibu (AKI) di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Komplikasi yang paling umum terjadi dalam periode postpartum meliputi perdarahan postpartum (postpartum hemorrhage/PPH), infeksi puerperalis, retensi plasenta, gangguan psikologis seperti depresi postpartum, dan gangguan laktasi. Masing-masing dari kondisi ini, jika tidak dikenali dan ditangani secara cepat dan efektif, dapat berkembang menjadi masalah yang serius bahkan berakibat fatal. Dalam banyak kasus, keterlambatan dalam mengenali gejala dan memberikan intervensi medis menjadi penyebab utama memburuknya kondisi ibu pascamelahirkan. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan dan deteksi dini harus berjalan beriringan dengan kemampuan tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam memberikan penanganan yang berbasis pada pedoman klinis dan bukti ilmiah terbaru.

Dalam praktik kebidanan modern, pendekatan berbasis bukti atau evidence-based practice (EBP) telah menjadi standar emas dalam pengambilan keputusan klinis, termasuk dalam penatalaksanaan komplikasi postpartum. EBP merupakan pendekatan yang mengintegrasikan temuan ilmiah terkini dari hasil penelitian yang valid, pengalaman klinis tenaga kesehatan, dan nilai serta preferensi pasien. Dalam konteks kebidanan, hal ini berarti bahwa bidan dan tenaga kesehatan lainnya tidak hanya bertumpu pada kebiasaan praktik atau intuisi, tetapi juga harus mampu

menilai dan menerapkan rekomendasi yang didukung oleh bukti ilmiah yang kredibel. Misalnya, dalam penanganan perdarahan postpartum, penggunaan oksitosin sebagai uterotonika lini pertama telah didukung oleh berbagai pedoman WHO dan POGI sebagai intervensi yang efektif dan efisien dalam mencegah kematian ibu akibat syok hipovolemik.

Urgensi penerapan pendekatan berbasis bukti juga semakin tinggi di era pelayanan kesehatan yang menuntut akuntabilitas dan mutu. Pasien dan keluarga kini lebih sadar akan hak-haknya untuk mendapatkan perawatan terbaik dan sering kali memiliki akses informasi yang luas. Dalam kondisi ini, bidan dan tenaga kesehatan dituntut untuk memberikan penjelasan yang transparan dan berdasar, sekaligus menunjukkan bahwa keputusan klinis yang diambil sesuai dengan standar profesional dan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi EBP juga memungkinkan terjadinya standardisasi praktik yang konsisten antar tenaga kesehatan dan antar fasilitas, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi sistem pelayanan dan mengurangi variasi penatalaksanaan yang tidak perlu.

Namun demikian, penerapan EBP dalam kebidanan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Masih terdapat tantangan seperti keterbatasan akses terhadap sumber literatur ilmiah terkini, kurangnya pelatihan berkelanjutan mengenai cara menafsirkan dan menerapkan hasil penelitian, serta kendala struktural di fasilitas pelayanan kesehatan seperti kurangnya tenaga atau alat penunjang. Oleh karena itu, diperlukan strategi sistematis untuk menjadikan pendekatan berbasis bukti sebagai budaya kerja di semua lini pelayanan kebidanan, termasuk dalam penanganan kasus postpartum. Hal ini mencakup penyediaan sumber daya ilmiah, peningkatan kapasitas SDM, penguatan jejaring profesional, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan ibu pascapersalinan.

Dengan dasar pemikiran tersebut, pembahasan dalam bab ini akan menguraikan lebih jauh tentang bentuk-bentuk komplikasi postpartum yang paling sering terjadi, prinsip-prinsip penatalaksanaan berdasarkan bukti ilmiah terkini, serta sistem pendukung yang dibutuhkan agar pelayanan postpartum menjadi lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan ibu. Penanganan komplikasi postpartum berbasis bukti bukan hanya pilihan, tetapi merupakan suatu keharusan dalam sistem pelayanan kebidanan yang bermutu, humanistik, dan responsif terhadap tantangan kesehatan ibu di masa kini dan masa depan.

B. Jenis-Jenis Komplikasi Postpartum

Masa nifas atau masa postpartum adalah periode transisi yang sangat penting, dimulai setelah lahirnya plasenta hingga enam minggu pascapersalinan. Meskipun sebagian besar ibu melalui masa ini dengan pemulihan yang baik, tidak sedikit pula

yang mengalami komplikasi yang dapat membahayakan kesehatan bahkan keselamatannya. Komplikasi postpartum bisa bersifat fisik maupun psikologis dan dapat muncul secara akut dalam 24 jam pertama, maupun secara bertahap dalam beberapa minggu setelah persalinan. Pemahaman yang menyeluruh mengenai jenis-jenis komplikasi ini sangat penting agar deteksi dini dan intervensi yang tepat dapat dilakukan secara efisien.

Salah satu komplikasi postpartum yang paling sering dan paling berbahaya adalah perdarahan postpartum (postpartum hemorrhage/PPH), yang dibedakan menjadi perdarahan dini (terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan) dan perdarahan lanjut (terjadi setelah 24 jam hingga 6 minggu postpartum). Perdarahan postpartum dini umumnya disebabkan oleh atonia uteri, yaitu kegagalan otot rahim untuk berkontraksi dengan baik setelah plasenta lahir, sehingga menyebabkan kehilangan darah dalam jumlah besar. Sedangkan perdarahan postpartum lanjut biasanya disebabkan oleh sisa jaringan plasenta, infeksi, atau subinvolusi uterus. Jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, PPH dapat menyebabkan syok hipovolemik yang mengancam nyawa. Oleh karena itu, intervensi aktif kala III (AMTSL), pemantauan kontraksi uterus, dan pemberian uterotonika sangat penting untuk pencegahan maupun penanganan PPH.

Komplikasi berikutnya yang juga cukup sering terjadi adalah infeksi puerperalis, yaitu infeksi pada saluran reproduksi atau organ tubuh lainnya yang muncul dalam masa nifas. Infeksi ini dapat disebabkan oleh kontaminasi bakteri selama proses persalinan atau ketidakterjagaan kebersihan perineum pascapersalinan. Gejala umum infeksi puerperalis mencakup demam, nyeri perut bagian bawah, keputihan berbau tidak sedap, dan malaise. Bentuk infeksi yang umum meliputi endometritis (infeksi pada lapisan dalam rahim), infeksi luka jahitan, serta infeksi traktus urinarius. Penanganan dini dengan antibiotik sesuai protokol dan edukasi tentang kebersihan diri merupakan langkah penting dalam mencegah komplikasi lebih lanjut seperti sepsis.

Retensi plasenta juga menjadi salah satu penyebab utama perdarahan postpartum, khususnya pada fase awal. Retensi terjadi ketika sebagian atau seluruh jaringan plasenta tidak berhasil dikeluarkan setelah 30 menit pasca persalinan. Kondisi ini dapat menghambat kontraksi uterus secara optimal dan memicu perdarahan terus-menerus. Penanganannya dapat mencakup manipulasi manual oleh tenaga medis terlatih, tindakan kuretase, atau pemberian uterotonika untuk mempercepat kontraksi uterus. Kegagalan dalam mengatasi retensi plasenta bisa menyebabkan infeksi berat hingga infertilitas di kemudian hari.

Gangguan laktasi merupakan masalah lain yang sering dihadapi ibu pascapersalinan. Kesulitan menyusui bisa terjadi akibat pelekatan yang tidak tepat,

puting lecet, mastitis, atau produksi ASI yang tidak mencukupi. Gangguan ini tidak hanya berdampak pada pemberian nutrisi yang optimal bagi bayi, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan emosional ibu. Edukasi dan dukungan menyusui sejak awal persalinan, teknik menyusui yang benar, serta pendampingan dari konselor laktasi sangat berperan dalam mencegah dan mengatasi gangguan ini.

Komplikasi postpartum juga dapat mencakup masalah serius seperti Deep Vein Thrombosis (DVT), yaitu terbentuknya bekuan darah di pembuluh darah dalam, biasanya di tungkai bawah. Risiko DVT meningkat pada ibu nifas karena faktor hiperkoagulabilitas alami pascapersalinan, imobilisasi yang lama, atau riwayat trombosis sebelumnya. Gejala meliputi bengkak, nyeri tungkai, dan kemerahan. Jika bekuan darah ini lepas, dapat menimbulkan emboli paru yang berakibat fatal. Pencegahan dilakukan dengan mobilisasi dini, penggunaan stocking kompresi, dan pada kasus tertentu, pemberian antikoagulan.

Tidak kalah penting, masa postpartum juga menjadi masa yang rentan terhadap gangguan psikologis, termasuk baby blues dan postpartum depression. Baby blues terjadi pada sekitar 70-80% ibu dan biasanya berlangsung singkat, ditandai dengan perubahan suasana hati, mudah menangis, dan kelelahan. Sementara itu, postpartum depression merupakan gangguan yang lebih serius dan berkepanjangan, melibatkan gejala seperti perasaan sedih yang mendalam, kecemasan, gangguan tidur, hingga munculnya pikiran untuk menyakiti diri atau bayi. Kondisi ini memerlukan deteksi dini melalui skrining psikologis dan intervensi yang mencakup konseling, dukungan sosial, serta rujukan ke profesional kesehatan jiwa bila diperlukan.

Dengan mengenali berbagai bentuk komplikasi postpartum ini, tenaga kesehatan—khususnya bidan—dapat melakukan penatalaksanaan berbasis bukti secara lebih efektif. Penguatan kapasitas dalam observasi klinis, keterampilan teknis, dan komunikasi interpersonal menjadi fondasi penting dalam memberikan pelayanan pasca persalinan yang aman, empatik, dan menyeluruh. Pendekatan komprehensif terhadap komplikasi postpartum tidak hanya menyelamatkan nyawa ibu, tetapi juga berkontribusi pada terwujudnya keluarga yang sehat dan berdaya.

C. Prinsip Pendekatan Berbasis Bukti dalam Penatalaksanaan

Pendekatan berbasis bukti atau evidence-based practice (EBP) telah menjadi landasan utama dalam praktik kebidanan modern, termasuk dalam penatalaksanaan komplikasi postpartum. Konsep ini dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap keputusan klinis yang diambil oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan, tidak hanya mengandalkan pengalaman pribadi atau kebiasaan lama, tetapi juga didasarkan pada bukti ilmiah terkini yang telah terbukti secara valid dan dapat

dipertanggungjawabkan. Tujuan utama dari EBP adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, menjamin keselamatan pasien, dan memberikan hasil klinis yang optimal melalui pendekatan yang sistematis, logis, dan akuntabel.

EBP dalam kebidanan mencakup tiga pilar utama yang saling terintegrasi. Pilar pertama adalah hasil penelitian ilmiah terkini (*best available evidence*), yaitu informasi yang diperoleh dari hasil studi klinis yang valid dan relevan, seperti uji klinis terkontrol, meta-analisis, dan panduan praktik klinis berbasis konsensus ilmiah. Sumber-sumber ini memberikan dasar ilmiah tentang intervensi yang paling efektif untuk berbagai kondisi, termasuk dalam penanganan komplikasi postpartum seperti perdarahan, infeksi, atau gangguan psikologis. Misalnya, penggunaan oksitosin intramuskular sebagai pilihan utama dalam penanganan perdarahan postpartum dini telah terbukti secara kuat melalui berbagai studi dan telah direkomendasikan oleh WHO serta organisasi profesi kebidanan internasional.

Pilar kedua adalah keahlian klinis tenaga kesehatan (*clinical expertise*). Dalam praktik sehari-hari, bidan menghadapi situasi yang tidak selalu sesuai dengan kondisi ideal dalam penelitian. Oleh karena itu, keahlian dan intuisi klinis yang diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman sangat dibutuhkan untuk menilai secara cepat kondisi ibu, memodifikasi tindakan bila diperlukan, serta mengintegrasikan pedoman ilmiah dengan kenyataan praktik lapangan. Keahlian klinis mencakup kemampuan observasi, keterampilan prosedural, penilaian risiko, dan pengambilan keputusan dalam situasi mendesak, seperti pada kasus perdarahan berat atau infeksi pasca persalinan.

Pilar ketiga yang tidak kalah penting adalah nilai dan preferensi pasien (*patient values and preferences*). Setiap ibu memiliki latar belakang sosial, budaya, psikologis, dan spiritual yang berbeda, yang memengaruhi cara mereka memandang proses pemulihan postpartum dan keputusan yang akan mereka ambil terkait tindakan medis. Dalam prinsip EBP, bidan tidak hanya menyampaikan pilihan intervensi yang tersedia berdasarkan bukti ilmiah, tetapi juga berdiskusi secara terbuka dengan ibu dan keluarganya untuk memahami harapan, ketakutan, serta pilihan pribadi yang mereka miliki. Pendekatan ini menempatkan pasien sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan dan memberikan ruang bagi pelayanan yang lebih humanistik, etis, dan kontekstual.

Penerapan EBP dalam kebidanan, khususnya dalam penatalaksanaan komplikasi postpartum, membutuhkan sistem pendukung yang memadai. Hal ini meliputi akses terhadap sumber literatur ilmiah yang terpercaya, pelatihan rutin tentang penggunaan pedoman klinis berbasis bukti, serta penguatan jejaring profesional untuk mendiskusikan kasus-kasus sulit secara kolaboratif. Teknologi informasi seperti aplikasi praktik klinis, jurnal daring, dan database Cochrane atau

PubMed dapat menjadi sumber penting dalam memperbarui pengetahuan bidan di berbagai daerah, termasuk di fasilitas dengan keterbatasan sumber daya.

Dengan mengintegrasikan ketiga pilar tersebut—bukti ilmiah, keahlian klinis, dan preferensi pasien—penatalaksanaan komplikasi postpartum dapat dilakukan secara lebih efektif, aman, dan bermutu tinggi. Tidak hanya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, EBP juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kebidanan, memperkuat profesionalisme tenaga kesehatan, dan mewujudkan pelayanan kesehatan ibu yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks sistem kesehatan yang terus berkembang, pendekatan berbasis bukti bukan hanya pilihan metode, melainkan menjadi komitmen moral dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada setiap perempuan yang melahirkan.

D. Penatalaksanaan Perdarahan Postpartum (PPH)

Perdarahan postpartum atau postpartum hemorrhage (PPH) merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. PPH didefinisikan sebagai kehilangan darah ≥ 500 ml setelah persalinan pervaginam atau ≥ 1000 ml setelah operasi sesar. Kejadian ini dibagi menjadi dua kategori: PPH primer, yang terjadi dalam 24 jam pertama pascapersalinan, dan PPH sekunder, yang terjadi setelah 24 jam hingga enam minggu postpartum. Mayoritas kasus PPH disebabkan oleh atonia uteri—yaitu kegagalan otot rahim berkontraksi setelah melahirkan—namun dapat pula disebabkan oleh retensi plasenta, trauma jalan lahir, dan gangguan koagulasi. Karena terjadinya PPH bisa sangat cepat dan mengancam jiwa, penatalaksanaan yang cepat, tepat, dan berbasis bukti sangat penting dilakukan di semua lini pelayanan kebidanan.

Salah satu strategi utama dalam pencegahan PPH adalah penatalaksanaan aktif kala III persalinan (Active Management of Third Stage of Labour/AMTSL). AMTSL merupakan pendekatan yang terbukti secara ilmiah efektif dalam mencegah PPH, dengan komponen utama berupa pemberian uterotonika dalam satu menit setelah bayi lahir (biasanya oksitosin), traksi tali pusat terkendali, dan pemijatan fundus uteri setelah lahirnya plasenta. Prosedur ini bertujuan untuk merangsang kontraksi uterus sehingga mempercepat pelepasan plasenta dan mencegah atonia uteri. WHO dan organisasi profesi seperti POGI dan IBI telah menjadikan AMTSL sebagai bagian dari standar asuhan kebidanan yang wajib diterapkan oleh tenaga kesehatan.

Selain tindakan preventif, intervensi uterotonika menjadi bagian tak terpisahkan dari penatalaksanaan PPH, terutama yang disebabkan oleh atonia uteri. Oksitosin adalah pilihan pertama yang direkomendasikan karena memiliki onset

kerja yang cepat dan profil efek samping yang relatif aman. Oksitosin dapat diberikan secara intramuskular atau intravena tergantung pada fasilitas yang tersedia. Jika oksitosin tidak tersedia atau tidak efektif, misoprostol dapat menjadi alternatif atau pelengkap karena stabil pada suhu ruangan dan dapat diberikan secara oral, sublingual, atau rektal. Dosis dan jalur pemberian harus disesuaikan dengan panduan yang berlaku untuk menghindari efek samping seperti demam, menggigil, atau diare.

Dalam situasi darurat di mana pemberian uterotonika tidak memberikan hasil yang cukup, maka tindakan mekanis seperti teknik kompresi uterus dan tamponade balon dapat dilakukan. Kompresi bimanual uterus bertujuan untuk menghentikan perdarahan secara mekanis sambil menunggu efek uterotonika atau persiapan rujukan. Tamponade balon (misalnya balon Bakri atau kondom kateter) digunakan untuk memberikan tekanan dari dalam rongga uterus guna menghentikan perdarahan yang berlangsung. Prosedur ini tergolong sederhana, relatif aman, dan dapat dilakukan oleh bidan atau dokter umum terlatih di fasilitas pelayanan dasar. Dalam beberapa kasus, teknik kompresi dengan kain uterine packing atau pembedahan konservatif seperti ligasi arteri uterina mungkin diperlukan, meskipun umumnya dilakukan di fasilitas rujukan.

Dalam semua kasus PPH, sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk mengenali kriteria rujukan dan segera memulai proses evakuasi bila tindakan awal tidak menunjukkan perbaikan. Rujukan harus dilakukan bila terjadi syok hipovolemik yang tidak dapat dikendalikan, retensi plasenta yang tidak dapat dikeluarkan, perdarahan akibat robekan serviks atau vagina berat, atau bila fasilitas dan tenaga yang tersedia tidak memadai untuk menangani kasus. WHO dan POGI telah mengembangkan protokol penatalaksanaan PPH yang memuat langkah-langkah sistematis dalam bentuk algoritma. Protokol ini meliputi identifikasi cepat penyebab perdarahan (4T: tone, tissue, trauma, thrombin), pemberian cairan intravena, pemantauan tanda vital secara ketat, dan penggunaan skala untuk menilai status perfusi jaringan. Tenaga kesehatan perlu mengikuti protokol ini secara ketat untuk memastikan keamanan dan kelangsungan hidup ibu.

Penanganan PPH yang efektif tidak hanya memerlukan keterampilan klinis, tetapi juga kesiapsiagaan sistem, termasuk ketersediaan obat, peralatan, transportasi, dan rujukan yang cepat. Oleh karena itu, penting bagi setiap fasilitas pelayanan kebidanan, terutama puskesmas dan klinik bersalin, untuk melakukan simulasi penanganan PPH secara berkala, melakukan pelatihan rutin, dan memastikan seluruh tenaga kesehatan memahami alur penanganan gawat darurat obstetri. Dengan pendekatan berbasis bukti dan kerja tim yang solid, PPH yang

berisiko tinggi menyebabkan kematian dapat dikelola secara efektif, sehingga meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup ibu pascapersalinan.

E. Penatalaksanaan Infeksi Postpartum

Infeksi postpartum atau infeksi puerperalis merupakan salah satu komplikasi masa nifas yang dapat membahayakan keselamatan ibu bila tidak dikenali dan ditangani secara dini. Infeksi ini biasanya terjadi dalam enam minggu setelah persalinan, dan dapat mengenai berbagai bagian tubuh, terutama saluran reproduksi seperti uterus (endometritis), vagina, perineum, hingga sistem urinaria dan saluran luka operasi. Infeksi postpartum juga berperan dalam tingginya angka morbiditas maternal di negara berkembang, termasuk Indonesia, dan kerap menjadi penyebab rawat inap ulang pascapersalinan. Oleh karena itu, penatalaksanaan infeksi postpartum berbasis bukti sangat penting untuk memastikan intervensi yang tepat, rasional, dan berkelanjutan.

Langkah pertama dalam penatalaksanaan adalah identifikasi dini terhadap tanda dan gejala infeksi. Tenaga kesehatan, khususnya bidan dan perawat, harus waspada terhadap beberapa indikasi klinis yang umum ditemukan pada infeksi puerperalis, seperti demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dalam dua hari berturut-turut dalam 10 hari pertama pascapersalinan (kecuali hari pertama), nyeri tekan uterus, lochia yang berbau busuk, keputihan berlebihan, nyeri perineum, atau bengkak dan kemerahan di tempat jahitan. Selain itu, keluhan seperti rasa tidak enak badan, menggigil, takikardia, dan malaise juga harus menjadi sinyal untuk evaluasi lebih lanjut. Jika terdapat tanda-tanda sistemik seperti kesadaran menurun, hipotensi, atau syok, maka infeksi kemungkinan telah berkembang menjadi sepsis, yang memerlukan penanganan emergensi dan rujukan segera.

Setelah diagnosis infeksi ditegakkan atau dicurigai, maka penatalaksanaan dilanjutkan dengan pemberian antibiotik lini pertama yang sesuai pedoman nasional. Menurut Panduan Praktik Klinis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pilihan antibiotik empiris yang sering digunakan untuk infeksi postpartum meliputi ampicilin, gentamisin, dan metronidazol, baik secara tunggal maupun kombinasi tergantung lokasi dan beratnya infeksi. Misalnya, untuk kasus endometritis ringan, dapat diberikan metronidazol dan amoksisilin secara oral, sementara pada kasus yang lebih berat seperti infeksi luka operasi atau infeksi pelvis, pemberian antibiotik intravena dengan spektrum luas seperti ceftriaxone atau cefotaxime dapat menjadi pilihan. Penting untuk memastikan kepatuhan pasien terhadap dosis dan durasi terapi, serta menyesuaikan regimen berdasarkan kultur dan sensitivitas bila tersedia.

Selain terapi medikamentosa, aspek pencegahan infeksi nosokomial dan edukasi kebersihan perineum tidak kalah penting dalam manajemen infeksi postpartum. Infeksi nosokomial, terutama pada ibu pasca operasi sesar atau perineum dengan robekan tingkat lanjut, sering kali terjadi akibat tidak optimalnya praktik kebersihan di fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan wajib menerapkan protokol kebersihan tangan, sterilisasi alat, penggunaan sarung tangan steril, serta perawatan luka yang benar sesuai standar operasional prosedur. Penerapan prinsip universal precaution di ruang bersalin dan ruang nifas harus menjadi budaya kerja yang tidak dapat ditawar.

Bagi ibu yang menjalani perawatan di rumah, edukasi tentang kebersihan perineum sangat diperlukan. Ibu perlu diberikan informasi tentang cara membersihkan area genital dari depan ke belakang, mengganti pembalut secara teratur, menghindari penggunaan pembersih vagina yang tidak direkomendasikan, serta mengenali tanda-tanda infeksi yang harus segera dilaporkan. Edukasi ini idealnya dimulai sejak masa antenatal dan diperkuat dalam kunjungan postnatal. Bidan sebagai pendamping ibu harus memastikan bahwa ibu dan keluarganya memahami pentingnya kebersihan dan tindak lanjut yang tepat bila terjadi keluhan.

Dalam banyak kasus, keberhasilan penatalaksanaan infeksi postpartum sangat ditentukan oleh kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan deteksi dini, memberikan terapi yang tepat, serta melakukan monitoring dan evaluasi lanjutan. Pendekatan berbasis bukti, didukung dengan protokol klinis yang jelas dan komunikasi efektif dengan pasien, akan mengoptimalkan hasil klinis dan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang seperti infertilitas, sepsis, atau abses pelvis. Oleh karena itu, sistem pelayanan kebidanan harus dilengkapi dengan pelatihan rutin, penguatan jejaring rujukan, serta sumber daya yang memadai agar penanganan infeksi postpartum dapat dilakukan secara holistik, terstandar, dan berorientasi pada keselamatan ibu.

F. Penanganan Gangguan Psikologis Postpartum

Gangguan psikologis pada masa postpartum merupakan kondisi yang kerap tidak terdeteksi, meskipun memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup ibu, hubungan ibu-anak, serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Perubahan fisiologis dan hormonal yang terjadi secara cepat pascapersalinan, ditambah dengan beban peran baru sebagai ibu, kurangnya tidur, dan tekanan sosial, dapat memicu gangguan emosional mulai dari baby blues, depresi postpartum, hingga psikosis postpartum. Di antara kondisi tersebut, depresi postpartum merupakan bentuk gangguan psikologis yang paling sering ditemui dan dapat berlangsung dalam jangka panjang jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan

penanganan gangguan psikologis postpartum harus dilakukan secara menyeluruh dan berbasis bukti, dimulai dari deteksi dini, pemberian konseling, intervensi psikososial, hingga rujukan profesional bila diperlukan.

Langkah awal dalam penanganan adalah skrining terhadap depresi postpartum, yang seharusnya menjadi bagian dari pemeriksaan rutin pascapersalinan. Alat yang paling banyak digunakan dan telah divalidasi secara internasional adalah Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). EPDS merupakan kuesioner singkat yang terdiri dari 10 pertanyaan dan dapat digunakan oleh tenaga kesehatan seperti bidan atau perawat untuk mengevaluasi suasana hati ibu dalam dua minggu terakhir. Skor yang melebihi ambang batas tertentu menunjukkan kemungkinan adanya depresi dan perlu dilakukan asesmen lanjutan. Skrining ini dapat dilakukan saat kunjungan rumah, di ruang rawat nifas, atau saat ibu datang untuk kontrol pascapersalinan.

Jika hasil skrining menunjukkan gejala ringan hingga sedang, maka penanganan dapat dimulai melalui konseling dasar oleh bidan. Dalam perannya sebagai pendamping utama ibu, bidan memiliki posisi strategis untuk memberikan dukungan emosional dan membangun komunikasi empatik. Konseling ini bertujuan untuk membantu ibu mengenali emosinya, mengekspresikan kekhawatiran, serta mencari solusi praktis terhadap masalah yang dihadapi, seperti kelelahan, konflik peran, atau gangguan tidur. Konseling dasar juga dapat mencakup edukasi kepada suami atau anggota keluarga lainnya mengenai cara mendukung ibu selama masa pemulihan psikologisnya. Pendekatan ini harus dilakukan secara non-menghakimi, mendengarkan secara aktif, dan menjamin kerahasiaan informasi yang disampaikan ibu.

Namun demikian, jika gejala depresi berat muncul, seperti perasaan tidak berharga yang berlebihan, pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayi, atau gangguan fungsi yang signifikan dalam merawat diri dan anak, maka bidan wajib melakukan rujukan ke profesional kesehatan jiwa, seperti psikolog klinis atau psikiater. Intervensi oleh profesional ini dapat berupa psikoterapi, terapi perilaku kognitif (CBT), terapi keluarga, atau bahkan farmakoterapi bila dibutuhkan. Sistem rujukan ini harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi dengan memperhatikan keamanan ibu dan anak, serta melibatkan tim multidisiplin untuk perawatan yang komprehensif.

Di samping itu, keterlibatan keluarga merupakan aspek penting dalam penanganan gangguan psikologis postpartum. Suami dan keluarga inti berperan sebagai sistem pendukung utama yang dapat membantu mengurangi stresor ibu, seperti beban pekerjaan rumah, perawatan bayi, atau isolasi sosial. Dukungan emosional dari suami—seperti validasi perasaan, empati, dan komunikasi terbuka—

dapat mempercepat pemulihan psikologis ibu. Di sisi lain, kurangnya dukungan atau bahkan konflik dalam rumah tangga justru menjadi salah satu faktor risiko depresi postpartum yang paling umum. Oleh karena itu, edukasi keluarga mengenai pentingnya dukungan sosial dan bagaimana mengenali tanda-tanda gangguan psikologis sangat diperlukan dalam program pelayanan kebidanan.

Penanganan gangguan psikologis postpartum berbasis bukti menekankan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan emosional ibu. Tenaga kesehatan harus peka terhadap kondisi emosional ibu, melakukan asesmen secara holistik, dan menciptakan lingkungan pelayanan yang aman secara psikologis. Integrasi pelayanan kesehatan jiwa dalam sistem pelayanan maternal, pelatihan konseling dasar bagi bidan, serta pengembangan jejaring rujukan lintas sektor menjadi komponen penting dalam penatalaksanaan yang efektif.

Dengan sistem dukungan yang kuat, skrining yang sistematis, dan penanganan multidisipliner, gangguan psikologis postpartum dapat diatasi secara optimal, sehingga ibu mampu menjalani masa transisi ke peran sebagai orang tua dengan sehat, percaya diri, dan berdaya. Kesehatan mental ibu merupakan investasi jangka panjang untuk tumbuh kembang anak yang sehat dan keluarga yang sejahtera.

G. Kolaborasi dan Sistem Rujukan

Dalam penatalaksanaan komplikasi postpartum, sistem kolaborasi dan rujukan memegang peranan vital dalam memastikan bahwa setiap kasus mendapat penanganan tepat waktu, sesuai tingkat kegawatannya, dan oleh tenaga profesional yang kompeten. Komplikasi postpartum, seperti perdarahan hebat, infeksi berat, depresi postpartum, atau tromboemboli, dapat berkembang secara cepat dan membutuhkan koordinasi lintas profesi serta lintas level pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, keberhasilan intervensi kebidanan pascapersalinan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh sistem kerja yang terpadu, berbasis protokol, dan mengedepankan komunikasi yang efektif antar semua pihak terkait.

Kunci utama dari sistem rujukan yang efektif adalah kolaborasi interprofesional, terutama antara bidan, dokter, dan perawat. Setiap profesi memiliki peran dan kompetensi yang saling melengkapi dalam memberikan asuhan yang komprehensif kepada ibu pascapersalinan. Bidan sebagai penyedia layanan primer bertugas mendeteksi secara dini komplikasi yang mungkin terjadi, seperti perdarahan, infeksi, atau gangguan psikologis. Setelah identifikasi dilakukan, bidan harus segera berkonsultasi dengan dokter umum atau dokter spesialis kandungan untuk mendapatkan konfirmasi diagnosis dan perencanaan rujukan atau intervensi

lanjutan. Dalam proses ini, perawat memiliki peran penting dalam pemantauan tanda vital, pemberian terapi awal, dan edukasi kepada pasien serta keluarga. Kolaborasi yang harmonis dan saling menghargai peran masing-masing profesi akan mempercepat pengambilan keputusan klinis dan meningkatkan hasil perawatan pasien.

Agar proses rujukan berjalan secara sistematis dan efisien, perlu diterapkan algoritma rujukan untuk komplikasi postpartum. Algoritma ini berbentuk diagram alur yang memuat tahapan-tahapan keputusan klinis dan intervensi sesuai tingkat keparahan kasus. Misalnya, pada kasus perdarahan postpartum, algoritma akan mengarahkan bidan untuk segera melakukan kompresi uterus dan pemberian uterotonika, sambil menyiapkan rujukan ke rumah sakit jika tidak ada respons dalam waktu tertentu. Demikian pula, pada kasus infeksi postpartum disertai tanda-tanda sepsis, algoritma mengarahkan kepada pemberian antibiotik segera, infus cairan, dan aktivasi sistem rujukan emergensi. Algoritma ini didasarkan pada pedoman WHO, POGI, dan Kementerian Kesehatan, serta harus disesuaikan dengan sumber daya dan struktur rujukan di masing-masing wilayah.

Komponen lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan fasilitas dan komunikasi antar lini layanan. Rujukan tidak hanya memerlukan surat pengantar, tetapi juga harus didukung oleh kesiapan logistik, transportasi, dan sumber daya manusia di fasilitas tujuan. Kesiapan ini mencakup ketersediaan tempat tidur, alat emergensi obstetrik, tenaga dokter spesialis, serta protokol penanganan pasien rujukan. Untuk menjamin kesinambungan pelayanan, komunikasi yang efektif antara fasilitas perujuk (misalnya puskesmas atau klinik bersalin) dengan rumah sakit rujukan sangat diperlukan. Komunikasi ini harus berlangsung dua arah dan didasarkan pada informasi medis yang lengkap dan akurat, termasuk status vital, hasil pemeriksaan penunjang, dan tindakan yang telah diberikan. Pemanfaatan sistem digital seperti SiJariEMAS dan e-referral berbasis SMS atau web telah terbukti mempercepat proses komunikasi dan memperkecil risiko keterlambatan penanganan.

Selain sistem dan struktur, aspek manusia dalam komunikasi antarfasilitas juga sangat menentukan keberhasilan rujukan. Rasa saling percaya, keterbukaan, dan penghargaan antar profesi menjadi fondasi kolaborasi yang efektif. Oleh karena itu, pelatihan komunikasi interprofesional dan pelaksanaan pertemuan jejaring rujukan rutin di tingkat kabupaten sangat disarankan agar semua pihak memahami perannya masing-masing dalam rantai penyelamatan ibu pascapersalinan.

H. Peran Edukasi dan Follow-up Masa Nifas

Masa nifas adalah fase transisi penting yang dialami perempuan setelah melahirkan, di mana terjadi perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang signifikan. Meski sering kali dianggap sebagai masa pemulihan alami, periode ini sesungguhnya memerlukan perhatian khusus karena risiko komplikasi yang masih tinggi, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, edukasi yang memadai serta tindak lanjut (follow-up) yang sistematis menjadi aspek penting dalam penatalaksanaan kebidanan yang berkelanjutan. Edukasi yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai pemberian informasi, tetapi juga sebagai intervensi preventif untuk mendeteksi masalah sejak dini, membangun kesiapan ibu dalam menjalani peran barunya, dan memperkuat dukungan keluarga.

Salah satu komponen utama adalah pemberian konseling sejak masa antenatal, bukan hanya setelah persalinan. Konseling antenatal yang baik mencakup informasi mengenai perubahan yang akan dialami ibu pascapersalinan, tanda-tanda komplikasi yang harus diwaspadai, pentingnya kunjungan nifas, serta rencana perawatan bayi dan menyusui. Pemberian informasi sejak awal ini memungkinkan ibu dan keluarga mempersiapkan diri, baik secara emosional maupun logistik, termasuk dalam pengambilan keputusan cepat jika terjadi keadaan darurat. Konseling ini juga mencakup aspek kesiapan psikologis, dukungan sosial, dan pentingnya keterlibatan pasangan dalam perawatan ibu dan bayi.

Setelah melahirkan, kunjungan rumah pascapersalinan oleh bidan atau petugas kesehatan menjadi strategi efektif dalam mendekatkan pelayanan dan memastikan kelangsungan asuhan. Kunjungan rumah biasanya dilakukan pada hari ke-3, hari ke-7, dan minggu ke-42 pasca persalinan, atau disesuaikan dengan kebutuhan ibu. Dalam kunjungan ini, bidan tidak hanya melakukan pemeriksaan fisik, tetapi juga observasi terhadap lingkungan rumah, kondisi sosial ekonomi, dukungan keluarga, dan dinamika psikososial ibu. Hal ini penting karena banyak ibu yang mengalami keterbatasan akses atau enggan kembali ke fasilitas kesehatan karena alasan kelelahan, kurang percaya diri, atau minimnya dukungan.

Selama proses tindak lanjut tersebut, dilakukan monitoring terhadap berbagai aspek penting masa nifas, seperti status mental, proses menyusui (laktasi), penyembuhan luka perineum atau bekas operasi sesar, serta proses involusi uterus. Deteksi awal terhadap gangguan psikologis seperti baby blues atau depresi postpartum dilakukan melalui pengamatan perilaku ibu, diskusi terbuka, atau penggunaan alat skrining seperti EPDS. Penilaian terhadap proses laktasi meliputi posisi pelekatan bayi, nyeri payudara, produksi ASI, dan kemungkinan mastitis. Untuk luka perineum atau jahitan operasi, dilakukan pemeriksaan apakah ada tanda

infeksi, pembengkakan, atau keterlambatan penyembuhan. Involusi uterus dinilai dari tinggi fundus uteri dan konsistensinya, serta jumlah dan karakteristik lochia.

Selain aspek klinis, follow-up masa nifas juga menjadi momen untuk memperkuat edukasi lanjutan, seperti manajemen ASI, kontrasepsi pascapersalinan, pola tidur bayi, dan penguatan peran ayah dalam perawatan anak. Pendekatan ini sebaiknya dilakukan secara personal dan kontekstual, mengingat kebutuhan ibu bervariasi tergantung pada usia, paritas, latar belakang sosial budaya, dan kondisi kehamilan sebelumnya.

I. Simpulan

Penatalaksanaan komplikasi postpartum berbasis bukti merupakan pilar penting dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan ibu setelah persalinan. Masa nifas merupakan fase yang penuh dinamika fisik, psikologis, dan sosial, serta menyimpan berbagai risiko yang, bila tidak dikenali secara dini dan ditangani secara efektif, dapat menyebabkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Komplikasi seperti perdarahan postpartum, infeksi puerperalis, gangguan psikologis, dan masalah laktasi memerlukan pendekatan yang sistematis, terstandar, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Pendekatan berbasis bukti (evidence-based practice/EBP) menawarkan landasan kuat dalam penatalaksanaan komplikasi postpartum karena menggabungkan hasil penelitian ilmiah terkini, keahlian klinis tenaga kesehatan, dan preferensi pasien. Dengan EBP, intervensi seperti penggunaan oksitosin dalam penanganan perdarahan, pemberian antibiotik rasional untuk infeksi, hingga skrining depresi postpartum dengan EPDS, dapat dilaksanakan secara konsisten dan akuntabel. Penerapan prinsip EBP tidak hanya meningkatkan efektivitas klinis, tetapi juga memperkuat profesionalisme serta meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan kebidanan.

Kesuksesan penanganan komplikasi postpartum tidak lepas dari kolaborasi interprofesional yang terorganisir dan sistem rujukan yang fungsional. Keterlibatan bidan, dokter, perawat, serta tenaga kesehatan jiwa menjadi kunci dalam penanganan kasus kompleks. Begitu pula dengan kesiapan fasilitas, komunikasi dua arah antar lini layanan, serta penggunaan sistem digital rujukan seperti SiJariEMAS, yang mempercepat proses intervensi pada situasi kegawatdaruratan. Protokol dan algoritma rujukan yang jelas membantu mempercepat pengambilan keputusan dan menghindari keterlambatan penanganan.

Tidak kalah penting, peran edukasi dan tindak lanjut masa nifas merupakan bagian integral dari pendekatan pencegahan dan deteksi dini. Edukasi sejak masa antenatal, kunjungan rumah pascapersalinan, pemantauan aspek mental, fisik, dan

sosial, serta pemberdayaan keluarga, semuanya berkontribusi terhadap pemulihan optimal dan pencegahan komplikasi lebih lanjut. Pelayanan yang holistik dan responsif terhadap kebutuhan ibu menjadikan masa nifas sebagai kesempatan emas dalam mewujudkan kesehatan ibu dan bayi jangka panjang.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip evidence-based, kolaborasi lintas profesi, sistem rujukan yang siap tanggap, serta pendekatan yang humanistik dan berpusat pada ibu, pelayanan kebidanan pada masa postpartum dapat berkembang menjadi sistem yang berkualitas tinggi, adil, dan berkelanjutan. Penatalaksanaan komplikasi postpartum berbasis bukti bukan hanya standar profesional, tetapi juga wujud nyata dari komitmen untuk melindungi hak hidup dan kesehatan setiap perempuan setelah persalinan.

J. Referensi

- Althabe, F., Belizán, J. M., McClure, E. M., Hemingway-Foday, J., Buekens, P., Salazar, M., ... & Goldenberg, R. L. (2008). A population-based, multifaceted strategy to implement antenatal corticosteroid treatment in low- and middle-income countries: The ACT trial. *Lancet*, 385(9968), 629–639. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61651-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61651-2)
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Panduan Praktik Klinik bagi Bidan*. Jakarta: BKKBN.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Panduan Praktik Klinik Bagi Bidan Edisi 2*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Teknis Pencegahan dan Penanganan Komplikasi Masa Nifas*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Ibu dan Anak.
- National Institute for Health and Care Excellence. (2015). *Postnatal care up to 8 weeks after birth. NICE guideline [CG37]*. Retrieved from <https://www.nice.org.uk/guidance/cg37>
- Pusdik SDM Kesehatan. (2021). *Modul Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal (PPGD-ON)*. Jakarta: Badan PPSDM Kesehatan.
- Sines, E., Syed, U., Wall, S., & Worley, H. (2007). *Postnatal care: A critical opportunity to save mothers and newborns*. Population Reference Bureau. Retrieved from <https://www.prb.org/resources/postnatalcare/>
- World Health Organization. (2012). *WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2015). Maternal mortality: Levels and trends 1990 to 2015. Geneva: WHO Press.

World Health Organization. (2018). Managing complications in pregnancy and childbirth: A guide for midwives and doctors (2nd ed.). Geneva: World Health Organization.

K. Glosarium

Masa Postpartum

Merupakan periode penting yang dimulai sejak kelahiran plasenta hingga enam minggu setelah persalinan. Masa ini mencakup proses pemulihan fisik dan psikologis ibu, serta adaptasi terhadap peran baru sebagai orang tua.

Komplikasi Postpartum

Adalah berbagai gangguan kesehatan yang bisa terjadi selama masa nifas, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Komplikasi ini mencakup perdarahan, infeksi, gangguan psikologis, retensi plasenta, gangguan laktasi, dan trombosis vena dalam.

Perdarahan Postpartum (Postpartum Hemorrhage/PPH)

Salah satu penyebab utama kematian ibu, yang ditandai dengan kehilangan darah ≥ 500 ml setelah persalinan normal atau ≥ 1000 ml setelah operasi sesar. PPH dibedakan menjadi perdarahan primer (dalam 24 jam pertama) dan sekunder (hingga enam minggu postpartum).

Infeksi Puerperalis

Infeksi yang menyerang saluran reproduksi atau area tubuh lain pada ibu dalam masa nifas, seperti endometritis, infeksi luka jahitan, dan infeksi saluran kemih. Gejala umumnya berupa demam, nyeri perut bawah, dan keputihan abnormal.

Retensi Plasenta

Kondisi di mana sebagian atau seluruh jaringan plasenta gagal dikeluarkan dalam waktu 30 menit setelah persalinan. Hal ini dapat menyebabkan perdarahan terus-menerus dan meningkatkan risiko infeksi serius.

Gangguan Laktasi

Kesulitan dalam proses menyusui yang meliputi produksi ASI tidak mencukupi, mastitis, atau pelekatan yang tidak tepat. Gangguan ini dapat mengganggu pemberian nutrisi bayi dan kesejahteraan emosional ibu.

Deep Vein Thrombosis (DVT)

Kondisi di mana terbentuk bekuan darah di pembuluh darah vena dalam, umumnya pada tungkai bawah. DVT dapat menyebabkan komplikasi serius jika bekuan darah berpindah ke paru-paru dan menyebabkan emboli paru.

Baby Blues dan Depresi Postpartum

Baby blues merupakan perubahan suasana hati yang wajar dan bersifat sementara setelah persalinan. Sementara itu, depresi postpartum adalah gangguan mental serius yang ditandai dengan kesedihan mendalam, kecemasan, dan gangguan tidur yang menetap.

Evidence-Based Practice (EBP)

Merupakan pendekatan klinis yang menggabungkan bukti ilmiah terkini, keahlian klinis tenaga kesehatan, dan preferensi serta nilai-nilai pasien. Dalam kebidanan, EBP menjadi prinsip penting untuk menjamin mutu dan keselamatan pelayanan.

Active Management of Third Stage of Labour (AMTSL)

Suatu prosedur aktif dalam penanganan kala III persalinan yang meliputi pemberian uterotonika segera setelah bayi lahir, traksi tali pusat terkendali, dan pemijatan uterus untuk mencegah terjadinya perdarahan postpartum.

CHAPTER 4

IDENTIFIKASI DINI DAN MANAJEMEN DEPRESI POSTPARTUM

Handayani, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

A. Pendahuluan/Prolog

Masa pasca persalinan sering digambarkan sebagai periode yang penuh kebahagiaan, namun kenyataannya tidak semua ibu mampu menjalani fase ini dengan perasaan positif. Berbagai tuntutan fisik, perubahan hormonal, serta dinamika sosial dan psikologis dapat memunculkan tantangan besar bagi kesehatan mental ibu. Salah satu masalah yang sering muncul tetapi kerap terabaikan adalah depresi postpartum, sebuah kondisi gangguan suasana hati yang tidak hanya menurunkan kualitas hidup ibu, tetapi juga berdampak serius pada tumbuh kembang anak serta keharmonisan keluarga.

Secara global, prevalensi depresi postpartum diperkirakan mencapai 10–20% dari total ibu melahirkan, dengan angka yang lebih tinggi ditemukan di negara berkembang termasuk Indonesia (O'Hara & Wisner, 2023; Wang et al., 2021; World Health Organization [WHO], 2022). Penelitian di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan bahwa angka kejadian depresi postpartum dapat mencapai lebih dari 25%, terutama pada ibu dengan dukungan sosial rendah, kondisi ekonomi yang terbatas, atau pengalaman persalinan yang traumatis (Andajani-Sutjahjo et al., 2020). Situasi ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental pascapersalinan bukanlah isu minor, melainkan fenomena klinis dan sosial yang perlu ditangani secara serius dalam praktik kebidanan modern.

Depresi postpartum sering kali tidak teridentifikasi sejak awal karena gejalanya dapat menyerupai kelelahan pasca persalinan biasa atau kondisi baby blues yang dialami sebagian besar ibu. Akibatnya, deteksi terlambat menyebabkan intervensi menjadi tidak optimal dan memperbesar risiko komplikasi psikologis jangka panjang, termasuk gangguan ikatan ibu-bayi, keterlambatan perkembangan anak, hingga risiko percobaan bunuh diri pada ibu (Shorey & Chan, 2021; Stein et al., 2022). Oleh karena itu, identifikasi dini melalui skrining yang sistematis dan berbasis bukti menjadi sangat penting untuk memutus rantai dampak negatif yang mungkin timbul.

Dalam konteks kebidanan, bidan memegang peranan kunci tidak hanya dalam mendeteksi tanda-tanda awal depresi postpartum, tetapi juga dalam memberikan

manajemen awal yang sesuai, memberikan konseling dasar, serta melakukan rujukan bila diperlukan. Mengingat pelayanan kebidanan berfokus pada pendekatan holistik dan berpusat pada ibu, maka integrasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam menangani depresi postpartum sangat relevan untuk meningkatkan mutu layanan pascapersalinan (Kemenkes RI, 2021).

B. Konsep Depresi Postpartum dalam Perspektif Kebidanan Modern

Depresi postpartum merupakan gangguan suasana hati yang muncul setelah persalinan, ditandai dengan rasa sedih berkepanjangan, hilangnya minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, kelelahan ekstrem, hingga munculnya perasaan bersalah berlebihan yang mengganggu fungsi ibu dalam merawat dirinya maupun bayinya. Kondisi ini berbeda dengan baby blues yang biasanya terjadi dalam beberapa hari pertama setelah persalinan dan akan membaik secara spontan dalam waktu dua minggu. Depresi postpartum memiliki durasi lebih panjang, gejala lebih berat, serta membutuhkan intervensi klinis yang tepat (O'Hara & Wisner, 2023).

Dalam perspektif kebidanan modern, depresi postpartum tidak hanya dipahami sebagai gangguan mental individu, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Perubahan hormonal pascapersalinan, khususnya penurunan kadar estrogen dan progesteron, berperan dalam memicu gangguan mood. Namun, faktor non-biologis seperti rendahnya dukungan pasangan, stres ekonomi, pengalaman persalinan yang traumatis, hingga norma budaya yang membatasi ekspresi emosi perempuan turut memperberat risiko terjadinya depresi postpartum (Shorey & Chan, 2021).

Bidan sebagai tenaga kesehatan yang mendampingi ibu sejak masa antenatal, persalinan, hingga nifas memiliki posisi strategis dalam mengenali tanda-tanda awal depresi postpartum. Perspektif kebidanan modern menekankan bahwa kesehatan ibu bukan hanya bebas dari penyakit fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental dan emosional. Oleh karena itu, praktik kebidanan harus mengintegrasikan pendekatan biopsikososial, termasuk dalam pencegahan dan penanganan depresi postpartum (Kemenkes RI, 2021).

Selain itu, pemahaman modern juga menekankan pentingnya melihat depresi postpartum dalam kerangka keberlanjutan kesehatan ibu dan anak. Gangguan mental pascapersalinan tidak hanya berpengaruh pada ikatan emosional ibu dan bayi, tetapi juga berdampak pada pola menyusui, kualitas tidur bayi, serta perkembangan kognitif dan emosional anak. Kajian terbaru menunjukkan bahwa anak dari ibu dengan depresi postpartum berisiko lebih tinggi mengalami gangguan perkembangan bahasa dan perilaku pada usia dini (Stein et al., 2022). Fakta ini memperkuat urgensi bahwa deteksi dan intervensi tidak boleh ditunda.

Di era pelayanan kesehatan berbasis bukti, konsep depresi postpartum dalam kebidanan modern juga mencakup pemanfaatan instrumen skrining yang terstandar, intervensi berbasis komunitas, serta integrasi teknologi digital. Aplikasi kesehatan maternal yang dilengkapi fitur pemantauan gejala psikologis kini mulai digunakan sebagai sarana deteksi awal dan pendampingan ibu. Hal ini membuka peluang bagi bidan untuk memperluas perannya, tidak hanya di ruang praktik tetapi juga melalui media digital, dalam upaya mendukung kesehatan mental ibu pascapersalinan (Kendall-Tackett, 2024).

Dengan demikian, konsep depresi postpartum dalam kebidanan modern tidak lagi dipandang semata sebagai masalah psikologis, tetapi sebagai isu kesehatan reproduksi yang menuntut pendekatan komprehensif, kolaboratif, dan kontekstual. Bidan perlu memiliki kepekaan klinis, keterampilan komunikasi, serta dukungan sistem untuk dapat memberikan asuhan yang menyeluruh, berkesinambungan, dan berpusat pada ibu.

C. Faktor Risiko dan Determinan Depresi Postpartum

Depresi postpartum tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil interaksi yang kompleks antara faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Pemahaman yang komprehensif mengenai faktor risiko ini penting agar bidan dapat melakukan skrining secara lebih tepat, serta menyusun strategi pencegahan yang relevan dengan konteks kehidupan ibu dan keluarganya.

1. Faktor Biologis

Perubahan hormonal drastis setelah melahirkan, khususnya penurunan kadar estrogen dan progesteron, diyakini memicu gangguan mood pada sebagian perempuan. Kondisi ini dapat diperparah oleh riwayat pribadi atau keluarga dengan gangguan depresi maupun kecemasan (O'Hara & Wisner, 2023). Faktor biologis lain yang juga berkontribusi adalah komplikasi obstetri, anemia, gangguan tidur akibat menyusui, serta kelelahan fisik pasca persalinan.

2. Faktor Psikologis

Kerentanan psikologis memiliki peran penting dalam timbulnya depresi postpartum. Ibu dengan tingkat stres tinggi, rendahnya kepercayaan diri dalam merawat bayi, serta pengalaman persalinan yang traumatis lebih rentan mengalami depresi (Shorey & Chan, 2021). Perasaan gagal sebagai seorang ibu, rasa bersalah karena kesulitan menyusui, atau ekspektasi yang tidak realistis dari lingkungan juga sering memperberat kondisi ini.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Ketersediaan dukungan sosial, terutama dari pasangan dan keluarga, merupakan determinan utama dalam kesehatan mental ibu pascapersalinan.

Rendahnya dukungan emosional, konflik rumah tangga, atau isolasi sosial terbukti meningkatkan risiko depresi postpartum (Stein et al., 2022). Dalam budaya tertentu, norma gender yang menuntut ibu untuk selalu kuat dan tidak boleh mengungkapkan kelemahan emosional dapat membuat gejala depresi terpendam dan sulit dikenali.

4. Faktor Ekonomi dan Lingkungan

Tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh. Ibu yang hidup dalam kondisi sosial-ekonomi rendah, tidak memiliki akses layanan kesehatan, atau bekerja di lingkungan dengan tekanan tinggi lebih mudah mengalami depresi postpartum (Kemenkes RI, 2021). Selain itu, tinggal di lingkungan dengan keterbatasan fasilitas kesehatan, perumahan yang padat, atau paparan kekerasan rumah tangga menambah risiko kesehatan mental ibu.

5. Perbedaan Konteks Perkotaan dan Pedesaan

Penelitian terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa determinan depresi postpartum memiliki variasi berdasarkan konteks tempat tinggal. Di wilayah perkotaan, faktor pemicu sering berkaitan dengan kesibukan kerja, tekanan karier, serta minimnya dukungan dari pasangan yang sibuk. Sementara di pedesaan, faktor yang dominan adalah keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya literasi kesehatan mental, serta pengaruh norma budaya yang lebih kuat (Andajani-Sutjahjo et al., 2020).

D. Pentingnya Identifikasi Dini dalam Praktik Kebidanan

Depresi postpartum sering kali digambarkan sebagai *silent suffering*, karena banyak ibu yang mengalaminya tetapi tidak terdeteksi sejak awal. Hal ini terjadi karena gejalanya kerap dianggap wajar sebagai bagian dari kelelahan pascapersalinan. Padahal, keterlambatan diagnosis dan intervensi dapat memperburuk kondisi ibu, mengganggu perkembangan bayi, bahkan meningkatkan risiko komplikasi psikologis jangka panjang (Shorey & Chan, 2021; Stein et al., 2022). Oleh karena itu, identifikasi dini menjadi salah satu pilar penting dalam praktik kebidanan modern.

Deteksi dini memungkinkan intervensi dilakukan pada fase awal sebelum gejala berkembang menjadi lebih berat. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang teridentifikasi lebih cepat memiliki peluang pemulihan lebih baik, dengan dampak positif terhadap ikatan ibu-bayi, keberhasilan menyusui, serta kesejahteraan keluarga (O'Hara & Wisner, 2023; Wang et al., 2021). Selain itu, skrining sejak dini dapat menurunkan beban biaya perawatan kesehatan jangka panjang karena mencegah komplikasi psikologis yang lebih serius.

Bidan sebagai tenaga terdepan dalam pelayanan maternal perlu memiliki kepekaan dalam mengenali tanda awal depresi postpartum. Beberapa gejala yang kerap muncul antara lain: perasaan sedih atau putus asa yang menetap, kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari termasuk interaksi dengan bayi, gangguan tidur yang tidak hanya disebabkan oleh jadwal menyusui, perasaan bersalah atau merasa tidak mampu menjadi ibu yang baik dan munculnya pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayinya. Gejala-gejala ini sering disamarkan oleh ibu atau bahkan diabaikan oleh lingkungan karena minimnya pengetahuan mengenai kesehatan mental pascapersalinan (Stein et al., 2022).

Meski urgensinya tinggi, deteksi dini sering kali terkendala berbagai faktor. Stigma terhadap gangguan mental membuat sebagian ibu enggan mengungkapkan keluhannya. Dari sisi tenaga kesehatan, keterbatasan waktu pemeriksaan nifas, kurangnya pelatihan tentang kesehatan jiwa maternal, serta belum tersedianya instrumen skrining rutin menjadi hambatan yang nyata (Kemenkes RI, 2021; Motrico et al., 2023).

E. Peran Bidan dalam Sistem Deteksi Dini

Dalam kerangka kebidanan modern, bidan tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan fisik pascapersalinan, tetapi juga sebagai penggerak deteksi kesehatan mental ibu. Penerapan skrining standar, pencatatan gejala psikologis, serta komunikasi empatik menjadi bagian integral dari pelayanan. Selain itu, bidan dapat mengoptimalkan kunjungan rumah dan memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi pemantauan psikologis, untuk memperluas akses deteksi dini (Kendall-Tackett, 2024; World Health Organization [WHO], 2022).

Dengan demikian, identifikasi dini depresi postpartum tidak sekadar sebuah prosedur tambahan, melainkan suatu strategi esensial dalam meningkatkan mutu layanan kebidanan. Upaya ini menjadi jembatan menuju intervensi yang lebih efektif, mencegah terjadinya komplikasi, dan memperkuat peran bidan dalam menjaga kesejahteraan ibu di masa pasca persalinan.

Upaya identifikasi dini depresi postpartum akan lebih efektif jika dilakukan secara sistematis menggunakan alat skrining yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Dalam praktik kebidanan modern, instrumen skrining tidak hanya berfungsi untuk menegakkan diagnosis awal, tetapi juga sebagai sarana komunikasi, membantu ibu mengungkapkan pengalaman emosionalnya yang sering sulit disampaikan secara lisan.

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) adalah instrumen paling banyak digunakan di seluruh dunia untuk skrining depresi postpartum. Terdiri dari 10 pertanyaan sederhana yang mengevaluasi perasaan ibu selama tujuh hari terakhir,

EPDS mudah diterapkan di layanan primer maupun komunitas. Skor ≥ 13 umumnya digunakan sebagai ambang indikasi adanya depresi postpartum, meskipun penyesuaian *cut-off* perlu mempertimbangkan konteks budaya lokal (Shorey & Chan, 2021). Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa EPDS memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang baik dalam mendeteksi depresi postpartum (Andajani-Sutjahjo et al., 2020).

Postpartum Depression Screening Scale (PDSS) dikembangkan lebih komprehensif dengan 35 item yang mengeksplorasi aspek emosi, kognisi, dan perilaku terkait pengalaman postpartum. Instrumen ini memberikan gambaran lebih luas mengenai spektrum depresi, termasuk perasaan ambivalen terhadap keibuan. Kelemahannya adalah waktu pengisian lebih lama dibandingkan EPDS, sehingga lebih cocok digunakan di fasilitas dengan sumber daya cukup (O'Hara & Wisner, 2023).

Patient Health Questionnaire (PHQ-9) awalnya dirancang untuk deteksi depresi umum, tetapi terbukti juga efektif untuk ibu pascapersalinan. Instrumen ini menilai intensitas gejala depresi selama dua minggu terakhir, dengan klasifikasi tingkat keparahan. Kelebihannya adalah fleksibel digunakan lintas kelompok populasi, sehingga bermanfaat di layanan kesehatan yang mengintegrasikan skrining kesehatan jiwa (Stein et al., 2022; Wang et al., 2021).

Metode observasi klinis dan wawancara terstruktur digunakan dengan mengandalkan keterampilan observasi klinis bidan. Kontak tatap muka selama kunjungan nifas memungkinkan bidan menangkap tanda nonverbal, seperti ekspresi wajah datar, kesulitan menjalin kontak mata dengan bayi, atau tangisan mudah. Wawancara empatik yang terstruktur membantu menggali pengalaman ibu tanpa membuatnya merasa dihakimi (Kendall-Tackett, 2024). Waktu ideal untuk melakukan skrining sebaiknya tidak hanya dilakukan sekali. Beberapa literatur merekomendasikan jadwal skrining berulang, misalnya: saat kunjungan antenatal trimester ketiga, minggu pertama pascapersalinan, minggu keenam pascapersalinan, serta pada kunjungan lanjutan bila ditemukan faktor risiko. Strategi ini memastikan bahwa kasus yang muncul terlambat tidak terlewatkan (WHO, 2022).

Bidan dapat mengintegrasikan skrining depresi postpartum sebagai bagian dari pemeriksaan rutin nifas. Penggunaan instrumen yang ringkas seperti EPDS membuat proses ini tetap efisien. Hasil skrining harus didokumentasikan dengan baik, dan bila ditemukan skor tinggi, bidan perlu melakukan konseling awal serta rujukan ke tenaga kesehatan jiwa sesuai alur layanan (Kemenkes RI, 2021).

Dengan penerapan instrumen yang tepat dan pendekatan empatik, skrining depresi postpartum tidak hanya menjadi prosedur teknis, tetapi juga sarana memperkuat hubungan kepercayaan antara bidan dan ibu. Hal ini mendukung

terciptanya layanan kebidanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kesehatan mental perempuan pascapersalinan.

F. Pendekatan Manajemen Depresi Postpartum

Manajemen depresi postpartum memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan intervensi psikososial, farmakologis, dan komplementer, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan unik setiap ibu. Pendekatan ini harus bersifat holistik, kolaboratif, dan berjenjang, di mana bidan berperan penting sebagai pendamping utama sekaligus penghubung antara ibu dengan sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas.

Intervensi psikososial merupakan lini pertama dalam penanganan depresi postpartum, terutama untuk kasus dengan gejala ringan hingga sedang. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Konseling individual

Bidan dapat memberikan ruang aman bagi ibu untuk mengekspresikan perasaan dan ketakutannya. Teknik komunikasi empatik dan non-judgmental membantu ibu merasa dipahami, sehingga mengurangi isolasi emosional.

2. Terapi berbasis kognitif-perilaku (Cognitive Behavioral Therapy/CBT)

Terapi ini membantu ibu mengidentifikasi pikiran negatif dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih adaptif. Penelitian menunjukkan CBT efektif menurunkan gejala depresi pascapersalinan (Shorey & Chan, 2021).

3. Interpersonal Therapy (IPT)

Fokus pada perbaikan relasi interpersonal, terutama dengan pasangan dan keluarga, sehingga sangat relevan pada konteks postpartum.

4. Dukungan sebaya (peer support)

Kelompok dukungan ibu yang mengalami pengalaman serupa terbukti dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi gejala depresi (Stein et al., 2022).

Pada kasus depresi postpartum yang tergolong sedang hingga berat, intervensi farmakologis menjadi pertimbangan. Intervensi farmakologis yang dapat digunakan adalah:

1. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs), seperti sertraline, merupakan obat lini pertama karena relatif aman digunakan pada ibu menyusui (O'Hara & Wisner, 2023).
2. Pemilihan obat harus mempertimbangkan keamanan bayi, efek samping, serta kepatuhan ibu dalam minum obat.
3. Bidan berperan dalam mengedukasi ibu tentang penggunaan obat dan memantau kondisi klinis, namun pemberian resep dan pengaturan dosis tetap merupakan kewenangan psikiater atau dokter spesialis.

Selain pendekatan medis, intervensi komplementer juga semakin diakui sebagai strategi pendukung, diantaranya adalah:

1. Mindfulness dan meditasi dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan regulasi emosi.
2. Aktivitas fisik ringan, seperti jalan santai atau yoga postpartum, terbukti berkontribusi pada peningkatan suasana hati.
3. Nutrisi seimbang, terutama yang kaya omega-3 dan zat besi, mendukung pemulihan kesehatan mental dan fisik ibu (Kendall-Tackett, 2024).
4. Praktik berbasis budaya lokal, seperti ritual tradisional pascapersalinan, dapat menjadi sarana pemulihan emosional jika dilakukan dengan pendekatan yang aman dan kontekstual.

Bidan berperan penting dalam tahap awal manajemen depresi postpartum yaitu: melakukan konseling dasar dan memberikan edukasi kepada ibu serta keluarga, memfasilitasi dukungan kelompok atau kegiatan komunitas, melakukan rujukan tepat waktu ke psikiater atau psikolog bila gejala memburuk dan mendokumentasikan hasil intervensi dan memantau perkembangan ibu selama masa nifas. Dengan keterlibatan bidan yang proaktif, manajemen depresi postpartum dapat dilakukan secara lebih berkesinambungan dan berorientasi pada kebutuhan ibu, sehingga meminimalisasi risiko komplikasi jangka panjang baik pada ibu maupun bayi.

G. Peran Tenaga Kebidanan dalam Pencegahan dan Manajemen Depresi Postpartum

Tenaga kebidanan, khususnya bidan yang mendampingi wanita dari kehamilan hingga masa nifas, berada pada posisi strategis untuk mencegah, mendeteksi, dan mengelola depresi postpartum. Peran ini melampaui pemeriksaan fisik; ia meliputi kemampuan membangun hubungan kepercayaan, melakukan skrining berulang, memberikan intervensi psikososial dasar, dan mengoordinasikan rujukan pada level layanan yang tepat. Pendekatan kebidanan yang proaktif dan empatik dapat mengubah *silent suffering* menjadi proses pemulihan yang terarah dan bermartabat bagi ibu dan keluarga (World Health Organization [WHO], 2022). Peran Bidan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran Preventif Pendidikan, Persiapan, dan Penguatan Dukungan Sosial. Pencegahan depresi postpartum dimulai sejak kehamilan. Bidan harus memasukkan pendidikan kesehatan mental ke dalam paket antenatal: memberi informasi tentang perbedaan *baby blues* dan depresi postpartum, tanda peringatan, serta strategi *coping* praktis (istirahat, delegasi tugas, teknik relaksasi). Selain itu, intervensi pencegahan yang menargetkan ibu berisiko

tinggi—misalnya dengan riwayat depresi, dukungan sosial lemah, atau komplikasi obstetri—terbukti efektif bila diberikan secara terstruktur (Rodríguez-Gallego et al., 2024). Penguatan jaringan dukungan (pasangan, keluarga inti, kelompok ibu sebaya) menjadi fondasi penting yang dapat mengurangi risiko manifestasi depresi setelah melahirkan.

2. **Skrining Terpadu oleh Bidan Praktik Rutin dan Berjenjang.** Bidan dapat mengintegrasikan skrining psikologis (misalnya EPDS atau PHQ-9) ke dalam kunjungan antenatal akhir dan kunjungan nifas berulang. Model skrining universal maupun berbasis risiko sama-sama dapat diterapkan, asalkan didukung protokol yang jelas—meliputi kapan skrining dilakukan, siapa yang mencatat, tindakan lanjutan bila hasil positif, dan bagaimana dokumentasinya. Implementasi skrining tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus diikuti tindak lanjut klinis, konseling, atau rujukan (American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2023).
3. **Intervensi Awal yang Dapat Dilakukan Bidan (*First-line/Low-intensity*).** Untuk ibu dengan gejala ringan–sedang, bidan dapat memberi intervensi awal yang aman dan berbasis bukti, antara lain: Psychoeducation yang menjelaskan kondisi, menormalkan pengalaman, dan menyusun rencana praktis (istirahat terjadwal, dukungan tugas rumah). Konseling singkat berfokus pada solusi atau *motivational interviewing* untuk meningkatkan keterlibatan ibu dalam perawatan diri. Fasilitasi dukungan sebaya, seperti kelompok menyusui atau kelompok ibu lokal, yang terbukti dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memperpanjang pemberian ASI eksklusif (Shorey & Chan, 2021). Intervensi ini harus dilakukan dengan nada empatik, mendengarkan aktif, dan tanpa menghakimi. Bila tidak terjadi perbaikan atau muncul gejala berat, bidan wajib melakukan rujukan cepat ke layanan spesialis (Stein et al., 2022).
4. **Koordinasi Rujukan dan Kolaborasi Interprofesional.** Bidan bukan pengganti psikiater atau psikolog klinis, tetapi merupakan agen penghubung yang memastikan ibu menerima perawatan tepat waktu. Tugas ini mencakup mengenali tanda bahaya (seperti *suicidal ideation* atau pikiran menyakiti bayi), mengatur rujukan ke layanan kesehatan mental, dan menjaga komunikasi antarprofesional (dokter kandungan, dokter keluarga, psikiater, psikolog). Sistem rujukan yang jelas dan jalur komunikasi yang cepat mengurangi jeda waktu dari identifikasi hingga penatalaksanaan definitif, yang berpengaruh terhadap *outcome* klinis (ACOG, 2023).
5. **Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Bidan.** Agar peran ini dijalankan secara efektif, bidan memerlukan pelatihan praktis tentang skrining perinatal, teknik konseling dasar, manajemen krisis psikiatri sederhana, serta pemahaman tentang

farmakoterapi perinatal dalam batas kewenangan praktik. Studi menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan kepercayaan diri bidan melalui pelatihan meningkatkan frekuensi skrining dan intervensi awal (Nechaeva et al., 2024). Implementasi modul kesehatan mental perinatal dalam pendidikan kebidanan dan program *in-service training* perlu diprioritaskan (Kemenkes RI, 2021).

6. Pemanfaatan Teknologi dan Pendekatan Komunitas. Teknologi (telekonseling, aplikasi *self-monitoring*, pengingat skrining) menawarkan cara untuk memperluas jangkauan layanan, terutama di wilayah dengan keterbatasan tenaga spesialis. Sementara itu, model berbasis komunitas seperti kelompok dukungan ibu yang difasilitasi bidan di puskesmas dapat mendorong keberlanjutan dukungan sosial. Kombinasi layanan klinis dan dukungan komunitas memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan (WHO, 2022).
7. Pengukuran Mutu Layanan Kebidanan pada Aspek Kesehatan Mental. Untuk memastikan intervensi memiliki dampak nyata, fasilitas perlu mengukur indikator mutu: proporsi ibu yang diskining sesuai protokol, waktu rata-rata rujukan ke layanan kesehatan mental, tingkat kepuasan ibu terhadap dukungan psikosocial, dan *outcome* klinis seperti penurunan skor EPDS setelah intervensi. Data ini bermanfaat untuk audit layanan, perbaikan berkelanjutan, serta advokasi penguatan sumber daya (Policy Center for Maternal Mental Health, 2023).

H. Tantangan dan Peluang dalam Identifikasi Dini dan Manajemen Depresi Postpartum

Upaya identifikasi dini dan manajemen depresi postpartum tidak terlepas dari berbagai hambatan di lapangan. Tantangan ini muncul dari aspek individu, keluarga, tenaga kesehatan, hingga sistem pelayanan. Namun, di balik setiap hambatan terdapat peluang untuk melakukan inovasi dan memperkuat layanan kebidanan agar lebih responsif terhadap kesehatan mental ibu pascapersalinan. Depresi postpartum masih dianggap tabu di banyak komunitas. Banyak ibu merasa bersalah atau takut dicap “ibu yang gagal” bila mengungkapkan perasaan negatif setelah melahirkan. Stigma ini menyebabkan banyak kasus tidak terdeteksi hingga gejala memburuk (Nechaeva et al., 2024).

Tidak semua bidan memiliki pelatihan formal dalam kesehatan mental perinatal. Kurangnya pengetahuan mengenai instrumen skrining, teknik konseling, atau tanda bahaya psikiatri membuat sebagian tenaga kesehatan ragu melakukan deteksi dan intervensi awal (Rodríguez-Gallego et al., 2024). Di fasilitas kesehatan primer, beban kerja tinggi sering membuat skrining kesehatan mental tidak menjadi prioritas. Selain itu, keterbatasan akses ke psikolog atau psikiater memperpanjang waktu rujukan dan menurunkan kontinuitas layanan (Motrico et al., 2023). Ibu

dengan kondisi ekonomi rendah, status pekerjaan yang rentan, dan minimnya dukungan pasangan lebih berisiko mengalami depresi postpartum. Sayangnya, mereka juga merupakan kelompok yang paling sulit mengakses layanan kesehatan mental karena hambatan biaya maupun jarak (WHO, 2022).

Program kebidanan modern memberi peluang besar untuk memasukkan skrining kesehatan mental sebagai standar rutin dalam kunjungan antenatal dan postnatal. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan deteksi dini, tetapi juga memperluas pemahaman bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik (American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2023). Meningkatkan kompetensi bidan melalui pelatihan berkelanjutan dalam bidang konseling, penggunaan instrumen skrining, serta teknik manajemen awal dapat memperluas cakupan intervensi. Studi menunjukkan bahwa pelatihan sederhana sekalipun mampu meningkatkan keberanian bidan dalam melakukan skrining perinatal (Shorey & Chan, 2021). Layanan telehealth, aplikasi skrining mandiri, hingga dukungan kelompok virtual membuka peluang untuk menjangkau ibu di daerah terpencil. Teknologi juga memungkinkan monitoring gejala lebih sistematis, dengan tetap melibatkan bidan sebagai pendamping utama (Stein et al., 2022).

Program berbasis komunitas, seperti kelompok pendukung ibu yang difasilitasi bidan atau kader kesehatan, berpotensi menjadi jembatan penting untuk mengurangi stigma sekaligus meningkatkan keberlanjutan dukungan. Kolaborasi lintas sektor dengan tokoh masyarakat, organisasi perempuan, maupun lembaga keagamaan juga dapat memperluas jangkauan intervensi (Kemenkes RI, 2021). Momentum meningkatnya perhatian global terhadap kesehatan mental ibu memberikan peluang advokasi agar skrining dan manajemen depresi postpartum dimasukkan ke dalam standar nasional pelayanan kebidanan. Dukungan kebijakan dapat memfasilitasi alokasi sumber daya, pelatihan, dan penguatan sistem rujukan (Policy Center for Maternal Mental Health, 2023).

I. Simpulan

Depresi postpartum merupakan masalah kesehatan mental serius yang dapat mengganggu kualitas hidup ibu, ikatan ibu-bayi, serta kesejahteraan keluarga. Kondisi ini kerap terabaikan akibat stigma, keterbatasan pengetahuan, dan minimnya akses layanan kesehatan mental. Padahal, bukti ilmiah menunjukkan bahwa deteksi dini dan manajemen yang tepat dapat mencegah dampak jangka panjang baik secara psikologis maupun sosial (Shorey & Chan, 2021; WHO, 2022).

Dalam perspektif kebidanan modern, identifikasi dini harus menjadi bagian integral dari asuhan pascapersalinan. Skrining terstandar dengan instrumen valid, intervensi psikososial awal, serta sistem rujukan yang jelas menjadi kunci

keberhasilan penanganan. Bidan, dengan kedekatan peran dan kehadirannya di komunitas, memiliki posisi strategis untuk memimpin upaya ini (ACOG, 2023; Kemenkes RI, 2021).

Meskipun tantangan seperti stigma, keterbatasan sumber daya, dan beban kerja masih besar, peluang penguatan layanan tetap terbuka. Integrasi kesehatan mental ke dalam paket layanan kebidanan, pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan kebijakan nasional adalah arah strategis yang perlu terus diperjuangkan (Motrico et al., 2023; Stein et al., 2022).

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Integrasi skrining kesehatan mental ke dalam kunjungan antenatal dan postnatal dengan instrumen yang mudah diimplementasikan oleh bidan.
2. Penguatan kompetensi bidan melalui pelatihan berkelanjutan dalam bidang konseling dasar, skrining perinatal, dan manajemen awal depresi postpartum.
3. Pengembangan model layanan kolaboratif, di mana bidan berperan sebagai penghubung dengan psikolog, psikiater, dan dokter keluarga.
4. Peningkatan dukungan komunitas, termasuk kelompok sebaya dan program berbasis keluarga, untuk memperkuat jejaring sosial ibu.
5. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung skrining, monitoring, edukasi, dan telekonseling yang menjangkau daerah terpencil.
6. Advokasi kebijakan nasional, agar kesehatan mental ibu menjadi prioritas dalam agenda pelayanan kebidanan dan kesehatan reproduksi.

Melalui identifikasi dini dan manajemen yang terintegrasi, depresi postpartum dapat ditangani secara lebih efektif. Bidan tidak hanya berperan sebagai tenaga klinis, tetapi juga sebagai pendidik, konselor, dan advokat bagi ibu dan keluarga. Dengan menggabungkan pendekatan klinis, psikososial, dan komunitas, praktik kebidanan dapat menjadi benteng utama dalam menjaga kesehatan mental ibu pasca persalinan.

J. Referensi

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2023). *Screening for perinatal depression: ACOG clinical practice guideline. Obstetrics & Gynecology*, 141(1), 222–233. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000005011>
- Andajani-Sutjahjo, S., Manderson, L., Astbury, J., & Kristanto, A. (2020). Complex emotions, complex problems: Understanding the experiences of perinatal depression among women in Indonesia. *BMC Psychiatry*, 20(1), 482. <https://doi.org/10.1186/s12888-020-02894-0>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kendall-Tackett, K. (2024). *Depression in new mothers: Causes, consequences, and treatment alternatives* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003477360>
- Motrico, E., Bina, R., Domínguez-Salas, S., Mateus, V., & Chandra, P. S. (2023). Addressing perinatal mental health care gaps: Barriers and innovations. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 1990. <https://doi.org/10.3390/ijerph20031990>
- Nechaeva, N., Arzamasova, A., & Petrova, O. (2024). Stigma and barriers to mental health help-seeking among postpartum women: A cross-cultural perspective. *Frontiers in Global Women's Health*, 5, 1357921. <https://doi.org/10.3389/fgwh.2024.1357921>
- O'Hara, M. W., & Wisner, K. L. (2023). Perinatal mental illness: Definition, description, and aetiology. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 88, 101–113. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2023.102347>
- Policy Center for Maternal Mental Health. (2023). *Measuring quality in maternal mental health services*. <https://policycentermmh.org>
- Rodríguez-Gallego, I., López-Morales, H., & Salinas-Escudero, G. (2024). Midwives' knowledge, attitudes, and practices regarding perinatal mental health: A multicountry survey. *Women and Birth*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2024.01.004>
- Shorey, S., & Chan, S. W. C. (2021). Postnatal depression: A literature review. *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 34(3), 491–497. <https://doi.org/10.1080/14767058.2019.1572731>

- Stein, A., Pearson, R. M., Goodman, S. H., Rapa, E., Rahman, A., McCallum, M., Howard, L. M., & Pariante, C. M. (2022). Effects of perinatal mental disorders on the fetus and child. *The Lancet Psychiatry*, 9(5), 447–456. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(21\)00195-3](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00195-3)
- Wang, Z., Liu, J., Shuai, H., Cai, Z., Fu, X., Liu, Y., Xiao, X., & Liu, R. (2021). Mapping global prevalence of depression among postpartum women: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 727. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.727>
- World Health Organization. (2022). *Maternal mental health and child health and development in resource-constrained settings: Report of a UNFPA/WHO international expert meeting*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241503565>

K. Glosarium

Baby Blues

Gangguan suasana hati ringan yang biasanya muncul dalam beberapa hari pertama setelah melahirkan, ditandai dengan mudah menangis, cemas, dan mood yang tidak stabil. Kondisi ini biasanya hilang dalam waktu dua minggu tanpa intervensi medis.

Bidan

Tenaga kesehatan profesional yang memberikan asuhan menyeluruh kepada perempuan mulai dari kehamilan, persalinan, masa nifas, hingga kesehatan reproduksi. Dalam konteks depresi postpartum, bidan berperan penting dalam deteksi dini, konseling dasar, dan rujukan.

Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

Terapi psikologis berbasis kognitif dan perilaku yang membantu ibu mengidentifikasi pola pikir negatif, kemudian menggantinya dengan pikiran yang lebih adaptif. Efektif digunakan untuk menurunkan gejala depresi postpartum.

Depresi Postpartum

Gangguan suasana hati yang muncul setelah persalinan, ditandai dengan rasa sedih berkepanjangan, kehilangan minat, kelelahan, perasaan bersalah, hingga pikiran menyakiti diri atau bayi. Berbeda dari baby blues karena gejalanya lebih berat, berlangsung lebih lama, dan memerlukan intervensi klinis.

Deteksi Dini

Upaya mengidentifikasi gejala depresi postpartum sejak awal melalui observasi klinis, wawancara, maupun penggunaan instrumen skrining terstandar agar intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Dukungan Sosial

Bantuan emosional, praktis, dan psikologis yang diberikan oleh pasangan, keluarga, maupun komunitas kepada ibu pascapersalinan. Rendahnya dukungan sosial terbukti menjadi faktor risiko depresi postpartum.

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)

Instrumen skrining depresi postpartum yang paling banyak digunakan di dunia, terdiri dari 10 pertanyaan yang menilai kondisi emosional ibu selama 7 hari terakhir. Skor ≥ 13 mengindikasikan kemungkinan depresi postpartum.

Faktor Risiko

Kondisi atau keadaan yang meningkatkan kemungkinan seorang ibu mengalami depresi postpartum, misalnya perubahan hormonal, riwayat depresi, stres psikologis, rendahnya dukungan sosial, masalah ekonomi, atau pengalaman persalinan traumatis.

Interpersonal Therapy (IPT)

Terapi psikologis yang berfokus pada peningkatan kualitas hubungan interpersonal (terutama dengan pasangan dan keluarga) untuk membantu pemulihan depresi postpartum.

Intervensi Farmakologis

Pendekatan pengobatan depresi postpartum dengan obat-obatan antidepresan, seperti Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs), yang relatif aman digunakan pada ibu menyusui dengan pengawasan ketat dari psikiater/dokter.

Intervensi Psikososial

Strategi non-obat yang melibatkan konseling, terapi, dukungan sebaya, dan pendidikan kesehatan untuk membantu ibu mengatasi depresi postpartum.

Kesehatan Mental Perinatal

Aspek kesehatan mental yang mencakup masa kehamilan hingga satu tahun setelah melahirkan, termasuk pencegahan, deteksi, dan manajemen gangguan psikologis seperti depresi postpartum.

Kesejahteraan Ibu dan Bayi

Kondisi fisik, emosional, sosial, dan psikologis yang baik bagi ibu pascapersalinan dan bayinya. Depresi postpartum dapat mengganggu ikatan emosional, menyusui, tidur bayi, hingga perkembangan kognitif anak.

Observasi Klinis

Metode deteksi gejala depresi postpartum melalui pengamatan langsung oleh bidan, misalnya ekspresi wajah datar, kontak mata yang minim dengan bayi, atau tangisan yang berlebihan.

Patient Health Questionnaire (PHQ-9)

Instrumen penilaian depresi yang umum digunakan secara luas, juga efektif untuk mendeteksi depresi postpartum dengan menilai intensitas gejala selama dua minggu terakhir.

Postpartum Depression Screening Scale (PDSS)

Instrumen skrining yang lebih komprehensif dengan 35 pertanyaan, mengevaluasi aspek emosional, kognitif, dan perilaku ibu pascapersalinan.

Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif

Empat pilar upaya pelayanan kesehatan. Pada depresi postpartum, promotif dan preventif dilakukan melalui edukasi dan skrining dini, kuratif dengan intervensi psikososial dan farmakologis, serta rehabilitatif melalui dukungan berkelanjutan.

Skrining Psikologis

Proses sistematis menggunakan instrumen terstandar (misalnya EPDS, PDSS, PHQ-9) untuk mendeteksi dini kemungkinan depresi postpartum pada ibu.

Stigma

Pandangan negatif atau label buruk yang diberikan masyarakat terhadap ibu dengan gangguan kesehatan mental, sehingga membuat ibu enggan mengungkapkan masalahnya dan menghambat deteksi dini.

Teknologi Digital dalam Kebidanan

Pemanfaatan aplikasi kesehatan maternal, telekonseling, atau monitoring mandiri berbasis digital untuk mendukung deteksi dini, konseling, serta pendampingan ibu dengan depresi postpartum.

CHAPTER 5

PENDAMPINGAN DAN KONSELING KELUARGA PADA MASA NIFAS

Bdn. Putu Lusita Nati Indriani, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Masa nifas, yang berlangsung sejak lahirnya plasenta hingga enam minggu setelah persalinan, merupakan periode transisi yang sangat penting dan menentukan bagi kesehatan fisik, psikologis, dan sosial seorang ibu. Meskipun fase persalinan telah usai, masa nifas menyimpan berbagai tantangan dan potensi risiko yang bisa berdampak serius terhadap kesejahteraan ibu dan bayi jika tidak ditangani dengan optimal. Perubahan drastis yang terjadi selama masa ini mencakup penyesuaian hormonal, proses involusi uterus, penyembuhan luka perineum atau bekas operasi sesar, inisiasi menyusui, hingga penyesuaian terhadap peran baru sebagai ibu. Seluruh perubahan ini dapat menimbulkan tekanan fisik dan emosional yang tinggi bagi ibu, terutama jika tidak didampingi oleh dukungan sosial dan layanan kebidanan yang responsif.

Dalam konteks pelayanan kebidanan, masa nifas sering kali kurang mendapatkan perhatian yang setara dengan masa kehamilan dan persalinan. Padahal, berbagai penelitian dan laporan kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa komplikasi serius, seperti perdarahan lanjutan, infeksi puerperalis, gangguan laktasi, serta masalah psikologis seperti baby blues dan depresi postpartum, kerap muncul justru setelah ibu melahirkan. Banyak dari komplikasi ini dapat dicegah atau ditangani dengan cepat apabila tenaga kesehatan, terutama bidan, melakukan intervensi yang tepat dan berkesinambungan. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi pada masa nifas adalah konseling dan pendampingan keluarga.

Keluarga, khususnya suami dan ibu kandung, memegang peran penting dalam mendampingi ibu melalui masa pemulihan pasca persalinan. Keterlibatan mereka bukan hanya memberikan dukungan moral dan emosional, tetapi juga dapat berkontribusi dalam aspek praktis seperti perawatan luka, membantu proses menyusui, menjaga kebersihan lingkungan, hingga mendeteksi tanda-tanda bahaya sejak dini. Di sinilah peran bidan menjadi sangat strategis, yaitu sebagai fasilitator yang menjembatani pengetahuan dan keterampilan keluarga agar dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan ibu.

Konseling keluarga pada masa nifas bukan hanya sekadar menyampaikan informasi kesehatan, melainkan suatu proses komunikasi dua arah yang melibatkan empati, keterbukaan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan sosial keluarga. Melalui konseling yang efektif, keluarga dapat diberdayakan untuk menjadi mitra aktif dalam perawatan ibu dan bayi, meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menghadapi masa nifas, dan mencegah terjadinya keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang krusial. Dengan pendekatan ini, pelayanan kebidanan masa nifas menjadi lebih bersifat holistik, bukan hanya fokus pada aspek klinis, tetapi juga mencakup dimensi psikososial dan kultural yang tidak kalah penting.

Oleh karena itu, dalam bab ini akan dibahas secara mendalam mengenai berbagai strategi pendampingan dan konseling keluarga pada masa nifas. Pembahasan akan mencakup prinsip-prinsip komunikasi efektif, metode pendekatan yang relevan, peran bidan dalam pemberdayaan keluarga, serta tantangan-tantangan yang sering dihadapi dalam praktik pendampingan. Diharapkan, melalui pendekatan ini, kualitas pelayanan masa nifas dapat ditingkatkan, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

B. Konsep Dasar Masa Nifas dan Peran Keluarga

Masa nifas, atau puerperium, merupakan periode yang dimulai segera setelah lahirnya plasenta dan berlangsung selama kurang lebih enam minggu. Masa ini dibagi menjadi tiga fase, yaitu masa nifas dini (0–24 jam setelah persalinan), masa nifas intermediet (hari ke-2 hingga minggu ke-7), dan masa nifas lanjut (setelah minggu ke-7 hingga organ reproduksi kembali seperti sebelum hamil). Selama periode ini, tubuh ibu mengalami proses pemulihan dan penyesuaian besar-besaran, baik dari sisi fisiologis, psikologis, maupun sosial. Bila proses ini berlangsung dengan baik dan mendapat dukungan yang memadai, maka ibu dapat menjalani transisi ke peran barunya sebagai orang tua dengan lebih sehat dan percaya diri.

Secara fisiologis, perubahan yang terjadi meliputi involusi uterus (pengecilan rahim kembali ke ukuran semula), pengeluaran lochia (darah dan jaringan dari dalam rahim), penyembuhan luka jalan lahir atau sayatan operasi, dan penyesuaian sistem hormonal, termasuk produksi prolaktin dan oksitosin untuk menyusui. Pada saat bersamaan, ibu juga mengalami perubahan psikologis yang signifikan. Perasaan gembira karena telah melahirkan sering kali bercampur dengan kelelahan, kecemasan, bahkan perasaan tidak mampu menjalani peran sebagai ibu. Beberapa

ibu mengalami baby blues—kondisi emosional yang umum dan bersifat sementara—sedangkan sebagian lainnya bisa mengalami depresi postpartum yang lebih berat dan berkepanjangan jika tidak ditangani secara tepat.

Dalam situasi ini, dukungan dari keluarga menjadi komponen yang sangat penting. Keluarga berperan sebagai sistem pendukung pertama yang dapat memperkuat stabilitas emosional dan fisik ibu. Peran suami sangat penting, tidak hanya dalam aspek logistik, seperti membantu pekerjaan rumah tangga atau mengantar ke fasilitas kesehatan, tetapi juga dalam memberikan kehadiran emosional dan empati. Suami yang terlibat secara aktif akan memperkuat ikatan emosional dengan istri, mempercepat pemulihan, serta membangun dasar yang sehat bagi hubungan orang tua dan anak. Di sisi lain, ibu kandung atau anggota keluarga perempuan lainnya biasanya memberikan dukungan praktis seperti membantu menyusui, memandikan bayi, atau memberikan nasihat tradisional yang dapat memperkuat rasa percaya diri ibu baru.

Namun, perlu ditekankan bahwa keterlibatan keluarga harus diarahkan dengan pendekatan yang tepat oleh tenaga kesehatan, terutama bidan. Tidak semua informasi yang beredar di masyarakat akurat atau sesuai dengan prinsip kesehatan yang terkini. Oleh karena itu, bidan memiliki peran penting dalam membimbing keluarga agar mampu memberikan dukungan yang benar, tepat, dan empatik kepada ibu. Melalui pendampingan yang disertai dengan edukasi, keluarga dapat menjadi mitra aktif dalam pelayanan kebidanan dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas asuhan masa nifas.

C. Prinsip-Prinsip Konseling Keluarga dalam Kebidanan

Konseling keluarga dalam kebidanan, khususnya pada masa nifas, merupakan bagian integral dari upaya pemberdayaan dan pendampingan keluarga dalam mendukung kesehatan ibu dan bayi secara optimal. Konseling tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang setara antara tenaga kesehatan dan keluarga, dengan tujuan membantu mereka memahami kondisi ibu, mengatasi kekhawatiran, dan mengambil keputusan yang tepat dalam perawatan pascapersalinan. Untuk mencapai efektivitas dalam proses konseling, dibutuhkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip dasar yang menyentuh aspek komunikasi, budaya, etika, dan hak individu.

Salah satu prinsip utama dalam konseling kebidanan adalah pendekatan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang dilakukan oleh bidan harus bersifat dua arah, terbuka, dan mudah dipahami oleh keluarga dengan latar belakang pendidikan dan budaya yang beragam. Dalam konteks ini, bidan perlu menghindari penggunaan istilah medis yang rumit dan menggantinya dengan bahasa yang lebih

familiar bagi masyarakat. Selain itu, komunikasi non-verbal, seperti kontak mata, ekspresi wajah yang hangat, dan sikap tubuh yang terbuka, memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang nyaman dan membuat keluarga merasa dihargai.

Konseling empatik juga menjadi pilar utama dalam pendekatan kebidanan. Empati bukan sekadar memahami perasaan ibu dan keluarganya, tetapi menunjukkan kepedulian secara aktif dan tulus. Bidan harus mampu mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi, memberikan umpan balik yang mendukung, serta menyesuaikan respon sesuai dengan situasi emosional yang sedang dihadapi oleh ibu dan keluarga. Ketika keluarga merasa didengar dan dimengerti, mereka lebih terbuka untuk berbagi kekhawatiran dan bersedia mengikuti arahan tenaga kesehatan.

Selanjutnya, penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan sosial dalam keluarga sangat penting untuk memastikan bahwa proses konseling relevan secara kontekstual. Setiap keluarga membawa latar belakang budaya yang unik, termasuk kepercayaan tradisional, praktik perawatan bayi, pola peran gender, dan cara pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Bidan perlu bersikap sensitif terhadap nilai-nilai tersebut dan tidak serta-merta menolaknya, melainkan mendiskusikannya dengan bijak serta mengedukasi berdasarkan prinsip ilmiah tanpa mencederai keyakinan yang diyakini keluarga. Kolaborasi antara kebijakan kesehatan dan kearifan lokal menjadi kunci dalam membangun pendekatan yang inklusif dan dapat diterima oleh masyarakat.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah confidentiality atau kerahasiaan informasi. Bidan harus menjaga privasi dan kerahasiaan data kesehatan ibu, termasuk riwayat kehamilan, kondisi emosional, atau tantangan yang dihadapi dalam masa nifas. Informasi hanya boleh dibagikan kepada pihak lain—termasuk anggota keluarga—dengan izin ibu atau jika situasi mengharuskan demi keselamatan pasien. Menjaga kerahasiaan menciptakan rasa aman bagi ibu dan membangun kepercayaan terhadap tenaga kesehatan.

Terakhir, prinsip informed choice harus selalu dijunjung tinggi dalam praktik konseling kebidanan. Setiap intervensi atau keputusan medis yang melibatkan ibu pascapersalinan dan bayinya harus didasarkan pada persetujuan yang diberikan secara sadar, setelah ibu dan keluarganya menerima informasi yang lengkap, jelas, dan jujur mengenai manfaat, risiko, dan alternatif yang tersedia. Bidan bertugas memastikan bahwa keputusan diambil secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan, dan memberikan ruang bagi ibu untuk mengajukan pertanyaan atau menunda keputusan jika diperlukan.

D. Metode Pendampingan Keluarga oleh Bidan

Pendampingan keluarga oleh bidan selama masa nifas merupakan strategi kunci dalam meningkatkan keterlibatan keluarga, mempercepat pemulihan ibu, serta mencegah dan menangani komplikasi pascapersalinan. Dalam pelaksanaannya, pendampingan ini harus disesuaikan dengan kondisi sosial, geografis, serta kebutuhan spesifik setiap keluarga. Oleh karena itu, bidan perlu menguasai berbagai metode pendampingan yang bersifat fleksibel dan berorientasi pada pemberdayaan keluarga. Pendampingan tidak hanya bertujuan memberikan informasi, tetapi juga menumbuhkan sikap tanggap dan dukungan berkelanjutan dari anggota keluarga terhadap ibu dan bayi.

Salah satu metode yang paling efektif dan umum digunakan adalah kunjungan rumah. Kunjungan ini dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan lain untuk memantau kondisi ibu dan bayi secara langsung di lingkungan tempat tinggalnya. Pendekatan ini memungkinkan bidan untuk menilai tidak hanya aspek medis, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan yang dapat memengaruhi proses pemulihan ibu. Dalam kunjungan rumah, bidan dapat melakukan pemeriksaan tanda vital, memeriksa luka perineum atau luka operasi, menilai proses involusi uterus dan produksi ASI, serta mengidentifikasi risiko psikososial seperti depresi postpartum. Di samping itu, kunjungan rumah menjadi momen yang tepat untuk memberikan edukasi praktis, seperti cara merawat bayi, menyusui yang benar, serta pentingnya dukungan emosional dari suami dan keluarga.

Selain kunjungan rumah, edukasi berbasis kelompok atau yang lebih dikenal dengan kelas ibu nifas juga merupakan metode pendampingan yang efektif dan efisien. Dalam forum ini, ibu-ibu yang berada dalam periode nifas berkumpul dan mendapatkan edukasi secara kolektif tentang berbagai topik penting, seperti kebersihan diri, tanda bahaya masa nifas, manajemen stres, menyusui eksklusif, dan kontrasepsi pascapersalinan. Kelas ini juga menjadi ruang sosial yang mendukung karena ibu-ibu dapat saling bertukar pengalaman dan saling menguatkan. Peran bidan dalam kelas ini sangat strategis sebagai fasilitator, edukator, dan pendamping yang membimbing diskusi, merespons pertanyaan, dan membangun suasana yang suportif. Keterlibatan suami atau anggota keluarga lainnya juga dapat dioptimalkan dalam forum ini untuk memperkuat dukungan internal keluarga.

Kemajuan teknologi juga telah memungkinkan diterapkannya komunikasi daring sebagai metode pendampingan alternatif. Pendekatan ini sangat berguna terutama di daerah dengan keterbatasan akses atau saat kondisi tidak memungkinkan untuk bertatap muka, seperti pada masa pandemi atau bagi ibu dengan keterbatasan mobilitas. Bidan dapat memanfaatkan platform seperti WhatsApp, Telegram, atau aplikasi telekonsultasi untuk melakukan komunikasi rutin,

memberikan pengingat jadwal kontrol, menjawab pertanyaan ibu, hingga melakukan skrining psikologis awal. Kelebihan metode ini adalah fleksibilitas waktu dan efisiensi sumber daya, namun tetap memerlukan etika komunikasi dan jaminan privasi.

Keberhasilan pendampingan keluarga pada masa nifas dapat diukur melalui berbagai indikator, baik dari sisi ibu maupun keluarga. Dari sisi ibu, indikator keberhasilan mencakup peningkatan pengetahuan tentang perawatan diri dan bayi, kepatuhan terhadap kunjungan nifas, status kesehatan fisik dan mental yang membaik, serta keberhasilan dalam menyusui. Dari sisi keluarga, indikator dapat dilihat dari tingkat keterlibatan suami atau keluarga dalam pengambilan keputusan, peningkatan komunikasi dalam keluarga, serta kemampuan memberikan dukungan emosional dan praktis kepada ibu. Evaluasi keberhasilan juga dapat dilakukan melalui pencatatan kegiatan pendampingan, umpan balik dari ibu dan keluarga, serta penurunan angka komplikasi pascanifas di wilayah kerja.

E. Materi Konseling Masa Nifas

Materi konseling pada masa nifas memiliki peran penting dalam memastikan pemulihan optimal bagi ibu dan bayi serta mencegah komplikasi yang dapat membahayakan kesehatan keduanya. Konseling ini bukan hanya sebagai proses transfer informasi, tetapi juga sebagai pendekatan pemberdayaan keluarga untuk terlibat aktif dalam perawatan ibu dan bayi pascapersalinan. Berikut adalah penjelasan materi konseling yang harus diberikan selama masa nifas:

Isi edukasi/konseling yang mencakup:

1. Perawatan luka perineum atau bekas SC

Bidan perlu mengedukasi ibu tentang cara merawat luka perineum atau luka sayatan akibat operasi sesar. Ibu dianjurkan menjaga kebersihan luka dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan area luka, menggunakan air hangat untuk membilas perineum dari arah depan ke belakang, dan mengganti pembalut secara rutin. Untuk luka operasi sesar, ibu diberi informasi mengenai pentingnya menjaga luka tetap kering dan bersih, menghindari tekanan pada area luka, serta mengenali tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, nyeri hebat, nanah, atau demam. Pencegahan infeksi juga ditekankan dengan pemberian antibiotik sesuai indikasi.

2. Pola istirahat dan nutrisi

Istirahat yang cukup sangat penting bagi proses pemulihan ibu. Konseling harus menjelaskan bahwa meskipun ibu memiliki tanggung jawab baru, penting untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Disarankan ibu tidur saat bayi tidur dan melibatkan keluarga untuk membantu pekerjaan rumah. Dari aspek nutrisi,

ibu membutuhkan asupan tinggi energi, protein, dan cairan untuk mempercepat penyembuhan luka dan mendukung produksi ASI. Konselor atau bidan perlu menjelaskan pentingnya makan makanan seimbang yang mencakup sayur, buah, protein hewani dan nabati, serta minum air minimal 2 liter per hari.

3. Psikologis ibu (baby blues dan postpartum depression)

Masa nifas merupakan periode emosional yang penuh perubahan. Konseling psikologis mencakup penjelasan tentang gejala normal baby blues seperti mudah menangis, cemas, dan mudah tersinggung, yang biasanya hilang dalam dua minggu. Namun, bidan juga harus memberi informasi mengenai gejala depresi postpartum yang lebih serius, seperti kehilangan minat, gangguan tidur berat, pikiran menyakiti diri atau bayi, serta rasa tidak mampu sebagai ibu. Jika gejala ini muncul, ibu harus segera dirujuk ke profesional kesehatan jiwa. Peran keluarga, terutama suami, dalam memahami kondisi emosional ibu juga harus ditekankan.

4. Perawatan bayi baru lahir

Materi ini mencakup cara merawat tali pusat agar tetap kering dan tidak terinfeksi, tanda-tanda bayi kuning yang perlu dipantau, cara memandikan bayi dengan aman, serta menjaga kehangatan tubuh bayi. Orang tua juga perlu dikenalkan dengan perilaku bayi normal, seperti frekuensi buang air kecil, pola tidur-bangun, serta cara menenangkan bayi yang menangis. Bidan harus memberi pemahaman bahwa setiap bayi memiliki irama unik, dan ibu tidak perlu cemas berlebihan selama bayi dalam kondisi sehat.

5. ASI eksklusif dan manajemen laktasi

Konseling menyusui harus mencakup penjelasan tentang pentingnya ASI eksklusif selama enam bulan pertama, manfaat ASI bagi ibu dan bayi, serta tanda bayi mendapatkan cukup ASI. Teknik pelekatan yang benar, posisi menyusui yang nyaman, dan penanganan masalah laktasi seperti puting lecet, payudara bengkak, atau mastitis juga perlu dibahas. Bidan harus mengajarkan ibu bagaimana memerah dan menyimpan ASI bila dibutuhkan, serta menjelaskan bahwa pemberian susu formula sebaiknya dihindari kecuali atas indikasi medis.

6. Kontrasepsi pascasalin

Pemilihan kontrasepsi menjadi topik penting dalam konseling nifas untuk mencegah kehamilan terlalu dekat yang dapat membahayakan kesehatan ibu. Bidan menjelaskan berbagai metode kontrasepsi seperti pil laktasi, suntik, IUD, implan, kondom, dan metode alami (LAM). Konseling harus bersifat non-diskriminatif dan menghargai keputusan ibu dan suami, serta dilakukan secara personal. Waktu yang tepat untuk memulai kontrasepsi juga disesuaikan dengan metode yang dipilih dan kondisi kesehatan ibu.

7. Tanda bahaya ibu dan bayi

Bidan harus mengedukasi ibu dan keluarga tentang tanda bahaya yang perlu diwaspadai dan segera dilaporkan ke fasilitas kesehatan. Untuk ibu, tanda bahaya meliputi perdarahan banyak, nyeri perut hebat, demam tinggi, keluar nanah dari luka, pusing, dan sesak napas. Pada bayi, tanda bahaya mencakup bayi tidak menyusu, demam, bayi terlalu mengantuk dan sulit dibangunkan, kejang, kulit atau mata menguning sebelum usia 24 jam, serta muntah berwarna hijau. Edukasi ini harus disampaikan dengan bahasa sederhana dan disertai contoh nyata agar mudah dipahami oleh keluarga.

F. Keterlibatan Suami dan Keluarga Inti

Keterlibatan suami dan keluarga inti dalam pendampingan masa nifas merupakan aspek fundamental dalam menciptakan lingkungan pemulihan yang sehat, aman, dan suportif bagi ibu pascapersalinan. Masa nifas tidak hanya menuntut perhatian dari sisi medis, tetapi juga dari sisi sosial dan emosional. Oleh karena itu, konseling dan pendampingan keluarga harus melibatkan suami, orang tua, atau anggota keluarga terdekat lainnya untuk memastikan bahwa ibu tidak menjalani masa transisi ini seorang diri.

Suami memiliki posisi strategis sebagai figur paling dekat dengan ibu setelah melahirkan. Peran suami bukan hanya sebagai penyedia kebutuhan material, tetapi juga sebagai penopang emosional utama. Dukungan dari suami dalam bentuk empati, perhatian, dan kesediaan berbagi tanggung jawab rumah tangga serta perawatan bayi terbukti mampu menurunkan risiko stres pascapersalinan, mempercepat pemulihan psikologis ibu, dan meningkatkan keberhasilan menyusui. Ketika suami terlibat aktif dalam proses perawatan bayi, seperti mengganti popok, menenangkan bayi saat menangis, atau mendampingi ibu saat menyusui, tercipta ikatan emosional yang kuat antara ayah-anak sekaligus memperkuat hubungan keluarga secara keseluruhan.

Keterlibatan keluarga inti lainnya, seperti ibu kandung atau mertua, juga memiliki peran yang besar, terutama dalam memberikan bantuan praktis, seperti menyiapkan makanan, menjaga bayi saat ibu beristirahat, dan berbagi pengalaman merawat bayi. Namun, dalam situasi tertentu, perbedaan nilai atau kebiasaan antargenerasi dapat menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Di sinilah pentingnya pendekatan konseling yang komunikatif dan inklusif dari bidan, yang tidak hanya berfokus pada ibu, tetapi juga mengarahkan keluarga untuk mendukung dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan ibu.

Dalam proses konseling, bidan harus mendorong adanya komunikasi terbuka antara ibu, suami, dan keluarga inti. Hal ini meliputi diskusi mengenai kondisi fisik

dan emosional ibu, kebutuhan dukungan, serta rencana perawatan bayi dan rumah tangga selama masa nifas. Konseling juga harus menanamkan prinsip “shared decision making”, yaitu pengambilan keputusan bersama berdasarkan informasi yang cukup dan mempertimbangkan preferensi serta kenyamanan ibu. Misalnya, dalam memilih metode kontrasepsi pascasalin atau penanganan masalah laktasi, suami diharapkan ikut memahami konsekuensi medis maupun psikososialnya agar dapat memberikan keputusan bersama yang bijak.

Selain itu, penting untuk mengedukasi suami dan keluarga tentang tanda-tanda bahaya pada ibu dan bayi yang memerlukan tindakan cepat, serta peran mereka dalam memastikan akses layanan kesehatan tetap terbuka. Melalui strategi ini, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai pendukung emosional, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan ibu dan anak.

Dengan pendekatan konseling yang menyeluruh dan humanistik, keterlibatan suami dan keluarga inti dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini bukan hanya berdampak pada kualitas pemulihan ibu, tetapi juga membentuk fondasi yang kuat bagi pola asuh anak yang sehat, hubungan keluarga yang harmonis, serta keberhasilan program kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan di masyarakat.

G. Tantangan dan Solusi dalam Konseling Keluarga

Dalam praktik konseling keluarga pada masa nifas, bidan dan tenaga kesehatan seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas intervensi. Hambatan-hambatan ini tidak hanya berasal dari individu klien (ibu dan keluarga), tetapi juga dari konteks sosial, budaya, dan sistem layanan itu sendiri. Untuk menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif, penting untuk mengidentifikasi hambatan yang lazim ditemui serta mengembangkan strategi solutif yang relevan dan berbasis kebutuhan lapangan.

Salah satu tantangan utama dalam konseling keluarga adalah keberagaman norma budaya yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap masa nifas, peran perempuan, dan praktik kesehatan. Di beberapa komunitas, masa nifas dianggap sebagai ranah privat yang tidak perlu dijangkau oleh pihak luar, termasuk tenaga kesehatan. Selain itu, mitos dan praktik tradisional—seperti pembatasan makanan tertentu, larangan mandi, atau larangan menyusui saat demam—masih sering ditemukan dan dapat menghambat pemulihan ibu secara optimal. Bidan harus memiliki kepekaan budaya (cultural sensitivity) dalam menyampaikan edukasi agar tidak menimbulkan resistensi, dengan cara mengapresiasi nilai-nilai lokal dan menyelaraskannya dengan pengetahuan medis secara persuasif.

Rendahnya literasi kesehatan di kalangan keluarga juga menjadi tantangan serius. Banyak keluarga yang tidak memahami pentingnya pemeriksaan pasca

persalinan, deteksi dini komplikasi, atau perawatan yang tepat bagi ibu dan bayi. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran untuk terlibat aktif dalam perawatan ibu nifas, serta kesulitan dalam memahami materi edukasi yang disampaikan. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan edukasi perlu disesuaikan dengan kemampuan kognitif sasaran, menggunakan bahasa yang sederhana, alat bantu visual, serta mengedepankan metode edukasi yang interaktif dan berbasis praktik langsung.

Waktu kunjungan yang terbatas juga menjadi hambatan tersendiri, terutama di daerah dengan jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah ibu pascapersalinan. Dalam waktu yang singkat, bidan dituntut menyampaikan informasi yang banyak sekaligus membangun hubungan yang empatik. Solusi atas tantangan ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem prioritas materi, sehingga topik yang paling krusial disampaikan terlebih dahulu, disertai dengan materi pendukung seperti leaflet, video edukasi, atau arahan untuk mengakses informasi digital yang tepercaya.

Strategi berbasis komunitas dapat menjadi jawaban untuk memperluas jangkauan konseling keluarga. Peran kader Posyandu, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan sangat potensial dalam menyebarkan informasi dan menjadi perpanjangan tangan tenaga kesehatan di lapangan. Kelas ibu nifas berbasis kelompok juga menjadi wadah edukatif yang efektif untuk membangun solidaritas sesama ibu dan meningkatkan keterlibatan keluarga dalam mendukung masa nifas.

Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi memberikan peluang besar dalam mengatasi keterbatasan waktu dan jarak. Konseling daring melalui media sosial, grup WhatsApp keluarga, aplikasi kesehatan ibu-anak, atau video call menjadi alternatif yang efisien. Teknologi ini memungkinkan bidan memberikan informasi secara kontinu, menjawab pertanyaan, dan memantau kondisi ibu secara real time, terutama pada keluarga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan.

H. Studi Kasus Pendampingan Masa Nifas

Pada bagian ini, akan disajikan ilustrasi studi kasus mengenai pendampingan keluarga selama masa nifas yang menunjukkan keberhasilan intervensi kebidanan dalam konteks nyata, sekaligus menjadi refleksi praktik profesional bidan dalam menerapkan prinsip-prinsip edukasi, konseling, dan pemberdayaan keluarga.

Kasus:

Seorang ibu berusia 26 tahun, G2P2A0, melahirkan anak kedua secara spontan di Puskesmas. Setelah melahirkan, ibu dipulangkan ke rumah pada hari ketiga dengan kondisi umum baik, namun mengalami luka episiotomi derajat II. Pada saat kunjungan rumah hari keempat, bidan menemukan bahwa ibu tampak kelelahan,

kurang tidur, mengalami nyeri pada luka jahitan, serta mengeluh ASI tidak keluar lancar. Suami tampak kurang terlibat dalam perawatan, dan ibu tinggal serumah dengan mertuanya yang masih mempercayai pantangan makanan tradisional seperti tidak boleh makan sayur tertentu dan minum air dalam jumlah banyak. Selain itu, ibu mengaku sering menangis sendiri dan merasa kesepian merawat bayi.

Pendampingan dan Intervensi:

Bidan melakukan pendekatan secara empatik kepada ibu dan keluarga. Ia mengedukasi secara langsung tentang pentingnya hidrasi dan nutrisi dalam mempercepat pemulihan luka dan produksi ASI. Dengan menggunakan bahasa sederhana dan komunikasi yang hangat, bidan juga mengklarifikasi mitos-mitos seputar makanan pasca persalinan dan memberikan contoh menu sehat yang tetap menghargai budaya keluarga.

Pada sesi konseling selanjutnya, bidan mengundang suami untuk ikut serta dan menjelaskan pentingnya dukungan emosional dan fisik dari pasangan. Edukasi dilakukan dengan pendekatan positif, menekankan bahwa keterlibatan suami bukan hanya membantu istri, tapi juga mempererat ikatan ayah-anak. Bidan juga mengajarkan teknik dasar perawatan bayi kepada suami agar ia lebih percaya diri mendampingi istrinya.

Untuk memantau perkembangan psikologis ibu, bidan menggunakan alat skrining sederhana seperti EPDS dan mengobservasi respons ibu dalam kunjungan lanjutan. Hasilnya menunjukkan adanya risiko ringan depresi postpartum. Dengan kolaborasi bersama kader Posyandu dan konselor kesehatan jiwa di Puskesmas, ibu diarahkan ke kelompok pendukung ibu pascapersalinan dan diberikan sesi konseling lanjutan.

Refleksi Praktik Kebidanan:

Kasus ini menunjukkan bahwa pendampingan masa nifas tidak cukup hanya dengan memeriksa kondisi fisik ibu, melainkan harus mencakup aspek emosional, sosial, dan lingkungan keluarga. Praktik konseling dan edukasi yang dilakukan bidan tidak bersifat otoritatif, namun dialogis dan sensitif terhadap budaya. Selain itu, pendekatan yang menasar pada peningkatan peran suami dan keluarga terbukti efektif dalam menciptakan perubahan perilaku dan mempercepat pemulihan ibu secara holistik.

Keberhasilan dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa ketika bidan mampu membangun hubungan saling percaya dengan keluarga, menggunakan alat skrining secara tepat, dan melakukan kolaborasi lintas sektor, maka praktik kebidanan benar-benar menjadi solusi nyata dalam upaya promotif, preventif, dan kuratif di masa nifas.

I. Peran Bidan dalam Penguatan Sistem Dukungan Keluarga

Peran bidan dalam pelayanan kebidanan masa nifas tidak hanya terbatas pada tindakan klinis atau asuhan langsung kepada ibu, tetapi juga sangat strategis dalam membangun dan memperkuat sistem dukungan keluarga. Bidan memiliki posisi sentral sebagai fasilitator, advokat, dan pendidik yang menjembatani kebutuhan ibu dan bayi dengan potensi sumber daya di lingkungannya, baik dari dalam keluarga inti maupun dari jejaring sosial dan sistem layanan kesehatan.

Sebagai fasilitator, bidan memegang peran dalam menciptakan hubungan harmonis antara ibu pascapersalinan dan lingkungan sekitarnya. Bidan mengidentifikasi siapa saja yang berpengaruh dalam proses pemulihan ibu (seperti suami, ibu kandung, mertua, saudara, tetangga), lalu secara aktif melibatkan mereka melalui penyuluhan, konseling kelompok, dan dialog partisipatif. Tujuannya adalah agar keluarga tidak hanya menjadi penonton dalam proses pemulihan, tetapi ikut bertanggung jawab dalam menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan penuh dukungan secara fisik dan emosional bagi ibu.

Dalam perannya sebagai advokat, bidan memperjuangkan hak-hak ibu nifas atas informasi yang akurat, pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta lingkungan keluarga yang mendukung proses pemulihannya. Bidan memastikan bahwa setiap keputusan klinis dan tindakan yang dilakukan telah diinformasikan secara jelas kepada ibu dan keluarganya, serta menghormati nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut. Bila terjadi praktik keluarga yang menghambat pemulihan ibu—seperti pantangan tidak berdasar, stigma terhadap kesehatan mental, atau isolasi sosial—bidan bertugas untuk mengadvokasi perubahan melalui pendekatan edukatif dan persuasif, bukan konfrontatif.

Sebagai pendidik, bidan memberikan informasi yang tepat, relevan, dan mudah dipahami mengenai seluruh aspek masa nifas. Hal ini mencakup perawatan fisik ibu, dukungan psikologis, pentingnya istirahat dan nutrisi, perawatan bayi baru lahir, serta edukasi tentang kontrasepsi pascapersalinan. Materi ini disampaikan tidak hanya kepada ibu, tetapi juga kepada suami dan keluarga inti agar mereka dapat memahami peran penting mereka dan menjadi bagian dari proses perawatan.

Lebih jauh, penguatan sistem dukungan keluarga juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Bidan perlu menjalin kerja sama dengan tenaga kesehatan lain, kader Posyandu, tokoh masyarakat, petugas KUA, penyuluh agama, hingga penggerak PKK atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Kolaborasi ini dapat menciptakan ekosistem yang lebih luas dalam mendukung ibu nifas, baik dari aspek edukasi, logistik, hingga kesehatan mental. Sebagai contoh, jika seorang ibu menunjukkan gejala depresi postpartum, bidan dapat merujuknya kepada psikolog

di Puskesmas, sambil tetap menjaga komunikasi intensif dengan keluarga dan melibatkan tokoh masyarakat agar tidak terjadi stigma.

J. Simpulan

Masa nifas merupakan fase kritis yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial ibu serta perkembangan bayi. Meskipun kerap dianggap sebagai periode pemulihan alami, masa nifas justru menyimpan berbagai potensi komplikasi yang memerlukan perhatian serius dan respons cepat dari tenaga kesehatan, khususnya bidan. Perubahan hormonal, penyesuaian emosional, tantangan menyusui, dan peran baru sebagai orang tua menjadikan masa ini penuh dinamika yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik.

Pendampingan dan konseling keluarga menjadi strategi kunci dalam pelayanan kebidanan masa nifas yang efektif. Keterlibatan suami, ibu kandung, dan anggota keluarga inti lainnya terbukti dapat meningkatkan kepercayaan diri ibu, mempercepat pemulihan, dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan komplikasi. Peran bidan sebagai fasilitator, advokat, dan pendidik sangat strategis dalam mengoptimalkan dukungan keluarga dengan menjembatani pengetahuan ilmiah dan praktik budaya lokal yang bersifat adaptif.

Prinsip-prinsip komunikasi empatik, penghormatan terhadap nilai budaya, informed choice, dan kerahasiaan informasi menjadi fondasi utama dalam proses konseling keluarga. Metode seperti kunjungan rumah, kelas ibu nifas, dan komunikasi daring telah terbukti fleksibel dan relevan dalam menjangkau kebutuhan ibu serta mengaktifkan keterlibatan keluarga secara partisipatif. Materi konseling pun tidak hanya mencakup aspek klinis, tetapi juga menyentuh dimensi psikososial dan perilaku, mulai dari perawatan luka, nutrisi, kesehatan mental, hingga perencanaan keluarga.

Berbagai tantangan seperti rendahnya literasi kesehatan, norma budaya yang kaku, dan keterbatasan waktu kunjungan dapat diatasi melalui inovasi berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi digital. Kolaborasi lintas sektor antara bidan, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal sangat penting dalam menciptakan sistem pendukung yang berkelanjutan dan responsif.

Dengan mengedepankan pendekatan yang humanistik, komunikatif, dan berbasis bukti, pendampingan dan konseling keluarga pada masa nifas mampu memperkuat kapasitas keluarga sebagai mitra aktif dalam pelayanan kebidanan. Hal ini pada akhirnya akan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas asuhan pascapersalinan, penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, serta terciptanya lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan berdaya.

K. Referensi

- Anderson, B. A., & Stone, S. (2020). *Postpartum care: Guidelines and practices for the modern midwife*. Springer Publishing Company.
- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., & Jensen, M. D. (2022). *Maternity Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Dinas Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Panduan Praktik Klinis untuk Pelayanan Kebidanan di Masa Nifas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Feinberg, M. E., & Kan, M. L. (2019). The transition to parenthood: Impact of co-parenting on infant and maternal well-being. *Journal of Family Psychology*, 33(2), 246–256. <https://doi.org/10.1037/fam0000501>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Profil Kesehatan Indonesia 2020*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI.
- Koblinsky, M., Moyer, C. A., Calvert, C., Campbell, J., Campbell, O. M. R., Feigl, A. B., ... & Langer, A. (2016). Quality maternity care for every woman, everywhere: A call to action. *The Lancet*, 388(10057), 2307–2320. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31333-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31333-2)
- NICE (National Institute for Health and Care Excellence). (2021). *Postnatal care*. Retrieved from <https://www.nice.org.uk/guidance/ng194>
- Olds, S. B., London, M. L., Ladewig, P. A., & Davidson, M. R. (2020). *Maternal-Newborn Nursing & Women's Health Care* (12th ed.). Pearson Education.
- Ratnasari, D., & Kurniasari, D. (2023). Keterlibatan suami dalam perawatan ibu masa nifas: Perspektif budaya dan peran bidan. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Tradisional*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.37341/jkkt.v7i1.2500>
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989>

L. Glosarium

Masa nifas: Periode transisi yang berlangsung selama enam minggu setelah melahirkan, dimulai dari keluarnya plasenta, yang ditandai dengan pemulihan organ reproduksi, penyesuaian hormonal, serta adaptasi psikososial seorang ibu.

Involusi uterus: Proses alami penyusutan ukuran dan berat rahim untuk kembali ke kondisi semula sebelum hamil, biasanya selesai dalam 6 minggu setelah persalinan.

Lokia: Cairan yang keluar dari jalan lahir setelah persalinan, terdiri dari darah, sisa jaringan rahim, dan lendir serviks, yang menunjukkan proses pembersihan rahim.

Baby blues: Gangguan emosional ringan yang dialami sebagian besar ibu beberapa hari setelah melahirkan, ditandai dengan suasana hati yang mudah berubah, menangis tanpa sebab, dan kelelahan.

Depresi postpartum: Gangguan mental serius yang terjadi setelah melahirkan, ditandai dengan perasaan sedih mendalam, gangguan tidur, kecemasan, kehilangan minat, bahkan pikiran menyakiti diri atau bayi.

Konseling keluarga: Proses komunikasi dua arah antara tenaga kesehatan dan keluarga, bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan kesehatan yang tepat, memahami kondisi ibu, dan mendorong peran aktif keluarga.

Pendampingan kebidanan: Serangkaian kegiatan yang dilakukan bidan untuk memberikan dukungan emosional, edukasi kesehatan, dan monitoring kondisi ibu dan bayi selama masa nifas, baik secara langsung maupun daring.

Informed choice: Prinsip dalam pelayanan kesehatan yang memastikan bahwa setiap keputusan klinis diambil berdasarkan informasi lengkap yang dipahami oleh pasien, tanpa paksaan, dan sesuai dengan nilai serta preferensi pribadi.

Kunjungan rumah: Strategi pelayanan kebidanan di mana bidan datang ke rumah pasien untuk melakukan pemantauan kesehatan ibu dan bayi, memberikan edukasi, serta mendeteksi masalah secara dini.

Kelas ibu nifas: Forum edukatif berbasis kelompok yang diselenggarakan bagi ibu-ibu setelah melahirkan untuk memperoleh informasi seputar perawatan diri, bayi, menyusui, kontrasepsi, dan dukungan psikososial.

CHAPTER 6

EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA BERENCANA PASCAPERSALINAN

Bdn. Erma Puspita Sari, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Pendahuluan

Masa pascapersalinan merupakan periode krusial yang dimulai sejak keluarnya plasenta hingga kurang lebih enam minggu setelah persalinan. Pada fase ini, tubuh ibu mengalami perubahan besar baik secara fisiologis, psikologis, maupun sosial. Secara biologis, tubuh mengalami proses involusi uterus, penyembuhan luka pascapersalinan (baik pervaginam maupun operasi sesar), perubahan hormonal yang berpengaruh terhadap suasana hati dan produksi ASI, serta pemulihan sistem reproduksi menuju kondisi sebelum kehamilan. Selain itu, ibu juga menjalani transisi penting dalam peran kehidupannya, dari seorang perempuan menjadi seorang ibu, yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan kesehatan bayi yang baru dilahirkan.

Perubahan besar yang terjadi selama masa ini menuntut adanya perhatian menyeluruh terhadap kondisi kesehatan ibu, tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional dan sosial. Sayangnya, masa pascapersalinan kerap kali mendapatkan perhatian yang kurang dibandingkan masa kehamilan dan persalinan. Banyak ibu yang kembali ke rumah tanpa mendapatkan cukup informasi, bimbingan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk melewati fase pemulihan secara optimal. Padahal, fase ini justru menjadi dasar penting untuk memastikan kualitas hidup ibu dan bayi dalam jangka panjang, termasuk dalam aspek kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

Pemulihan kesehatan reproduksi tidak hanya melibatkan aspek biologis, tetapi juga berkaitan erat dengan kesiapan ibu untuk kembali beraktivitas seksual, mengenali hak-hak reproduktifnya, serta memahami kebutuhan tubuhnya pascapersalinan. Dalam konteks ini, edukasi mengenai kesehatan reproduksi menjadi sangat penting. Ibu perlu mengetahui bagaimana menjaga organ reproduksinya, memahami siklus menstruasi pasca melahirkan, mengatasi ketidaknyamanan dalam hubungan seksual, serta mengidentifikasi tanda-tanda gangguan yang perlu ditangani secara medis.

Lebih lanjut, keluarga berencana juga merupakan elemen penting dalam pelayanan kebidanan masa nifas. Jarak kehamilan yang terlalu dekat dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan berikutnya dan menurunkan peluang ibu

untuk pulih secara menyeluruh. Oleh karena itu, edukasi tentang metode kontrasepsi yang sesuai, waktu yang tepat untuk memulai, serta peran pasangan dalam pengambilan keputusan sangatlah krusial. Program keluarga berencana pascapersalinan bukan hanya ditujukan untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak reproduksi dan kesejahteraan perempuan serta keluarganya.

Dalam praktik kebidanan modern, pendekatan yang holistik, berkelanjutan, dan berbasis pada evidence-based practice sangat diperlukan untuk mendukung ibu dalam masa pascapersalinan. Edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana bukan hanya disampaikan secara informatif, tetapi harus melalui proses konseling yang empatik, komunikatif, dan partisipatif. Dengan demikian, ibu dan keluarganya merasa didengar, dimengerti, dan memiliki otonomi dalam menentukan langkah-langkah terbaik untuk kesehatannya.

Dengan mempertimbangkan urgensi tersebut, bab ini akan mengulas secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dalam masa pascapersalinan. Pembahasan mencakup latar belakang konseptual, strategi komunikasi edukatif, metode penyampaian yang efektif, keterlibatan pasangan, hingga tantangan serta solusi di lapangan. Harapannya, melalui intervensi yang tepat, ibu pascapersalinan dapat memperoleh informasi yang memadai dan mampu mengambil keputusan yang mendukung keselamatan dan kualitas hidup reproduktifnya secara berkelanjutan.

B. Konsep Kesehatan Reproduksi Pascapersalinan

Kesehatan reproduksi pascapersalinan mencerminkan kondisi pemulihan menyeluruh sistem reproduksi perempuan setelah proses persalinan, yang mencakup perubahan fisiologis, psikologis, dan hormonal. Masa ini merupakan jembatan antara masa kehamilan dan kembalinya fungsi reproduksi normal. Pemahaman terhadap dinamika perubahan ini sangat penting agar ibu dan keluarga memiliki ekspektasi yang realistis mengenai proses pemulihan, serta dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi.

Secara fisiologis, salah satu proses utama yang terjadi pada masa pascapersalinan adalah involusi uterus, yaitu kembalinya ukuran dan berat rahim ke kondisi pra-kehamilan. Proses ini berlangsung selama sekitar enam minggu, ditandai dengan penurunan tinggi fundus uteri dan pengeluaran lochia—cairan yang terdiri dari darah, sisa jaringan, dan lendir serviks. Pada minggu pertama, lochia berwarna merah terang (lochia rubra), kemudian berubah menjadi cokelat kekuningan (lochia serosa), dan akhirnya menjadi putih kekuningan (lochia alba).

Involusi yang normal menunjukkan pemulihan yang sehat, sedangkan involusi yang terganggu dapat menjadi tanda adanya infeksi atau retensi sisa plasenta.

Selain perubahan pada rahim, terjadi pula pemulihan luka pada perineum atau bekas sayatan operasi sesar. Proses penyembuhan ini bergantung pada status gizi, kebersihan area luka, dan istirahat yang cukup. Penting bagi ibu untuk memahami cara perawatan luka dan mengenali tanda-tanda infeksi, seperti nyeri yang menetap, kemerahan, bengkak, atau keluarnya cairan abnormal.

Dari sisi hormonal, tubuh ibu mengalami fluktuasi besar setelah persalinan. Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron berlangsung cepat setelah keluarnya plasenta. Sementara itu, hormon prolaktin meningkat untuk mendukung produksi ASI. Hormon oksitosin juga berperan dalam merangsang kontraksi uterus dan pengeluaran ASI. Fluktuasi ini dapat memengaruhi suasana hati ibu dan menjadi salah satu pemicu kondisi emosional seperti baby blues. Oleh karena itu, pemantauan kesehatan mental selama masa nifas sangat dianjurkan.

Kembalinya siklus menstruasi menjadi indikator penting kesiapan tubuh untuk kembali berfungsi secara reproduktif. Pada ibu menyusui secara eksklusif, menstruasi biasanya tertunda akibat pengaruh hormon prolaktin yang menekan ovulasi. Namun, perlu diketahui bahwa ovulasi bisa terjadi sebelum menstruasi pertama datang, sehingga ibu tetap berpotensi hamil meskipun belum haid. Inilah mengapa pemahaman mengenai metode kontrasepsi pascapersalinan menjadi sangat penting dan harus disampaikan sejak awal masa nifas.

Secara psikologis, masa ini juga sarat tantangan. Perubahan peran menjadi seorang ibu, kelelahan, gangguan tidur, serta tekanan sosial dan budaya dapat berdampak pada kestabilan emosional. Keadaan ini dapat berujung pada gangguan psikologis ringan seperti baby blues, maupun gangguan serius seperti postpartum depression atau bahkan postpartum psychosis. Oleh sebab itu, perhatian terhadap aspek psikologis merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan kesehatan reproduksi.

Kesiapan tubuh untuk kembali aktif secara seksual juga merupakan bagian dari kesehatan reproduksi pascapersalinan. Biasanya, hubungan seksual dapat dilakukan kembali setelah enam minggu, namun harus didasarkan pada kenyamanan fisik dan kesiapan emosional ibu. Edukasi yang tepat mengenai hal ini perlu diberikan kepada pasangan agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling memahami, tanpa tekanan atau paksaan.

C. Hak dan Kebutuhan Reproduksi Ibu Pascapersalinan

Setiap perempuan yang telah melalui proses persalinan memiliki hak yang melekat dan tidak dapat dicabut atas kesehatan reproduksinya. Masa pascapersalinan bukan hanya periode pemulihan fisik, tetapi juga momentum penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar ibu dalam memperoleh informasi, pelayanan, dan dukungan yang menunjang kesejahteraan jangka panjang—baik dari aspek biologis, psikologis, sosial, maupun seksual. Pemahaman yang menyeluruh mengenai hak dan kebutuhan reproduksi pada masa ini sangat krusial agar ibu dapat menjalani transisi peran dengan aman, bermartabat, dan berdaya.

Hak reproduksi ibu pascapersalinan mencakup hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan individunya. Pelayanan ini harus menjangkau seluruh dimensi pemulihan pasca melahirkan, termasuk pemeriksaan klinis berkala, edukasi menyusui, penyuluhan kesehatan seksual, hingga konseling psikologis bila dibutuhkan. Hak atas pelayanan kesehatan juga berarti hak atas akses, yaitu tersedianya fasilitas yang mudah dijangkau secara geografis, ekonomis, serta bebas dari diskriminasi dan stigma.

Di samping itu, ibu berhak memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan mudah dipahami mengenai kondisi tubuhnya, pilihan metode kontrasepsi pascapersalinan, serta aspek-aspek penting dalam kesehatan reproduksi. Informasi ini harus diberikan oleh tenaga kesehatan melalui pendekatan edukatif dan komunikatif, serta dengan menghargai kemampuan literasi dan nilai budaya yang dianut ibu dan keluarganya. Penyampaian informasi juga harus menjunjung tinggi prinsip *informed choice*—memberi keleluasaan kepada ibu untuk memilih tindakan atau keputusan yang sesuai dengan preferensinya, bukan atas paksaan.

Kebutuhan reproduksi ibu pada masa nifas juga sangat erat kaitannya dengan dimensi emosional. Perubahan hormonal yang drastis, kelelahan fisik, dan tekanan peran baru sering kali memicu ketidakstabilan suasana hati. Oleh karena itu, hak ibu atas dukungan psikososial tidak boleh diabaikan. Tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk mengenali tanda-tanda gangguan psikologis seperti *baby blues* atau *postpartum depression*, serta menyediakan layanan konseling dasar dan sistem rujukan ke profesional kesehatan jiwa bila diperlukan. Selain itu, keluarga, khususnya pasangan, perlu dilibatkan secara aktif untuk memberikan dukungan emosional, membantu mengurangi beban ibu, dan menciptakan suasana rumah yang suportif.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah kebutuhan dan hak ibu terhadap pemenuhan kesehatan seksual. Sering kali topik ini dianggap tabu atau diabaikan dalam pelayanan kebidanan, padahal banyak perempuan mengalami ketidaknyamanan fisik dan psikis terkait kehidupan seksualnya pascapersalinan.

Misalnya, nyeri saat berhubungan intim akibat luka perineum, menurunnya libido karena perubahan hormonal atau kelelahan, hingga kecemasan akan kehamilan ulang. Ibu berhak mendapatkan penjelasan yang jujur dan ilmiah mengenai kapan dan bagaimana aman memulai kembali aktivitas seksual, serta metode kontrasepsi yang sesuai. Edukasi yang inklusif juga harus melibatkan pasangan, agar dapat tercipta komunikasi terbuka dan hubungan seksual yang sehat dan saling menghormati.

Dalam konteks keluarga berencana, hak ibu pascapersalinan adalah untuk mendapatkan konseling yang netral dan tidak menghakimi mengenai berbagai metode kontrasepsi yang tersedia, manfaat dan risikonya, serta pengaruhnya terhadap menyusui. Pilihan kontrasepsi seharusnya tidak ditentukan oleh pihak lain, baik tenaga kesehatan maupun anggota keluarga, melainkan sepenuhnya menjadi keputusan ibu (dan pasangan bila relevan) setelah mendapat informasi yang memadai.

Seluruh hak dan kebutuhan ini menjadi dasar dalam membangun pendekatan pelayanan kebidanan yang berkeadilan gender dan berpusat pada ibu. Pemenuhan hak reproduksi ibu pascapersalinan bukan hanya bentuk perlindungan terhadap individu, tetapi juga investasi jangka panjang dalam menciptakan keluarga yang sehat dan masyarakat yang lebih sejahtera. Bidan, sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ibu, memiliki tanggung jawab etis dan profesional untuk memastikan bahwa setiap ibu mendapatkan pelayanan yang manusiawi, bermartabat, dan berpihak pada hak-haknya sebagai perempuan dan sebagai manusia.

D. Edukasi Seksualitas Sehat Pascapersalinan

Masa pascapersalinan merupakan fase krusial dalam kehidupan reproduksi dan relasi seksual pasangan suami istri. Setelah persalinan, banyak perempuan mengalami berbagai perubahan fisik, emosional, dan psikososial yang berdampak langsung pada kehidupan seksual mereka. Oleh karena itu, edukasi mengenai seksualitas sehat pada masa ini menjadi bagian integral dari pelayanan kebidanan yang berkelanjutan. Edukasi ini tidak hanya penting untuk pemulihan fisik ibu, tetapi juga untuk memperkuat komunikasi pasangan, memperbaiki kualitas hubungan intim, dan menghindari konflik dalam rumah tangga yang dapat muncul akibat miskomunikasi atau ketidaktahuan.

Setelah melahirkan, tubuh perempuan mengalami penyesuaian besar, termasuk involusi uterus, penyembuhan luka jalan lahir atau operasi sesar, serta fluktuasi hormon yang memengaruhi mood, gairah seksual (libido), dan produksi lubrikasi vagina. Estrogen yang menurun pada ibu menyusui, misalnya, sering

menyebabkan vagina menjadi lebih kering, sehingga hubungan intim dapat terasa tidak nyaman atau menyakitkan. Ditambah kelelahan fisik akibat merawat bayi dan gangguan tidur, sebagian besar ibu merasa tidak siap secara fisik maupun emosional untuk kembali berhubungan seksual dalam waktu dekat setelah persalinan.

Karena itu, sangat penting bagi tenaga kesehatan, terutama bidan, untuk memberikan edukasi sejak awal mengenai hal-hal normal yang akan dialami dalam kehidupan seksual setelah melahirkan. Edukasi ini mencakup penjelasan bahwa setiap ibu memiliki waktu pemulihan yang berbeda, dan tidak ada batasan waktu pasti kapan aktivitas seksual harus dimulai kembali. Secara medis, hubungan seksual dapat dilakukan kembali setelah perdarahan nifas berhenti dan ibu merasa siap secara fisik dan emosional—biasanya sekitar 4–6 minggu pascapersalinan. Namun, kesiapan psikis dan kenyamanan menjadi indikator utama dalam menentukan waktunya.

Selain aspek medis, komunikasi terbuka dengan pasangan menjadi fondasi utama dalam menjaga keintiman pascapersalinan. Suami perlu dilibatkan dalam edukasi agar dapat memahami kondisi ibu secara utuh, termasuk ketidaknyamanan, kelelahan, atau ketakutan yang dirasakan pasca persalinan. Bidan harus mendorong pasangan untuk saling berbicara secara jujur tentang perasaan, harapan, dan kekhawatiran masing-masing. Misalnya, ibu bisa mengutarakan jika merasa lelah dan tidak nyaman, sementara suami juga diberi ruang untuk menyampaikan perasaannya secara sehat. Dengan komunikasi yang sehat, pasangan bisa menemukan alternatif untuk menjaga keintiman tanpa selalu harus melalui hubungan seksual penetratif.

Strategi lain yang dapat dilakukan untuk membantu pemulihan keintiman meliputi sentuhan fisik yang non-seksual, seperti pelukan, pijatan lembut, atau tidur berdekatan, yang dapat memperkuat hubungan emosional pasangan. Edukasi juga bisa mencakup informasi praktis, seperti penggunaan pelumas berbahan dasar air jika terjadi kekeringan vagina, memilih waktu berhubungan ketika bayi sedang tidur, dan menciptakan suasana yang santai dan bebas tekanan. Jika ibu mengalami nyeri atau ketidaknyamanan berkepanjangan, bidan dapat melakukan rujukan ke tenaga medis atau terapi seks bila diperlukan.

Masalah seksual yang umum ditemui pascapersalinan, seperti penurunan gairah, vaginismus (kekakuan otot vagina), atau gangguan citra tubuh, juga perlu dijelaskan kepada ibu sebagai hal yang dapat diatasi dengan dukungan profesional dan pasangan. Yang terpenting, ibu tidak boleh menyalahkan diri sendiri atau merasa bersalah karena tidak mampu “melayani” pasangan seperti sebelumnya. Justru di sinilah peran konseling yang humanistik dan berbasis empati menjadi

sangat penting untuk memulihkan keseimbangan dalam kehidupan seksual rumah tangga.

E. Kontrasepsi Pascapersalinan: Jenis dan Indikasi

Kontrasepsi pascapersalinan merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan reproduksi yang bertujuan untuk mencegah kehamilan yang terlalu cepat setelah persalinan, sekaligus memberikan waktu bagi ibu untuk pulih secara optimal baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pemberian edukasi dan pelayanan kontrasepsi pada masa pascapersalinan tidak hanya berkaitan dengan aspek klinis, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak reproduksi perempuan untuk merencanakan kehamilan sesuai dengan keinginan dan kesiapan dirinya. Oleh karena itu, pemilihan metode kontrasepsi harus bersifat individual, berdasarkan kondisi medis, preferensi pribadi, dukungan keluarga, serta faktor sosial-budaya yang memengaruhi pengambilan keputusan.

Berbagai metode kontrasepsi tersedia untuk digunakan setelah melahirkan, baik yang bersifat hormonal maupun non-hormonal, jangka pendek maupun jangka panjang. Setiap metode memiliki waktu pemberian yang ideal dan indikasi khusus tergantung pada kondisi menyusui, status kesehatan ibu, dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Metode kontrasepsi hormonal yang umum digunakan pascapersalinan meliputi pil progestin tunggal (minipil), suntikan DMPA (Depo Medroxyprogesterone Acetate), dan implan subdermal. Pil progestin tunggal dapat diberikan mulai enam minggu setelah persalinan bagi ibu menyusui, atau sejak hari ke-3 jika ibu tidak menyusui. Kelebihan pil ini adalah tidak memengaruhi produksi ASI, tetapi kekurangannya adalah harus diminum setiap hari pada jam yang sama. Suntikan DMPA yang diberikan setiap 12 minggu juga aman untuk ibu menyusui dan sangat efektif, tetapi dapat menyebabkan perdarahan tidak teratur dan peningkatan berat badan. Implan merupakan metode jangka panjang (3–5 tahun) yang sangat efektif, praktis, dan dapat dipasang segera setelah melahirkan, bahkan dalam 48 jam pertama pascapersalinan atau setelah 6 minggu bagi ibu yang menyusui.

Metode non-hormonal meliputi IUD (Intra Uterine Device) dan metode barrier seperti kondom. IUD dapat dipasang dalam 10 menit setelah lahirnya plasenta (IUD post placenta), dalam waktu 48 jam setelah persalinan, atau setelah enam minggu. IUD sangat efektif dalam jangka panjang (5–10 tahun) dan tidak memengaruhi kualitas maupun kuantitas ASI. Kelebihan lain dari IUD adalah tidak mengandung hormon, sehingga cocok bagi ibu dengan kontraindikasi hormonal. Namun, risiko pengeluaran spontan (ekspulsi) lebih tinggi jika dipasang segera setelah melahirkan.

Metode barrier seperti kondom dapat digunakan kapan saja dan memiliki manfaat tambahan dalam mencegah infeksi menular seksual, tetapi efektivitasnya lebih rendah jika tidak digunakan secara konsisten dan benar.

Metode alami seperti LAM (Lactational Amenorrhea Method) juga menjadi pilihan selama tiga bulan pertama pascapersalinan dengan syarat ketat: ibu harus menyusui eksklusif (siang dan malam tanpa tambahan makanan atau susu lain), belum mengalami menstruasi, dan bayi berusia di bawah enam bulan. Jika ketiga syarat ini terpenuhi, efektivitas LAM dapat mencapai lebih dari 98%. Namun, begitu salah satu syarat tidak terpenuhi, metode ini harus segera digantikan dengan metode kontrasepsi lain.

Dalam memilih metode kontrasepsi pascapersalinan, pertimbangan medis harus mencakup riwayat penyakit kronis (misalnya hipertensi, diabetes, gangguan koagulasi), jenis persalinan (pervaginam atau seksio sesarea), status menyusui, dan potensi efek samping. Sementara itu, preferensi pasien harus dihormati secara penuh dengan prinsip informed choice—yaitu keputusan yang diambil secara sadar dan sukarela setelah ibu menerima informasi lengkap mengenai manfaat, risiko, efektivitas, dan alternatif dari setiap metode yang ditawarkan. Edukasi mengenai kontrasepsi sebaiknya dimulai sejak masa antenatal atau segera setelah persalinan ketika ibu masih berada di fasilitas pelayanan, sehingga ibu dan pasangannya memiliki waktu untuk mempertimbangkan dan berdiskusi.

F. Komunikasi Efektif dalam Edukasi Keluarga Berencana

Komunikasi yang efektif merupakan landasan utama dalam menyampaikan edukasi keluarga berencana (KB) pascapersalinan, terutama mengingat kompleksitas kebutuhan informasi dan sensitivitas isu yang berkaitan dengan reproduksi, seksualitas, serta dinamika relasi pasangan. Dalam praktik kebidanan, komunikasi tidak hanya menjadi alat penyampaian pesan, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan, menciptakan suasana dialogis, dan memperkuat pengambilan keputusan bersama antara tenaga kesehatan, ibu, dan keluarganya.

Strategi komunikasi yang dilakukan bidan dalam edukasi KB pascapersalinan harus dilandasi oleh prinsip empati, kejujuran, keterbukaan, dan penghargaan terhadap nilai-nilai pribadi serta budaya yang dianut oleh keluarga. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali kebutuhan dan kesiapan ibu dalam menerima informasi. Sebagian ibu mungkin belum siap mendiskusikan tentang kontrasepsi di hari-hari awal setelah persalinan karena masih fokus pada proses pemulihan atau perawatan bayi. Oleh karena itu, bidan perlu mengatur waktu yang tepat untuk menyampaikan informasi dan memastikan suasana yang nyaman dan bebas tekanan.

Keterlibatan suami dalam proses edukasi KB merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan keberhasilan penggunaan kontrasepsi. Dalam banyak konteks budaya di Indonesia, suami memegang peranan besar dalam pengambilan keputusan keluarga, termasuk dalam hal penggunaan alat kontrasepsi. Oleh sebab itu, bidan sebaiknya mengundang suami untuk turut hadir dalam sesi edukasi, baik saat kunjungan rumah maupun dalam forum kelompok seperti kelas ibu nifas. Melalui komunikasi yang inklusif dan non-diskriminatif, suami dapat diberikan informasi mengenai pentingnya penjarangan kehamilan, manfaat kesehatan bagi ibu dan bayi, serta berbagai pilihan kontrasepsi yang tersedia. Edukasi ini tidak bertujuan untuk memaksa, melainkan membangun kesadaran kolektif bahwa tanggung jawab KB bukan hanya milik istri, tetapi juga suami sebagai mitra reproduksi.

Dalam menyampaikan materi KB, bidan juga perlu memanfaatkan media edukatif yang sesuai dengan karakteristik sasaran. Media cetak seperti leaflet, booklet, dan flipchart bisa digunakan untuk memperkuat pesan-pesan lisan. Sementara itu, media audio-visual seperti video edukasi atau infografis digital sangat berguna terutama dalam komunikasi kelompok atau melalui layanan daring. Penggunaan gambar dan bahasa sederhana sangat dianjurkan agar informasi lebih mudah dipahami oleh ibu dan keluarga dengan latar belakang pendidikan rendah. Dalam kondisi tertentu, bidan juga dapat menggunakan aplikasi berbasis ponsel yang menyediakan fitur pengingat jadwal KB, informasi tentang efek samping, serta direktori fasilitas layanan.

Pendekatan budaya dalam komunikasi KB menjadi unsur penting yang tidak boleh diabaikan. Setiap komunitas memiliki nilai, norma, dan kepercayaan tertentu mengenai kesuburan, peran gender, dan seksualitas yang bisa mempengaruhi cara mereka memandang KB. Misalnya, dalam beberapa komunitas, memiliki banyak anak dianggap sebagai simbol keberkahan atau status sosial. Dalam hal ini, bidan tidak boleh secara langsung menentang pandangan tersebut, melainkan perlu menyelaraskan pesan kesehatan dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat. Edukasi yang disampaikan melalui tokoh masyarakat, pemuka agama, atau kader Posyandu yang dihormati di komunitas dapat memperkuat penerimaan pesan dan mengurangi resistensi.

Selain itu, penting bagi bidan untuk mengedepankan pendekatan komunikasi interpersonal yang dialogis dan partisipatif. Ibu dan suami perlu diberi ruang untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan kekhawatiran, dan memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kondisi dan preferensi mereka. Proses ini harus bebas dari tekanan atau paksaan, karena hak untuk memilih (*informed choice*) adalah prinsip mendasar dalam pelayanan KB yang bermutu.

G. Peran Suami dan Keluarga dalam Pengambilan Keputusan KB

Pengambilan keputusan terkait penggunaan kontrasepsi pascapersalinan bukanlah semata-mata tanggung jawab individu, melainkan proses kolektif yang sangat dipengaruhi oleh hubungan interpersonal dalam keluarga, terutama antara suami dan istri. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, suami memiliki peran dominan dalam keputusan keluarga, sehingga keterlibatannya dalam program keluarga berencana (KB) menjadi sangat krusial. Dukungan suami tidak hanya mempengaruhi keputusan awal penggunaan kontrasepsi, tetapi juga keberlanjutan dan kepatuhan terhadap metode yang dipilih.

Keterlibatan suami dalam pengambilan keputusan KB mencerminkan kemitraan yang sehat dalam rumah tangga. Suami yang berpartisipasi aktif cenderung lebih memahami manfaat KB terhadap kesehatan istri dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Misalnya, dengan mengetahui dampak buruk dari kehamilan yang terlalu dekat atau terlalu sering, suami akan lebih mendukung penjarangan kehamilan melalui kontrasepsi. Dukungan ini dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam konsultasi KB, membantu istri dalam perawatan pascapersalinan, atau bahkan turut menggunakan metode KB seperti kondom atau vasektomi.

Selain itu, keluarga besar seperti ibu kandung, mertua, atau kerabat yang tinggal serumah juga dapat mempengaruhi keputusan KB, baik secara positif maupun negatif. Dalam beberapa kasus, mitos dan pandangan tradisional yang masih melekat bisa menjadi hambatan, seperti anggapan bahwa kontrasepsi menyebabkan kemandulan, atau bahwa menggunakan KB adalah bentuk penolakan terhadap rejeki anak. Oleh karena itu, edukasi tidak hanya harus diarahkan kepada ibu, tetapi juga kepada seluruh anggota keluarga yang berpengaruh terhadap keputusan.

Peran bidan dalam konteks ini sangat strategis. Bidan harus mampu memfasilitasi diskusi pasangan secara partisipatif dan setara, serta menciptakan suasana komunikasi yang aman dan terbuka. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah konseling pasangan, di mana suami dan istri diundang bersama untuk menerima informasi tentang berbagai metode KB, kelebihan dan kekurangannya, serta risiko dan indikasinya. Dalam sesi ini, bidan berperan sebagai fasilitator netral yang memastikan bahwa kedua belah pihak mendapat kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bersama tanpa tekanan.

Penting bagi bidan untuk menjaga keseimbangan dalam komunikasi, agar tidak terjadi dominasi sepihak dalam diskusi. Misalnya, apabila suami terlalu mendominasi pembicaraan atau memaksakan metode tertentu, bidan harus dengan hati-hati mengembalikan fokus kepada kebutuhan dan kenyamanan ibu sebagai

pihak yang mengalami proses biologis kehamilan dan persalinan. Sebaliknya, jika istri tampak enggan menyampaikan pendapat, bidan perlu memberikan dorongan positif agar suara istri tetap terwakili dalam pengambilan keputusan.

Dalam situasi di mana suami tidak dapat hadir secara langsung, komunikasi tidak harus berhenti. Bidan dapat menggunakan pendekatan tidak langsung melalui kunjungan rumah, keterlibatan kader atau tokoh masyarakat, serta media komunikasi keluarga seperti pesan teks atau panggilan daring. Yang terpenting adalah menjaga keberlanjutan informasi dan membangun pemahaman bersama dalam keluarga.

Dengan memberdayakan pasangan dan keluarga melalui pendekatan yang partisipatif, edukatif, dan berbasis kesetaraan, maka keputusan penggunaan kontrasepsi tidak hanya menjadi lebih tepat sasaran, tetapi juga lebih berkelanjutan. Kolaborasi yang harmonis antara suami, istri, dan anggota keluarga lain menciptakan lingkungan yang mendukung praktik KB yang sehat, serta memperkuat peran perempuan dalam mengelola kesehatan reproduksinya secara otonom dan bermartabat.

H. Tantangan Edukasi Reproduksi Pascapersalinan

Pemberian edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana (KB) pada masa pascapersalinan merupakan aspek penting dari pelayanan kebidanan yang berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, upaya ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi individu, keluarga, maupun sistem layanan kesehatan. Tantangan-tantangan ini harus diidentifikasi secara tepat agar dapat diselesaikan dengan strategi yang kontekstual, sensitif budaya, dan berbasis pemberdayaan.

Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi kesehatan masyarakat, terutama pada kelompok ibu dengan tingkat pendidikan rendah atau tinggal di wilayah terpencil. Banyak ibu pascapersalinan yang tidak memahami fungsi organ reproduksi, tidak mengetahui tanda bahaya kesehatan seksual, serta tidak mengenal metode KB yang sesuai. Hal ini diperparah oleh kurangnya akses terhadap sumber informasi yang terpercaya, sehingga pengetahuan yang diperoleh cenderung berasal dari cerita turun-temurun atau media sosial yang belum tentu valid. Ketika literasi kesehatan rendah, proses edukasi menjadi kurang efektif karena sulit menjembatani konsep-konsep medis dengan pemahaman masyarakat.

Selain itu, keberadaan mitos dan kepercayaan tradisional yang kuat masih menjadi hambatan serius. Di sejumlah komunitas, kontrasepsi pascapersalinan masih dianggap dapat menyebabkan kemandulan, mengganggu keseimbangan tubuh, atau bertentangan dengan nilai keagamaan. Ada pula kepercayaan yang

menyebutkan bahwa menyusui saja sudah cukup untuk mencegah kehamilan, padahal efektivitas metode amenore laktasi (LAM) sangat tergantung pada syarat-syarat tertentu yang belum tentu dipenuhi. Mitos-mitos ini tidak jarang membuat ibu menunda penggunaan KB atau bahkan menolaknya sama sekali, meskipun secara medis telah dianjurkan.

Stigma sosial terhadap pembicaraan seksualitas juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pasangan merasa tabu membahas masalah hubungan intim, perubahan fisik dan psikologis pascamelahirkan, atau kebutuhan kontrasepsi. Ketabuan ini membuat ibu merasa malu atau enggan berkonsultasi, bahkan ketika mengalami gangguan yang nyata seperti nyeri saat berhubungan atau penurunan gairah seksual. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi tidak hanya perlu menyampaikan pengetahuan, tetapi juga harus menciptakan ruang komunikasi yang aman, netral, dan bebas stigma.

Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi faktor penghambat signifikan, terutama di daerah pedesaan atau kepulauan. Fasilitas kesehatan yang jauh, keterbatasan tenaga kesehatan, serta minimnya kunjungan rumah menyebabkan ibu pascapersalinan kesulitan mendapatkan edukasi yang berkualitas. Dalam kondisi seperti ini, ibu seringkali bergantung pada informasi dari tetangga, dukun bayi, atau sumber yang tidak resmi. Di sisi lain, waktu pelayanan di fasilitas yang padat juga menjadi kendala bagi bidan untuk memberikan edukasi yang komprehensif dan personal.

Menghadapi berbagai tantangan ini, diperlukan strategi yang bersifat adaptif dan inovatif. Peningkatan literasi kesehatan dapat dilakukan melalui penguatan kelas ibu pascapersalinan, penyuluhan berbasis kelompok, dan penggunaan alat bantu visual yang mudah dipahami. Bidan dapat menyusun materi edukasi yang kontekstual, menggunakan bahasa lokal, serta menyisipkan cerita inspiratif dari ibu-ibu lain yang berhasil menjalani masa nifas dan KB dengan baik.

Untuk menangani mitos dan stigma, pendekatan budaya menjadi sangat penting. Edukasi sebaiknya dilakukan dengan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader kesehatan lokal yang dihormati oleh masyarakat. Mereka dapat menjadi jembatan yang efektif dalam menyampaikan pesan kesehatan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Diskusi kelompok, dialog lintas generasi, dan metode storytelling juga dapat digunakan untuk membuka ruang komunikasi yang lebih natural dan tidak menggurui.

Keterbatasan akses layanan dapat diatasi melalui strategi mobile health (mHealth) dan pelayanan berbasis komunitas. Pemanfaatan aplikasi pesan singkat, video edukasi yang dikirim melalui WhatsApp, atau layanan konseling daring dapat menjangkau ibu-ibu yang tinggal jauh dari fasilitas. Selain itu, memperkuat peran

kader Posyandu dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menyampaikan informasi reproduksi pascapersalinan akan memperluas jangkauan edukasi tanpa tergantung pada fasilitas formal semata.

I. Simpulan

Masa pascapersalinan merupakan periode kritis yang tidak hanya menandai pemulihan fisik ibu pasca melahirkan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi kesehatan reproduksi jangka panjang dan perencanaan keluarga yang sehat. Perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang terjadi dalam masa ini menuntut pendekatan pelayanan kebidanan yang holistik dan berkelanjutan. Edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana (KB) menjadi salah satu komponen utama yang harus diintegrasikan ke dalam pelayanan pascapersalinan guna mendukung perempuan dalam menjaga keseimbangan fungsi tubuh, kestabilan emosional, serta kesejahteraan relasional dengan pasangannya.

Pemahaman tentang konsep kesehatan reproduksi, hak-hak perempuan pascapersalinan, serta kebutuhan seksual dan emosional ibu menjadi landasan untuk menciptakan pelayanan yang bermartabat dan berbasis pada prinsip keadilan gender. Melalui edukasi yang tepat, ibu dan keluarga dapat membuat keputusan kontrasepsi secara sadar, memahami waktu yang aman untuk memulai kembali hubungan seksual, serta mengenali tanda-tanda gangguan reproduksi atau psikologis yang membutuhkan penanganan medis.

Dalam praktiknya, keberhasilan edukasi KB sangat ditentukan oleh kemampuan bidan dalam menerapkan komunikasi yang efektif, empatik, dan partisipatif. Peran suami dan keluarga inti sebagai pendukung utama ibu sangat krusial, sehingga keterlibatan mereka harus difasilitasi dalam setiap sesi edukasi. Komunikasi yang inklusif dan dialogis tidak hanya memperkuat pengambilan keputusan bersama, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan penggunaan kontrasepsi dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Namun demikian, pelaksanaan edukasi reproduksi pascapersalinan di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Rendahnya literasi kesehatan, mitos dan stigma budaya, serta keterbatasan akses layanan menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, strategi solutif yang kontekstual sangat diperlukan, seperti pendekatan budaya, kolaborasi komunitas, penggunaan teknologi informasi (mHealth), dan penguatan peran kader kesehatan. Semua ini bertujuan agar informasi kesehatan reproduksi dan KB dapat menjangkau ibu pascapersalinan secara luas, tepat, dan efektif.

Dengan pemahaman, dukungan, dan intervensi yang tepat, masa pascapersalinan dapat menjadi titik tolak pemberdayaan perempuan dalam

mengelola kesehatan reproduksi secara mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat. Hal ini pada akhirnya akan mendukung upaya nasional dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, meningkatkan kualitas hidup keluarga, serta menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera.

J. Referensi

- BKKBN. (2020). Panduan Layanan Keluarga Berencana Pascapersalinan. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., & Jensen, M. D. (2016). Maternity Nursing (6th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., & Dashe, J. S. (2018). Williams Obstetrics (25th ed.). McGraw-Hill Education.
- Departemen Kesehatan RI. (2019). Pedoman Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas. Jakarta: Direktorat Kesehatan Ibu.
- Kusmiran, E. (2012). Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita. Salemba Medika.
- WHO. (2022). Postnatal care of the mother and newborn: WHO guideline. Geneva: World Health Organization.

K. Glosarium

Masa pascapersalinan

Adalah masa transisi yang berlangsung sejak lahirnya plasenta hingga enam minggu setelah persalinan. Pada periode ini, tubuh ibu menjalani pemulihan menyeluruh secara fisik, psikologis, dan sosial.

Involusi uterus

Merupakan proses kembalinya ukuran dan kondisi rahim ke keadaan semula sebelum kehamilan. Proses ini biasanya berlangsung dalam enam minggu setelah melahirkan.

Lokia

Adalah cairan yang keluar dari jalan lahir ibu setelah persalinan. Lokia mencerminkan proses pembersihan rahim dan berlangsung dalam beberapa tahapan warna: rubra (merah), serosa (kecoklatan), dan alba (keputihan).

Baby blues

Merupakan gangguan emosional ringan yang umum terjadi pada ibu pascapersalinan, biasanya berlangsung singkat dan ditandai dengan perubahan mood, menangis tanpa sebab, dan mudah cemas.

Postpartum depression

Gangguan mental serius yang dialami sebagian ibu setelah melahirkan, ditandai dengan perasaan sedih mendalam, kehilangan minat, gangguan tidur, dan bahkan pikiran untuk menyakiti diri atau bayinya.

Kontrasepsi pascapersalinan

Metode pencegahan kehamilan yang diberikan setelah persalinan, bertujuan untuk menjaga jarak kehamilan dan memberikan waktu pemulihan bagi ibu secara optimal.

Informed choice

Hak individu untuk memilih tindakan atau keputusan secara sadar dan bebas setelah menerima informasi yang cukup, jelas, dan tidak memihak dari tenaga kesehatan.

Empati

Kemampuan untuk memahami dan merasakan kondisi emosional orang lain, yang ditunjukkan melalui perhatian tulus dan komunikasi yang mendukung.

Konseling

Proses komunikasi profesional antara tenaga kesehatan dan klien yang bertujuan untuk memberi dukungan psikososial, informasi, dan panduan dalam pengambilan keputusan.

Hak reproduksi

Hak dasar setiap individu, termasuk ibu pascapersalinan, untuk memperoleh informasi dan layanan kesehatan terkait reproduksi secara aman, bermartabat, dan tanpa diskriminasi.

CHAPTER 7

EVALUASI MUTU LAYANAN KEBIDANAN PADA MASA NIFAS

Nur Hidayati, S.SiT., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Masa nifas merupakan salah satu periode yang sangat krusial dalam siklus reproduksi seorang perempuan. Masa ini dimulai sejak lahirnya plasenta hingga kurang lebih enam minggu setelah persalinan. Meskipun fase kehamilan dan proses persalinan telah dilalui, masa nifas tetap menyimpan risiko tinggi terhadap terjadinya komplikasi yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa ibu dan bayinya. Di sinilah pentingnya pengawasan dan pemantauan berkelanjutan, karena banyak kejadian yang memerlukan penanganan segera justru terjadi dalam periode ini. Komplikasi seperti perdarahan postpartum sekunder, infeksi puerperal, mastitis, tromboemboli, gangguan psikologis, hingga kemunduran dalam proses menyusui merupakan contoh kondisi yang dapat muncul dan berdampak serius jika tidak terdeteksi lebih awal.

Pentingnya perhatian terhadap masa nifas sering kali terabaikan dalam praktik pelayanan kesehatan, baik oleh sistem pelayanan itu sendiri maupun oleh masyarakat umum. Banyak ibu yang tidak kembali melakukan kunjungan kesehatan atau hanya menganggap masa nifas sebagai masa pemulihan biasa tanpa risiko berarti. Padahal, periode ini adalah momentum krusial yang sangat menentukan kualitas hidup jangka panjang ibu dan anak. Kegagalan dalam mendeteksi atau menangani masalah pada masa nifas dapat berujung pada morbiditas bahkan mortalitas ibu maupun bayi yang sebenarnya bisa dicegah.

Dalam konteks inilah, evaluasi mutu layanan kebidanan pada masa nifas menjadi sangat penting dan tidak dapat dipandang sebagai rutinitas administratif semata. Evaluasi mutu merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelayanan kebidanan pada masa nifas telah memenuhi standar asuhan yang aman, efektif, dan berpusat pada kebutuhan pasien. Dengan melakukan evaluasi, fasilitas kesehatan dan tenaga kebidanan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pelayanan, menemukan celah pada proses asuhan, serta merumuskan strategi perbaikan berkelanjutan berdasarkan data dan bukti yang valid. Evaluasi mutu juga menjadi jembatan untuk menghubungkan aspek klinis

dengan manajerial, sekaligus menjadi mekanisme akuntabilitas bagi pelayanan publik di bidang kesehatan ibu dan anak.

Lebih jauh, dalam kerangka sistem kesehatan nasional maupun global, peningkatan mutu pelayanan nifas selaras dengan komitmen untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, seperti yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target 3.1 dan 3.2. Oleh karena itu, mutu pelayanan kebidanan pada masa nifas bukan hanya isu teknis, melainkan bagian integral dari pembangunan kesehatan yang berkeadilan dan berbasis hak asasi manusia. Setiap ibu berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu tinggi, tidak hanya saat melahirkan, tetapi juga dalam setiap fase pemulihan pascapersalinan.

B. Dimensi Mutu dalam Pelayanan Kebidanan Masa Nifas

Mutu pelayanan kebidanan pada masa nifas merupakan fondasi utama untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan ibu serta bayi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan berbagai standar nasional telah menetapkan sejumlah dimensi mutu sebagai tolok ukur dalam menilai dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, termasuk layanan kebidanan. Dimensi-dimensi ini tidak hanya mencerminkan hasil klinis, tetapi juga pengalaman pengguna layanan dan keberlanjutan sistem pelayanan itu sendiri. Dalam konteks pelayanan kebidanan masa nifas, dimensi mutu tersebut mencakup efektivitas, efisiensi, aksesibilitas, keterjangkauan, kesetaraan, dan responsivitas.

Efektivitas mengacu pada kemampuan layanan kebidanan dalam menghasilkan hasil yang diharapkan berdasarkan bukti ilmiah. Dalam masa nifas, efektivitas ditunjukkan melalui tindakan-tindakan yang terbukti secara klinis menurunkan risiko komplikasi ibu dan bayi, seperti edukasi laktasi, deteksi dini depresi postpartum, manajemen perdarahan, hingga penyuluhan kontrasepsi. Pelayanan yang efektif akan menggunakan pedoman praktik terkini dan memastikan bahwa setiap intervensi yang diberikan memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan risiko tambahan.

Efisiensi merujuk pada pemanfaatan sumber daya yang optimal dalam memberikan layanan berkualitas. Ini berarti pelayanan kebidanan harus mampu mencapai hasil terbaik dengan biaya, waktu, dan tenaga seminimal mungkin tanpa mengorbankan mutu. Contohnya adalah penggunaan sistem kunjungan rumah terjadwal untuk menjangkau ibu nifas di wilayah terpencil tanpa harus membebani fasilitas pelayanan primer. Pelayanan yang efisien juga mencakup pengelolaan logistik dan waktu kerja tenaga kesehatan yang terstruktur dan tepat sasaran.

Aksesibilitas mencerminkan sejauh mana ibu nifas dapat memperoleh layanan kebidanan tanpa menghadapi hambatan geografis, sosial, budaya, atau

administratif. Layanan yang berkualitas tinggi akan memastikan bahwa setiap ibu, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau masyarakat adat, mendapatkan hak yang sama untuk dilayani dengan baik. Dalam praktiknya, ini dapat diwujudkan melalui pembentukan posyandu mobile, pelayanan telekonsultasi, serta kerja sama lintas sektor untuk menjangkau kelompok rentan.

Keterjangkauan merupakan aspek penting yang mengukur seberapa mampu pengguna layanan—dalam hal ini ibu pascapersalinan—membayar atau mengakses layanan tanpa harus mengalami kesulitan ekonomi. Pelayanan kebidanan masa nifas yang berkualitas tinggi harus memberikan intervensi yang terstandar tanpa membebani pasien secara finansial. Di Indonesia, ini berarti pelayanan nifas harus dapat diakses melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan program subsidi pemerintah.

Kesetaraan menunjukkan bahwa pelayanan kebidanan harus bebas dari diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, agama, etnis, usia, atau lokasi geografis. Ibu nifas berhak mendapatkan perlakuan yang setara, dengan standar pelayanan yang sama tinggi, terlepas dari latar belakang mereka. Dimensi ini sangat penting dalam mewujudkan pelayanan yang adil dan bermartabat bagi semua ibu dan bayi.

Responsivitas merujuk pada kemampuan sistem pelayanan kebidanan dalam menanggapi kebutuhan, preferensi, dan harapan ibu pascapersalinan secara cepat, tanggap, dan manusiawi. Responsivitas mencakup penyediaan informasi yang jelas dan komunikatif, sikap empatik tenaga kesehatan, dan kesediaan mendengarkan keluhan pasien secara aktif. Layanan yang responsif tidak hanya meningkatkan kepuasan pasien, tetapi juga memperkuat hubungan saling percaya antara bidan dan keluarga.

C. Indikator Mutu Pelayanan Nifas

Evaluasi mutu layanan kebidanan pada masa nifas tidak dapat dilepaskan dari pemantauan indikator mutu yang terukur dan relevan. Indikator mutu ini digunakan untuk menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta berdampak nyata pada keselamatan dan kesejahteraan ibu dan bayi. Dalam kerangka evaluasi mutu, indikator biasanya dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: input, proses, dan output. Masing-masing kategori menggambarkan tahapan penting dalam sistem pelayanan yang saling berkaitan.

Indikator input mencerminkan kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh fasilitas pelayanan kebidanan dalam memberikan asuhan masa nifas. Hal ini mencakup:

1. Ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten, terutama bidan, yang mampu memberikan pelayanan sesuai standar. Rasio jumlah bidan terhadap jumlah kunjungan nifas dapat digunakan untuk melihat kecukupan tenaga.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana, seperti ruangan pemeriksaan nifas, tempat laktasi, ruang konseling, hingga alat untuk pemeriksaan fisik dan deteksi dini komplikasi (tensimeter, termometer, alat deteksi anemia, dan lain-lain).
3. Ketersediaan logistik dan obat-obatan, termasuk alat kontrasepsi pascapersalinan, formulir standar asuhan, vitamin, dan antibiotik dasar bila diperlukan.

Tanpa input yang memadai, maka proses pelayanan akan sulit dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan pada indikator input menjadi langkah awal dalam menjamin mutu layanan kebidanan.

Indikator proses menilai sejauh mana kegiatan pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur yang telah distandarisasi. Ini mencakup:

1. Kepatuhan tenaga kebidanan terhadap standar asuhan nifas, seperti melakukan minimal tiga kali kunjungan nifas sesuai waktu yang ditetapkan (KF1: 6 jam–3 hari, KF2: hari ke-4–28, dan KF3: hari ke-29–42).
2. Penerapan komunikasi efektif dan konseling, termasuk keterlibatan ibu dan keluarga dalam diskusi perawatan diri, perawatan bayi, menyusui, serta rencana kontrasepsi.
3. Pencatatan dan pelaporan yang akurat, seperti pengisian buku KIA, pelaporan ke sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA), dan rekam medis yang lengkap.

Indikator proses menjadi cermin sejauh mana pelayanan kebidanan berjalan sesuai dengan prinsip professional accountability dan standar mutu yang diharapkan.

Indikator output berfokus pada hasil atau dampak langsung dari proses pelayanan kebidanan masa nifas. Beberapa indikator penting dalam kategori ini antara lain:

1. Cakupan kunjungan nifas, yakni persentase ibu yang menerima kunjungan minimal sesuai standar waktu yang ditetapkan. Indikator ini digunakan secara nasional dalam pemantauan kinerja pelayanan dasar.
2. Tingkat kepuasan ibu nifas, yang mencerminkan pengalaman dan persepsi pasien terhadap pelayanan yang diterima. Evaluasi ini biasanya dilakukan melalui survei

kepuasan pasien yang mencakup aspek komunikasi, waktu tunggu, kenyamanan, dan empati tenaga kesehatan.

3. Jumlah komplikasi nifas yang terdeteksi dan ditangani secara tepat, seperti infeksi, perdarahan, gangguan psikologis, atau gangguan laktasi. Semakin tinggi angka deteksi dini komplikasi, maka semakin menunjukkan keberhasilan sistem deteksi dan respons pelayanan.

Dengan mengintegrasikan ketiga kelompok indikator ini secara konsisten dalam evaluasi, maka mutu pelayanan kebidanan pada masa nifas dapat dimonitor secara komprehensif dan berkelanjutan. Evaluasi indikator-indikator tersebut tidak hanya penting dalam proses akreditasi dan penjaminan mutu layanan, tetapi juga sangat bermanfaat dalam menyusun kebijakan perbaikan berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan. Oleh sebab itu, setiap tenaga kebidanan, manajer fasilitas, dan pembuat kebijakan perlu menjadikan indikator mutu ini sebagai alat refleksi dan perbaikan terus-menerus dalam rangka menjamin keselamatan dan kualitas hidup ibu dan bayi pascapersalinan.

D. Metode Evaluasi Mutu Layanan Kebidanan

Evaluasi mutu layanan kebidanan pada masa nifas memerlukan pendekatan yang sistematis dan komprehensif agar dapat menghasilkan gambaran utuh terhadap kualitas layanan yang diberikan. Untuk mencapainya, digunakan metode evaluasi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, yang masing-masing memiliki keunggulan tersendiri dan saling melengkapi. Metode-metode ini tidak hanya berperan dalam mengukur capaian kinerja, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelemahan layanan, merumuskan perbaikan, dan menilai efektivitas intervensi.

Pendekatan kuantitatif fokus pada data numerik dan statistik, yang memungkinkan penilaian objektif terhadap capaian indikator pelayanan kebidanan. Beberapa metode yang termasuk dalam pendekatan ini antara lain:

- a. Penilaian indikator cakupan layanan, seperti cakupan kunjungan nifas sesuai standar waktu (KF1, KF2, KF3), cakupan konseling kontrasepsi, atau cakupan deteksi dini komplikasi. Data ini biasanya diperoleh dari sistem pelaporan rutin (misalnya SIRANAP, SIKDA, e-PPGBM) dan digunakan untuk memantau kinerja layanan secara agregat.
- b. Survei kepuasan pasien, dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada ibu nifas untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap berbagai aspek layanan, seperti keramahan tenaga kesehatan, kenyamanan fasilitas, kejelasan informasi yang diberikan, dan waktu tunggu. Hasil survei ini dapat dianalisis secara statistik untuk menemukan area yang paling memerlukan perbaikan.

Sementara itu, pendekatan kualitatif memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan konteks sosial budaya yang mempengaruhi kualitas layanan. Beberapa metode evaluasi kualitatif yang umum digunakan dalam konteks layanan kebidanan antara lain:

- a. Audit klinis, yaitu peninjauan ulang secara sistematis terhadap catatan medis, proses pelayanan, dan kepatuhan terhadap standar asuhan kebidanan. Audit ini biasanya dilakukan oleh tim yang terdiri dari tenaga kebidanan senior atau pengawas mutu, untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar praktik klinis nasional maupun pedoman WHO. Audit klinis dapat dilakukan secara periodik dan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi mutu.
- b. Wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD), yang melibatkan ibu nifas, suami, tenaga kesehatan, atau kader, untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman mereka selama menerima layanan. Temuan dari wawancara ini sangat berguna untuk menangkap dimensi subjektif layanan, seperti empati bidan, kualitas komunikasi, serta hambatan akses yang mungkin tidak terlihat dari data numerik.
- c. Tracer study atau penelusuran kasus, digunakan untuk mengevaluasi alur pelayanan yang diterima oleh pasien secara longitudinal. Misalnya, seorang ibu nifas yang mengalami komplikasi (seperti infeksi atau depresi) ditelusuri perjalanan pelayanannya sejak persalinan hingga fase pemulihan, termasuk interaksi dengan tenaga kesehatan, waktu kunjungan, pemberian edukasi, dan penanganan yang diterima. Dari penelusuran ini, dapat ditemukan celah dalam sistem pelayanan, seperti keterlambatan rujukan, kesalahan dokumentasi, atau komunikasi yang tidak efektif.

Kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif ini dikenal sebagai evaluasi triangulasi, karena dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan valid mengenai mutu layanan kebidanan masa nifas. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam menyusun rencana peningkatan mutu (quality improvement plan), merancang pelatihan berkelanjutan untuk tenaga kesehatan, serta menetapkan indikator kinerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasien.

E. Peran Bidan dalam Monitoring dan Evaluasi Pelayanan

Bidan memegang peranan sentral dalam memastikan mutu pelayanan kebidanan pada masa nifas. Selain sebagai pelaksana asuhan langsung, bidan juga berperan sebagai pemantau, pencatat, pelapor, dan evaluator yang berkontribusi pada perbaikan sistem pelayanan secara keseluruhan. Dalam kerangka monitoring dan evaluasi (monev), bidan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi

juga fungsi strategis yang mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas.

Salah satu tanggung jawab utama bidan dalam monitoring adalah dokumentasi dan pencatatan kunjungan nifas secara tepat dan lengkap. Hal ini mencakup pencatatan tanggal kunjungan (KF1, KF2, KF3), hasil pemeriksaan fisik ibu dan bayi, konseling yang diberikan (misalnya kontrasepsi, nutrisi, tanda bahaya), serta keluhan atau komplikasi yang ditemukan. Dokumentasi yang baik tidak hanya mendukung kesinambungan pelayanan, tetapi juga menjadi dasar penting dalam pelaporan dan pengambilan keputusan klinis berikutnya.

Selain itu, bidan memiliki tanggung jawab dalam identifikasi dan pelaporan kasus risiko tinggi. Misalnya, ibu dengan tanda infeksi postpartum, perdarahan, gangguan psikologis seperti depresi pascamelahirkan, atau bayi dengan berat badan lahir rendah, harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai sistem rujukan. Pelaporan ini tidak hanya bermanfaat bagi manajemen kasus individual, tetapi juga penting dalam membangun basis data komunitas dan evaluasi epidemiologis.

Dalam konteks evaluasi mutu, bidan juga dilibatkan dalam proses audit internal atau evaluasi berbasis tim. Biasanya dilakukan secara periodik oleh tim mutu di puskesmas atau rumah sakit, bidan menyampaikan hasil asuhan, tantangan pelayanan, serta usulan perbaikan. Evaluasi ini sering dilakukan dalam bentuk audit klinis, penelaahan rekam medis, forum mutu, atau rapat tim maternal-neonatal. Dalam forum ini, keterlibatan bidan menjadi penting untuk memberikan perspektif lapangan yang autentik dan berbasis pengalaman langsung.

Selanjutnya, peran bidan dalam monev tidak terlepas dari komitmen terhadap peningkatan kapasitas diri. Bidan diharapkan mengikuti pelatihan atau workshop mengenai evaluasi mutu layanan, audit klinis, manajemen risiko, serta penggunaan alat bantu digital seperti e-MCH Handbook atau SiHaTi. Peningkatan kapasitas ini akan memperkuat kemampuan bidan dalam membaca indikator pelayanan, menilai efektivitas intervensi, dan mengimplementasikan perbaikan mutu berbasis bukti.

Bidan juga dapat berperan dalam pengembangan inovasi berbasis komunitas, seperti melakukan pemetaan risiko di wilayah kerja, membangun sistem pencatatan kunjungan berbasis WhatsApp group ibu nifas, atau membuat program tindak lanjut ibu dengan masalah psikologis. Inovasi seperti ini mendukung evaluasi layanan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan peran aktif dalam seluruh siklus monitoring dan evaluasi—mulai dari pencatatan, pelaporan, refleksi, hingga pengembangan solusi—bidan menjadi garda depan dalam menjamin mutu layanan kebidanan pada masa nifas. Hal ini tidak hanya berdampak pada keselamatan dan kenyamanan ibu dan bayi, tetapi juga

meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pelayanan kebidanan secara menyeluruh.

F. Tantangan dalam Menjaga Mutu Pelayanan Nifas

Menjaga mutu pelayanan kebidanan pada masa nifas merupakan tantangan yang kompleks, terutama ketika dihadapkan pada berbagai kendala operasional dan sistemik di lapangan. Meskipun kebijakan dan pedoman teknis telah tersedia, implementasi pelayanan yang berkualitas seringkali terhambat oleh berbagai faktor yang saling terkait dan memengaruhi efektivitas peran bidan serta tenaga kesehatan lainnya.

Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah beban kerja yang tinggi. Bidan, khususnya di fasilitas pelayanan tingkat pertama seperti Puskesmas atau praktik mandiri bidan, kerap kali menangani banyak pasien dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Pelayanan tidak hanya mencakup masa nifas, tetapi juga kehamilan, persalinan, imunisasi bayi, pelayanan KB, dan administrasi pelaporan. Kondisi ini menyebabkan waktu yang tersedia untuk melakukan kunjungan nifas secara komprehensif dan evaluasi mutu menjadi sangat terbatas. Keterbatasan waktu ini berdampak pada kualitas komunikasi dengan pasien, konseling, pencatatan, serta deteksi dini komplikasi.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan besar, terutama di daerah terpencil dan perbatasan. Jumlah bidan yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah kerja menyebabkan pelayanan nifas sering tidak optimal. Selain itu, distribusi bidan yang belum merata secara geografis mengakibatkan sebagian wilayah mengalami kekosongan tenaga kesehatan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap mutu layanan dan keterjangkauan kunjungan rumah atau tindak lanjut ibu pascapersalinan.

Kurangnya pelatihan atau pembinaan terkait manajemen mutu juga memperburuk situasi. Banyak bidan yang belum mendapatkan pelatihan berkelanjutan tentang standar mutu pelayanan, audit klinis, pengelolaan risiko, atau cara membaca indikator mutu. Hal ini menyebabkan evaluasi mutu cenderung dilakukan secara administratif dan tidak menyentuh aspek substansi klinis atau pengalaman pasien. Akibatnya, identifikasi masalah pelayanan bersifat reaktif, bukan preventif atau promotif.

Resistensi terhadap supervisi dan audit eksternal merupakan tantangan psikososial yang tidak dapat diabaikan. Dalam beberapa kasus, bidan merasa tidak nyaman atau bahkan terancam ketika hasil praktiknya dievaluasi oleh pihak luar. Ketakutan terhadap kritik, stigma profesional, atau sanksi administratif sering menyebabkan bidan enggan terbuka terhadap proses audit atau kunjungan

supervisi. Akibatnya, momen evaluasi yang seharusnya digunakan untuk pembelajaran dan peningkatan mutu berubah menjadi aktivitas formalitas tanpa makna perbaikan.

Tantangan lainnya termasuk kurangnya dukungan manajerial dan kebijakan fasilitas kesehatan, seperti tidak tersedianya alat transportasi untuk kunjungan rumah, kurangnya alat pemantauan standar (misalnya timbangan digital bayi, alat tensi portabel), atau minimnya sistem insentif bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan berkualitas.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang bersifat sistemik, partisipatif, dan berkelanjutan. Kunci keberhasilan perbaikan mutu pelayanan nifas tidak hanya terletak pada individu bidan, tetapi juga pada sistem dukungan yang tersedia di sekelilingnya: dari manajemen puskesmas, dinas kesehatan, hingga kebijakan nasional yang mendukung pendidikan, distribusi, dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang berkomitmen pada pelayanan bermutu. Tanpa perbaikan dari hulu ke hilir, upaya mempertahankan mutu pelayanan nifas hanya akan menjadi cita-cita yang sulit diwujudkan secara nyata.

G. Strategi Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Dalam konteks pelayanan kebidanan pada masa nifas, penerapan strategi peningkatan mutu yang bersifat berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa layanan tidak hanya sesuai standar, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan pasien, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial masyarakat. Salah satu pendekatan yang diakui secara luas dalam sistem kesehatan modern adalah Continuous Quality Improvement (CQI), atau peningkatan mutu berkelanjutan.

CQI merupakan pendekatan sistematis yang berfokus pada analisis dan peningkatan proses pelayanan secara terus-menerus dengan tujuan meningkatkan hasil yang dicapai. Dalam praktik kebidanan, hal ini melibatkan pemantauan rutin terhadap proses dan hasil pelayanan masa nifas, identifikasi masalah yang berulang, pengembangan solusi berbasis data, serta evaluasi hasil intervensi untuk perbaikan selanjutnya. CQI tidak berhenti pada pencapaian standar minimal, tetapi mendorong tenaga kesehatan untuk terus mencari cara meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna layanan.

Salah satu komponen penting dalam CQI adalah penggunaan data pelayanan sebagai dasar pengambilan keputusan. Data kunjungan nifas, catatan komplikasi, kepuasan pasien, hingga indikator keberhasilan ASI eksklusif dapat dianalisis untuk mengidentifikasi celah layanan. Misalnya, bila data menunjukkan angka kunjungan nifas ketiga rendah, maka dilakukan investigasi terhadap penyebabnya, seperti ketidaksesuaian jadwal, kurangnya edukasi ibu, atau kendala transportasi. Data ini

kemudian dijadikan dasar untuk merancang intervensi perbaikan, misalnya penjadwalan ulang kunjungan atau peningkatan edukasi saat kunjungan pertama.

Pelibatan ibu dan keluarga dalam proses evaluasi mutu juga merupakan aspek esensial dalam pendekatan yang berpusat pada pasien. Pengalaman ibu selama masa nifas memberikan informasi yang sangat berharga terkait kenyamanan, aksesibilitas, komunikasi bidan, dan kepuasan terhadap layanan. Feedback dari ibu dan keluarga dapat dikumpulkan melalui survei, wawancara, atau forum diskusi komunitas. Melalui partisipasi aktif pengguna layanan, sistem kebidanan dapat lebih responsif dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Selain itu, inovasi pelayanan berbasis kebutuhan lokal dan teknologi merupakan strategi penting untuk menjangkau ibu pascapersalinan secara lebih efektif. Salah satu contohnya adalah kunjungan rumah berbasis risiko, di mana prioritas diberikan kepada ibu yang teridentifikasi memiliki risiko komplikasi (misalnya, riwayat preeklamsia, operasi sesar, atau masalah laktasi). Strategi ini lebih efisien dibandingkan kunjungan rutin yang dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi individual.

Pemanfaatan teknologi digital atau mHealth (mobile health) juga semakin relevan dalam meningkatkan mutu layanan. Aplikasi telekonsultasi, pengingat jadwal kunjungan nifas, sistem pencatatan elektronik, hingga layanan pesan pendek untuk edukasi ibu telah terbukti efektif dalam memperluas jangkauan informasi, meningkatkan kepatuhan ibu terhadap kontrol, dan mempercepat respon terhadap tanda bahaya. Di daerah terpencil, pendekatan mHealth dapat menjadi solusi untuk keterbatasan SDM dan geografis.

Terakhir, pelatihan komunikasi empatik bagi bidan merupakan strategi penting yang tidak boleh diabaikan. Kualitas interaksi antara bidan dan ibu sangat menentukan keberhasilan edukasi, kepercayaan terhadap layanan, dan kepuasan pengguna. Pelatihan ini mencakup keterampilan mendengarkan aktif, komunikasi dua arah, penghargaan terhadap nilai budaya, serta penyampaian informasi yang sensitif secara emosional dan sosial. Bidan yang mampu menjalin hubungan empatik dengan ibu pascapersalinan cenderung lebih berhasil dalam memberikan edukasi yang diterima dan diikuti oleh pasien.

Dengan mengintegrasikan prinsip CQI, pemanfaatan data yang cermat, partisipasi aktif keluarga, dan inovasi layanan berbasis teknologi serta pendekatan empatik, mutu pelayanan kebidanan pada masa nifas dapat ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan indikator kesehatan ibu dan bayi, tetapi juga membangun sistem layanan kesehatan yang lebih manusiawi, adaptif, dan berkeadilan.

H. Simpulan

Evaluasi mutu layanan kebidanan pada masa nifas merupakan pilar penting dalam menjamin keselamatan dan kualitas hidup ibu serta bayi. Masa nifas adalah periode yang sangat rentan terhadap komplikasi, namun seringkali terabaikan dalam sistem pelayanan kesehatan. Padahal, intervensi yang tepat dan terstandar pada fase ini mampu mencegah berbagai kejadian yang membahayakan jiwa, seperti perdarahan sekunder, infeksi, gangguan psikologis, dan kesulitan menyusui. Untuk itu, upaya perbaikan layanan pada masa nifas perlu didasarkan pada sistem evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Mutu pelayanan tidak hanya diukur dari keberhasilan klinis semata, tetapi juga dari dimensi yang lebih luas seperti efektivitas, efisiensi, aksesibilitas, keterjangkauan, kesetaraan, dan responsivitas terhadap kebutuhan ibu. Penilaian mutu yang akurat membutuhkan pendekatan indikator input, proses, dan output yang relevan dan terukur, serta pelibatan berbagai metode evaluasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Peran aktif bidan dalam dokumentasi, pelaporan, audit klinis, dan refleksi tim menjadi kunci dalam menjembatani praktik klinis dengan penguatan sistem pelayanan.

Namun demikian, terdapat berbagai tantangan di lapangan yang menghambat tercapainya mutu layanan yang optimal, mulai dari beban kerja tinggi, keterbatasan SDM, minimnya pelatihan mutu, hingga resistensi terhadap proses supervisi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi peningkatan mutu berkelanjutan melalui pendekatan Continuous Quality Improvement (CQI), penggunaan data pelayanan sebagai dasar pengambilan keputusan, inovasi teknologi seperti mHealth, kunjungan rumah berbasis risiko, serta pelatihan komunikasi empatik bagi bidan.

Dengan penerapan evaluasi mutu yang sistematis dan terintegrasi dalam praktik kebidanan, masa nifas tidak lagi dipandang sebagai fase pasif pemulihan, melainkan sebagai kesempatan emas untuk memperkuat ketahanan kesehatan ibu dan anak. Evaluasi mutu yang baik akan melahirkan sistem pelayanan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga manusiawi, inklusif, dan berbasis hak asasi perempuan. Inilah bentuk nyata kontribusi kebidanan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan ibu dan anak.

I. Referensi

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2019). Riset Kesehatan Dasar 2018. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://www.litbang.kemkes.go.id/laporan-rkd-2018>
- Depkes RI. (2018). Standar Pelayanan Kebidanan. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir. Direktorat Kesehatan Keluarga, Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Koblinsky, M., Campbell, O., & Heichelheim, J. (2016). Organizing delivery care: What works for safe motherhood. *Bulletin of the World Health Organization*, 77(5), 399–406.
- Miller, S., Abalos, E., Chamillard, M., Ciapponi, A., Colaci, D., Comandé, D., ... & Althabe, F. (2016). Beyond too little, too late and too much, too soon: a pathway towards evidence-based, respectful maternity care worldwide. *The Lancet*, 388(10056), 2176–2192. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31472-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31472-6)
- Perry, H. B., Rassekh, B. M., Gupta, S., Wilhelm, J., & Freeman, P. A. (2017). Comprehensive review of the evidence regarding the effectiveness of community-based primary health care in improving maternal, neonatal and child health: 1. rationale, methods and database description. *Journal of Global Health*, 7(1), 010901. <https://doi.org/10.7189/jogh.07.010901>
- Titaley, C. R., Dibley, M. J., & Roberts, C. L. (2010). Factors associated with non-utilization of postnatal care services in Indonesia. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 64(10), 827–831. <https://doi.org/10.1136/jech.2008.081604>
- World Health Organization. (2015). Strategies toward ending preventable maternal mortality (EPMM). Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241508483>
- World Health Organization. (2016). Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities. Geneva: WHO Press. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/249155>

J. Glosarium

Masa Nifas

Periode setelah lahirnya plasenta hingga sekitar enam minggu pascapersalinan, di mana tubuh ibu mengalami pemulihan fisiologis, psikologis, dan hormonal.

Evaluasi Mutu

Proses sistematis untuk menilai sejauh mana pelayanan kebidanan telah memenuhi standar kualitas, keselamatan, dan kepuasan pasien guna melakukan perbaikan berkelanjutan.

Efektivitas

Ukuran keberhasilan layanan kebidanan dalam mencapai hasil klinis yang diinginkan, berdasarkan bukti ilmiah dan praktik terbaik.

Efisiensi

Tingkat optimal penggunaan sumber daya (waktu, tenaga, biaya) dalam penyelenggaraan layanan berkualitas tinggi.

Aksesibilitas

Kemudahan bagi ibu pascapersalinan dalam mendapatkan layanan kebidanan tanpa hambatan geografis, sosial, atau budaya.

Keterjangkauan

Kemampuan pasien untuk memperoleh pelayanan tanpa beban ekonomi yang berat, termasuk layanan yang dijamin oleh sistem pembiayaan nasional seperti JKN.

Kesetaraan

Prinsip pemberian layanan yang adil, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis.

Responsivitas

Kemampuan sistem layanan kebidanan merespons secara tanggap, empatik, dan manusiawi terhadap kebutuhan dan harapan pasien.

Indikator Input

Komponen awal dalam evaluasi mutu, mencakup sumber daya seperti tenaga kesehatan, alat, logistik, dan sarana prasarana.

Indikator Proses

Ukuran kepatuhan tenaga kebidanan terhadap standar operasional dalam pelaksanaan pelayanan, seperti kunjungan nifas dan konseling.

Indikator Output

Hasil langsung dari pelayanan kebidanan, seperti cakupan kunjungan nifas, kepuasan ibu, dan jumlah komplikasi yang berhasil dideteksi atau ditangani.

Audit Klinis

Prosedur evaluasi terhadap rekam medis dan proses pelayanan untuk menilai kepatuhan terhadap standar dan mengidentifikasi celah mutu.

Tracer Study

Penelusuran perjalanan pelayanan pasien secara menyeluruh, dari awal hingga akhir asuhan, guna mengetahui efektivitas layanan dan titik lemah sistem.

Continuous Quality Improvement (CQI)

Pendekatan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu layanan melalui analisis data, pengembangan solusi, dan evaluasi hasil perbaikan.

mHealth (Mobile Health)

Penggunaan teknologi mobile seperti aplikasi dan SMS untuk mendukung pelayanan kesehatan, edukasi, serta pemantauan ibu nifas secara jarak jauh.

Survei Kepuasan Pasien

Alat untuk mengukur persepsi ibu terhadap kualitas pelayanan kebidanan berdasarkan pengalaman mereka, biasanya berupa kuesioner atau wawancara.

Bidan

Tenaga kesehatan profesional yang berperan sentral dalam memberikan asuhan kebidanan, pemantauan, edukasi, serta evaluasi selama masa nifas.

Komunikasi Empatik

Keterampilan komunikasi bidan yang menekankan pada pemahaman, rasa hormat, dan keterbukaan terhadap perasaan dan kebutuhan pasien.

Pelatihan Mutu

Program peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan dalam hal evaluasi mutu, audit klinis, dan penggunaan indikator pelayanan.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Agenda pembangunan global yang salah satu targetnya adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui peningkatan mutu layanan kesehatan.

PROFIL PENULIS



Bd. Dewi Mayangsari, S.Si.T., M.Kes., M.Keb. Ketua Penulis Lahir di Semarang, 23 Maret 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-IV Kebidanan pada Program Studi D-IV Kebidanan, STIKes Ngudi Waluyo Ungaran tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro jurusan MKIA (Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak) lulus tahun pada tahun 2014, melanjutkan Pendidikan Profesi Bidan lulus tahun 2022 dan S2 pada STIKes Guna Bangsa Yogyakarta jurusan Magister Kebidanan lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2004 di Akademi Kebidanan Karya Husada Semarang sampai dengan sekarang yang sudah bertransformasi menjadi Universitas Karya Husada Semarang.

Penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas, Natural Therapy Kebidanan, Natural Advance Therapy, Promosi Kesehatan, Metodik Khusus, Panum Asuhan Kebidanan Nifas, Evidence Based Midwifery. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku di OPTIMAL, publikasi artikel, seminar, webinar serta pelatihan-pelatihan yang mendukung kinerja di Kebidanan. JaFung: Lektor. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mayang230380@gmail.com

Motto: "Kejarlah Akhiratmu, Dunia Akan Mengikutimu"



Rolita Efriani, S.ST., M.Keb Lahir di Kelutum, Bengkulu Selatan, Agustus tahun 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Program Studi Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2014, DIV Program Studi Kebidanan, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan lulus tahun 2019. Riwayat pekerjaan sebagai Dosen Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu sekaligus sebagai PJ SPMI Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Bengkulu sejak tahun 2020. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan

Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, Pengantar Praktik Kebidanan, Evidence Based dalam Praktik Kebidanan, Praktik Profesional Bidan, Ilmu Kesehatan Anak, Psikologi perkembangan, Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan, dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis juga aktif sebagai penulis buku serta jurnal ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: efrianirolita@gmail.com dan efrianirolita@poltekkesbengkulu.ac.id

Motto: "Do the Best and God will Do the Rest"

PROFIL PENULIS



Ririn Ratnasari lahir di Trenggalek, 05 September 1985. Sejak awal menempuh pendidikan, ia menunjukkan ketertarikan yang kuat pada bidang kebidanan dan kesehatan reproduksi. Setelah menyelesaikan pendidikan Diploma IV Kebidanan di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2009, ia melanjutkan studi ke jenjang Magister Kesehatan Reproduksi di Universitas Airlangga Surabaya dan berhasil meraih gelar pada tahun 2016.

Karier profesionalnya dimulai sejak tahun 2009, dan hingga kini ia aktif sebagai dosen yang mengampu mata kuliah *Asuhan Kebidanan Pascasalin dan Menyusui*, serta *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga*

Berencana. Dalam perannya sebagai pendidik, saya tidak hanya berfokus pada proses pembelajaran di kelas, tetapi juga konsisten mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini diwujudkan melalui keterlibatannya sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, serta partisipasi dalam seminar-seminar nasional maupun internasional.

Bagi saya, ilmu adalah bekal untuk dunia dan akhirat, sebagaimana motto hidupnya: *"Kejarlah Akhirat, Dunia Pasti Kau Dapat."*



Handayani, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat. Lahir di Yogyakarta, 5 Juni 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 1997. Kemudian melanjutkan pendidikan Spesialis Keperawatan Maternitas pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2005. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997 di Akper Sismadi Jakarta, tahun 1999 di Akper Husda Karya Jaya Jakarta dan tahun 2000 di Akper Bani Saleh Bekasi. Saat ini penulis bekerja di Universitas Binawan dari tahun 2005 mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas di Program Profesi

Ners, mata kuliah Maternity Nursing dan mata kuliah Women Reproductive Health in Nursing. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail handayani@binawan.ac.id

PROFIL PENULIS



Nur Hidayati, S.SiT., M. Kes. Lahir di Wonogiri, Jawa Tengah pada 06 Maret 1989. Penulis menyelesaikan Pendidikan D III Kebidanan di Stikes Mamba'ul Uluum Surakarta (2010). Bidan Pendidik di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran Semarang (2011). Gelar Magister Kesehatan Masyarakat dengan konsentrasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) diperoleh dari Universitas Diponegoro Semarang (2015).

Riwayat Pekerjaan: Dosen D3 Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan (2012 .d 2016). Pada tahun 2017 sampai sekarang bekerja sebagai Dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada program studi ilmu Kebidanan. Penulis mengampu berbagai mata

kuliah yakni Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Pascasalin dan Menyusui, Asuhan Kebidanan Neonatus dan Bayi, Asuhan Kebidanan Komunitas, Ketrampilan Klinik Praktik Kebidanan, Kebutuhan Dasar Manusia, Mutu Layanan Kebidanan, Anatomi Fisiologi dan Kewirausahaan. Selain itu, Penulis juga aktif dalam Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya di penulisan buku diantaranya Asuhan Kebidanan Kehamilan (2022), Kesehatan Reproduksi Generasi Digital dalam Perspektif Psikologi Islam (2024), Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan Pada Anak. Penulis dapat dihubungi melalui email nuhaida234@gmail.com.

Motto: "Keahlian menjadi bermakna ketika dibagikan, dan ilmu menjadi abadi ketika dituliskan"

Sinopsis

“Berbasis bukti terkini dan konteks layanan di Indonesia, bunga rampai ini merangkum perspektif modern asuhan kebidanan pascapersalinan dengan dua pilar utama: dukungan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan pencegahan depresi postpartum. Disusun oleh para praktisi dan akademisi lintas disiplin, buku ini menghubungkan ilmu fisiologi, praktik klinis, pendekatan psikososial, serta kebijakan layanan primer sehingga bidan dan tenaga kesehatan memiliki panduan yang komprehensif, terukur, dan mudah diterapkan.

Bahasan mencakup fisiologi laktasi; inisiasi menyusui dini, perlekatan yang benar, manajemen masalah laktasi (bendungan, mastitis, galaktokel), hingga strategi dukungan keluarga, komunitas, dan tempat kerja yang ramah menyusui. Pada pilar kesehatan mental, buku ini mengulas spektrum adaptasi emosional ibu, faktor risiko dan protektif, penggunaan alat skrining yang tervalidasi (seperti Skala Depresi Postnatal Edinburgh), intervensi nonfarmakologis yang aman selama menyusui, serta tata laksana rujukan dan kolaborasi interprofesional. Setiap bab menonjolkan komunikasi yang sensitif budaya, pendekatan berpusat pada perempuan dan keluarga, pemanfaatan teknologi digital (telekonseling laktasi, pemantauan gejala), serta penguatan jejaring rujukan.

Diperkuat dengan studi kasus, algoritma asuhan, daftar tilik, dan lembar edukasi, buku ini ditujukan bagi bidan, perawat, mahasiswa, pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, dan pembuat kebijakan. Tujuannya jelas: meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif, menurunkan beban depresi postpartum, dan memastikan masa pascapersalinan yang sehat, aman, serta bermartabat bagi ibu dan bayinya.”

"Berbasis bukti terkini dan konteks layanan di Indonesia, bunga rampai ini merangkum perspektif modern asuhan kebidanan pascapersalinan dengan dua pilar utama: dukungan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan pencegahan depresi postpartum. Disusun oleh para praktisi dan akademisi lintas disiplin, buku ini menghubungkan ilmu fisiologi, praktik klinis, pendekatan psikososial, serta kebijakan layanan primer sehingga bidan dan tenaga kesehatan memiliki panduan yang komprehensif, terukur, dan mudah diterapkan.

Bahasan mencakup fisiologi laktasi; inisiasi menyusui dini, perlekatan yang benar, manajemen masalah laktasi (bendungan, mastitis, galaktokel), hingga strategi dukungan keluarga, komunitas, dan tempat kerja yang ramah menyusui. Pada pilar kesehatan mental, buku ini mengulas spektrum adaptasi emosional ibu, faktor risiko dan protektif, penggunaan alat skrining yang tervalidasi (seperti Skala Depresi Postnatal Edinburgh), intervensi nonfarmakologis yang aman selama menyusui, serta tata laksana rujukan dan kolaborasi interprofesional. Setiap bab menonjolkan komunikasi yang sensitif budaya, pendekatan berpusat pada perempuan dan keluarga, pemanfaatan teknologi digital (telekonseling laktasi, pemantauan gejala), serta penguatan jejaring rujukan.

Diperkuat dengan studi kasus, algoritma asuhan, daftar tilik, dan lembar edukasi, buku ini ditujukan bagi bidan, perawat, mahasiswa, pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, dan pembuat kebijakan. Tujuannya jelas: meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif, menurunkan beban depresi postpartum, dan memastikan masa pascapersalinan yang sehat, aman, serta bermartabat bagi ibu dan bayinya."

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



Optimal
Untuk
Negeri



optimal



IKAPI
IKATAN KEBIDANAN INDONESIA

ISBN 978-634-7426-10-9



9

786347

426109